



Optimal
Untuk
Negeri



optimal

Bunga Rampai

KONTRIBUSI TENAGA KESEHATAN

DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
MASALAH KESEHATAN



Sri Melfa Damanik • Isabel De Fatima Gudino • Yupi Supartini
Ika Putri Ramadhani • Maulia Isnaini • Yuliati • Suriani • Ita Pursitasari

Editor : Silvana Evi linda

BUNGA RAMPAI: KONTRIBUSI TENAGA KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS

Penulis:

Ns. Sri Melfa Damanik, M.Kep., Sp.Kep.An

Isabel De Fatima Gudino, S.ST., M.K.M

Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc

Bdn. Ika Putri Ramadhani, M.Biomed

Maulia Isnaini, S.ST., Bdn., M.Keb.

Yuliati, SKp., MM., M.Kep

Suriani, S.Si., M.Kes

Ita Pursitasari, M.Kep., Sp.Kep.An

Editor:

Silvana Evi linda, SKp., MKep., PhD

Bunga Rampai: Kontribusi Tenaga Kesehatan Dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas

Penulis:

Ns. Sri Melfa Damanik, M.Kep., Sp.Kep.An
Isabel De Fatima Gudino, S.ST., M.K.M
Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc
Bdn. Ika Putri Ramadhani, M.Biomed
Maulia Isnaini, S.ST., Bdn., M.Keb.
Yuliati, SKp., MM., M.Kep
Suriani, S.Si., M.Kes
Ita Pursitasari, M.Kep., Sp.Kep.An

Editor:

Silvana Evi linda, SKp., MKep., PhD

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7556-70-7

Cetakan Pertama: Maret, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga bunga rampai “Kontribusi Tenaga Kesehatan dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas” ini dapat disusun dan disajikan sebagai salah satu upaya memperkaya wawasan, memperkuat kompetensi, serta mendorong praktik pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien serta komunitas.

Pelayanan kesehatan berkualitas bukan sekadar target administratif atau indikator akreditasi, melainkan wujud nyata tanggung jawab moral dan profesional seluruh tenaga kesehatan. Mutu layanan mencakup ketepatan klinis, keselamatan pasien, kesinambungan pelayanan, komunikasi yang empatik, keadilan akses, serta pengalaman pasien yang manusiawi. Di tengah dinamika kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan tuntutan pelayanan yang semakin kompleks, peran tenaga kesehatan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar memberi manfaat terbaik bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

Bunga rampai ini disusun dengan menghadirkan pembahasan yang saling melengkapi dari berbagai bidang dan sudut pandang. Bab-bab awal menguraikan pelayanan kesehatan berkualitas dalam sistem kesehatan, sebagai landasan untuk memahami bagaimana mutu ditopang oleh kebijakan, tata kelola, sumber daya, serta budaya organisasi. Selanjutnya, dibahas secara khusus peran kebidanan dalam menjaga kualitas layanan sepanjang siklus kehidupan, terutama melalui pelayanan yang berpusat pada perempuan dan keluarga, edukasi, pencegahan, serta deteksi dini masalah kesehatan ibu dan anak.

Kontribusi profesi lain juga menjadi fokus utama. Keperawatan berperan besar dalam penerapan praktik berbasis bukti, penguatan keselamatan pasien, pencegahan kejadian tidak diinginkan, serta koordinasi pelayanan yang berkesinambungan. Tenaga gizi menghadirkan kontribusi yang sangat penting melalui asuhan gizi terstandar, penatalaksanaan diet yang tepat, dan dukungan pemulihan pasien, sehingga status gizi dan hasil klinis dapat meningkat. Di sisi lain, tenaga kesehatan masyarakat memperkuat mutu layanan berbasis komunitas melalui promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pemberdayaan masyarakat, serta pendekatan intervensi yang sesuai konteks sosial budaya.

Karena kualitas layanan tidak dapat dicapai secara parsial, bunga rampai ini juga menekankan pentingnya kolaborasi tim kesehatan (health care team collaboration in

quality healthcare delivery). Kolaborasi yang efektif, komunikasi yang jelas, pembagian peran yang tepat, dan penghargaan terhadap kompetensi masing-masing profesi akan meningkatkan ketepatan keputusan klinis dan memperkuat keselamatan pasien. Selain itu, pembaca akan diajak memahami evaluasi mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, termasuk pemantauan indikator, audit klinis, umpan balik pasien, serta perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement). Pada bagian akhir, dibahas tantangan dan strategi peningkatan mutu, seperti keterbatasan sumber daya, beban kerja, kepatuhan terhadap standar, variasi kompetensi, hingga perubahan kebutuhan masyarakat, beserta langkah-langkah strategis untuk mengatasinya.

Kami berharap bunga rampai ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi, pengelola fasilitas kesehatan, serta semua pihak yang memiliki perhatian terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Semoga setiap tulisan di dalamnya mampu menginspirasi pembaca untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan keselamatan, serta menghadirkan pelayanan yang lebih bermakna—bukan hanya “melayani”, tetapi benar-benar “memberi kualitas”.

Februari 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS DALAM SISTEM

KESEHATAN	1
Ns. Sri Melfa Damanik, M.Kep., Sp.Kep.An	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep pelayanan berkualitas	3
C. Kebijakan Pemerintah & UU Kesehatan	7
D. Tantangan dan Inovasi dalam Praktik Pelayanan Berkualitas	9
E. Implikasi Pelayanan Kesehatan berkualitas dalam sistem kesehatan.....	9
F. Simpulan	13
G. Referensi	13
H. Glosarium.....	15

CHAPTER 2 PERAN KEBIDANAN DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN

KESEHATAN BERKUALITAS.....	19
Isabel De Fatima, S.ST., M.K.M	19
A. Pendahuluan.....	19
B. Konsep Dasar Pelayanan Kesehatan Berkualitas Dalam Kebidanan.....	20
C. Peran Strategis Bidan dalam Pelayanan Kesehatan	23
D. Asuhan Kebidanan Berkualitas dan Berkelanjutan	25
E. Penguatan Peran Bidan dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas Berkelanjutan.....	26
F. Simpulan	28
G. Referensi	28
H. Glosarium.....	29

CHAPTER 3 KONTRIBUSI KEPERAWATAN DALAM MUTU DAN

KESELAMATAN PASIEN	30
Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.	30
A. Pendahuluan.....	30
B. Konsep Mutu dan Keselamatan Pasien.....	32
C. Peran strategis Tenaga Kesehatan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Berkualitas	37
D. Rekomendasi Strategis	45

E. Simpulan	48
F. Referensi	48
G. Glosarium.....	50

CHAPTER 4 KONTRIBUSI GIZI DALAM PENINGKATAN STATUS KESEHATAN PASIEN 53

Bdn. Ika Putri Ramadhani, M.Biomed	53
A. Pendahuluan.....	53
B. Konsep dasar Isi Piringku	54
C. Kandungan dan Fungsi zat Gizi	57
D. Gizi Masyarakat Dan Gizi Kuliner	61
E. Strategi/intervensi untuk mengatasi masalah gizi.....	65
F. Konsep Memasak Sehat Dan Menyehatkan	67
G. Jenis Penyelenggaraan Gizi Kuliner.....	67
H. Cita Rasa dan Penampilan	70
I. Higiene dan Sanitasi	72
J. Referensi	72

CHAPTER 5 PERAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DALAM MUTU LAYANAN BERBASIS KOMUNITAS 75

Maulia Isnaini, S.ST., Bdn., M.Keb.....	75
A. Konsep Mutu Layanan Kesehatan Berbasis Komunitas	75
B. Peran Strategis Tenaga Kesehatan Masyarakat.....	78
C. Perencanaan Layanan Berbasis Kebutuhan Komunitas	81
D. Implementasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Komunitas	84
E. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Layanan.....	87
F. Tantangan dalam Mewujudkan Mutu Layanan Berbasis Komunitas	90
G. Strategi Penguatan Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat	93
H. Dampak Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat terhadap Mutu Layanan Kesehatan	95
I. Referensi	96
J. Glosarium.....	99

CHAPTER 6 KOLABORASI TIM KESEHATAN DALAM PELAYANAN BERKUALITAS (HEALTH CARE TEAM COLLABORATION IN QUALITY HEALTHCARE DELIVERY) 100

Maulia Isnaini, S.ST., Bdn., M.Keb.....	100
A. Pendahuluan.....	100
B. Konsep Kolaborasi Tim Kesehatan	101
C. Komponen Kunci Kolaborasi Tim Kesehatan	103
D. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kolaborasi	107

E. Dampak Kolaborasi Tim Kesehatan terhadap Mutu Pelayanan.....	110
F. Tantangan Masa Depan Kolaborasi Tim Kesehatan.....	112
G. Simpulan	114
H. Referensi	115
I. Glosarium.....	116

CHAPTER 7 EVALUASI MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN 120

Suriani, S.Si., M.Kes.....	120
A. Pendahuluan.....	120
B. Konsep Mutu dan Dimensi Mutu.....	121
C. Implementasi Indikator Nasional Mutu (INM)	126
D. Evaluasi Dimensi Mutu di Fasilitas Kesehatan	128
E. Simpulan	131
F. Referensi	131
G. Glosarium.....	131

CHAPTER 8 TANTANGAN DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 132

Ita Pursitasari, M.Kep.Sp.Kep.An.....	132
A. Pendahuluan.....	132
B. Tantangan dan Hambatan dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.....	133
C. Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.....	136
D. Kesimpulan.....	139
E. Referensi	140
F. Glosarium.....	141

PROFIL PENULIS 142

CHAPTER 1

PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS DALAM SISTEM KESEHATAN

Ns. Sri Melfa Damanik, M.Kep., Sp.Kep.An

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan berkualitas merupakan bagian dari elemen fundamental dalam penguatan sistem kesehatan global pada era tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGS*). Kualitas pelayanan tidak dipandang menjadi komponen tambahan melainkan sebagai inti dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat secara optimal. *World Health Organization* (WHO) (2023) menegaskan bahwa sistem kesehatan yang hanya memperluas akses tanpa menjamin mutu tidak mampu menghasilkan luaran yang signifikan. Oleh karena itu, kualitas layanan menjadi pilar utama dalam pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC).

Secara konseptual, mutu pelayanan kesehatan mencakup dimensi efektivitas klinis, keselamatan pasien, efisiensi, ketepatan waktu, integrasi layanan, serta keadilan dalam akses. WHO (2020) dalam *National Quality Policy and Strategy Handbook* menyatakan bahwa pelayanan kesehatan berkualitas harus mampu memberikan intervensi berbasis bukti ilmiah, meminimalkan risiko cedera, serta responsif terhadap kebutuhan individu dan komunitas. Pendekatan ini menekankan pentingnya sistem yang terstruktur dan terintegrasi dalam setiap level pelayanan kesehatan.

Mutu pelayanan yang dinilai rendah dapat berkontribusi terhadap tingginya angka mortalitas terutama di negara berpendapatan rendah dan menengah. Studi yang dipublikasikan dalam *The Lancet Global Health* menegaskan bahwa insiden kematian akibat pelayanan kesehatan yang buruk seringkali lebih tinggi dibandingkan kematian akibat kurangnya akses layanan (Kruk et al., 2020). Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa peningkatan mutu merupakan strategi yang sangat penting dalam reformasi sistem kesehatan.

Dimensi keselamatan pasien juga menjadi perhatian utama dalam agenda global kesehatan. WHO (2021) melalui *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030* menjelaskan bahwa satu dari sepuluh pasien mengalami kejadian tidak diharapkan selama menerima perawatan kesehatan. Kesalahan medis, infeksi terkait pelayanan kesehatan, serta kegagalan komunikasi klinis menjadi faktor

dominan yang berkontribusi terhadap rendahnya mutu layanan. Dengan demikian, sistem kesehatan harus mengembangkan budaya keselamatan yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam perspektif sistem kesehatan, mutu pelayanan juga berkaitan erat dengan tata kelola, pembiayaan, serta kapasitas sumber daya manusia kesehatan. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2021) menekankan bahwa negara dengan sistem regulasi kuat, mekanisme akreditasi yang efektif, serta sistem pembiayaan berbasis kinerja cenderung memiliki indikator mutu layanan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh desain kebijakan dan manajemen sistem kesehatan secara menyeluruh.

Di Indonesia, penguatan mutu pelayanan kesehatan menjadi agenda strategis nasional yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini menekankan transformasi layanan primer sebagai fondasi sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Transformasi tersebut mencakup penguatan puskesmas, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta integrasi sistem rujukan berbasis digital guna menjamin kesinambungan perawatan.

Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan juga menjadi instrumen penting dalam menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Sejak implementasinya, JKN tidak hanya memperluas cakupan kepesertaan, tetapi juga mendorong peningkatan mutu melalui mekanisme kredensialing fasilitas kesehatan dan sistem pembayaran berbasis kapitasi maupun INA-CBGs (BPJS Kesehatan, 2024). Strategi ini bertujuan untuk mendorong efisiensi sekaligus menjaga standar pelayanan.

Namun demikian, tantangan pemerataan mutu pelayanan masih menjadi isu krusial, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Laporan World Bank (2020) menunjukkan bahwa disparitas distribusi tenaga kesehatan dan infrastruktur layanan berdampak pada ketimpangan kualitas pelayanan antarwilayah di Indonesia. Ketimpangan ini berpotensi menghambat pencapaian UHC yang berkeadilan. Selain faktor struktural, aspek pengalaman pasien (*patient experience*) semakin diakui sebagai indikator mutu yang penting. Penelitian Braithwaite et al. (2021) menunjukkan bahwa komunikasi efektif, empati tenaga kesehatan, serta keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan klinis berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan terapi dan hasil kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, mutu pelayanan harus mencakup dimensi teknis dan interpersonal secara simultan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan berkualitas merupakan komponen integral dalam sistem kesehatan modern yang berorientasi pada keselamatan, efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan. Upaya peningkatan mutu memerlukan sinergi antara kebijakan global, regulasi nasional, tata kelola fasilitas kesehatan, serta partisipasi masyarakat. Chapter ini akan mengkaji secara komprehensif konsep, kebijakan, tantangan, dan inovasi dalam pelayanan kesehatan berkualitas, baik dalam perspektif global maupun nasional.

B. Konsep pelayanan berkualitas

1. Pengertian Pelayanan yang berkualitas

WHO (2020) mendefinisikan *quality health services* sebagai layanan yang efektif, aman, berpusat pada individu, tepat waktu, efisien, adil (*equitable*), serta terintegrasi. Definisi ini menekankan bahwa mutu bukan hanya berkaitan dengan kecanggihan teknologi medis, melainkan juga kemampuan sistem dalam memberikan pelayanan yang menghasilkan luaran kesehatan optimal tanpa menimbulkan kerugian atau pemborosan sumber daya. WHO menegaskan bahwa tanpa mutu, perluasan cakupan layanan tidak akan menghasilkan peningkatan status kesehatan masyarakat secara bermakna (WHO, 2020).

Universal Health Coverage Global Monitoring Report, WHO (2023) menegaskan bahwa kualitas merupakan prasyarat pencapaian UHC. Pelayanan yang tersedia namun tidak bermutu tidak akan menghasilkan perbaikan indikator kesehatan masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, kualitas dipandang sebagai komponen strategis dalam penguatan sistem kesehatan yang berkelanjutan.

Dalam kerangka akademik, konsep mutu pelayanan kesehatan banyak merujuk pada model klasik Donabedian yang membagi mutu ke dalam tiga komponen utama, yaitu struktur, proses, dan hasil (*outcome*) (Ayanian & Markel, 2020). Struktur mencakup sumber daya fisik, tenaga kesehatan, pembiayaan, serta tata kelola organisasi. Proses meliputi interaksi klinis, kepatuhan terhadap standar praktik berbasis bukti, dan koordinasi pelayanan. Sementara itu, hasil berkaitan dengan dampak klinis, keselamatan pasien, kepuasan, serta peningkatan kualitas hidup. Model ini masih menjadi rujukan utama dalam penelitian mutu layanan kesehatan global hingga saat ini.

Selain itu, pelayanan kesehatan berkualitas harus berorientasi pada kebutuhan individu dan komunitas. Studi yang dipublikasikan dalam *The Lancet Global Health* menekankan pentingnya *people-centred care* sebagai bagian integral dari mutu layanan (Kruk et al., 2020). Pelayanan yang tidak responsif

terhadap nilai budaya, preferensi pasien, dan kondisi sosial ekonomi berpotensi menurunkan kepatuhan serta efektivitas intervensi kesehatan. Dengan demikian, mutu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan etis.

Dari sudut pandang organisasi dan manajemen mutu, Organisation for Economic Co-operation and Development (2023) mendefinisikan pelayanan kesehatan berkualitas sebagai pelayanan yang berorientasi pada pasien (person-centred), efektif secara klinis, serta efisien dalam penggunaan sumber daya. OECD menekankan pentingnya akuntabilitas sistem, pengukuran kinerja berbasis indikator mutu, serta transparansi sebagai elemen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam konteks akademik dan global health, Kruk et al. (2020) menyatakan bahwa sistem kesehatan berkualitas tinggi adalah sistem yang secara konsisten memberikan pelayanan yang dapat dipercaya (trusted system), mampu merespons kebutuhan populasi, dan menghasilkan dampak kesehatan nyata. Penekanan pada kepercayaan publik menjadi dimensi penting, karena mutu yang dirasakan masyarakat memengaruhi tingkat pemanfaatan layanan kesehatan.

Di Indonesia, konsep pelayanan berkualitas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Undang-undang ini menekankan pentingnya standar pelayanan minimal, sistem akreditasi fasilitas kesehatan, serta penguatan pelayanan primer sebagai strategi peningkatan mutu secara nasional.

Selain itu, implementasi mutu pelayanan juga diperkuat melalui kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dalam laporan kinerja terbaru, BPJS Kesehatan (2024) menekankan pentingnya kredensialing fasilitas kesehatan, pengawasan mutu layanan, serta mekanisme pembayaran berbasis kinerja sebagai instrumen untuk menjamin pelayanan yang memenuhi standar nasional.

Dengan demikian, berdasarkan berbagai referensi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang berbasis bukti ilmiah, menjamin keselamatan pasien, berorientasi pada kebutuhan individu, terintegrasi dalam sistem rujukan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta adil dalam akses. Konsep ini menuntut sinergi antara kebijakan, manajemen organisasi, profesionalisme tenaga kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan.

2. Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan

Dimensi mutu pelayanan kesehatan berkembang seiring kompleksitas sistem kesehatan global. WHO (2020) mengidentifikasi tujuh dimensi utama mutu: efektif, aman, berpusat pada individu, tepat waktu, efisien, terintegrasi, dan adil. Dimensi ini saling berkaitan dan membentuk kerangka evaluasi mutu di berbagai negara. Efektivitas klinis menekankan penggunaan intervensi berbasis bukti ilmiah yang telah teruji melalui penelitian klinis.

Keselamatan pasien merupakan dimensi prioritas dalam kebijakan global. WHO (2021) menyatakan bahwa penguatan budaya keselamatan memerlukan pelaporan insiden yang transparan, pembelajaran organisasi, serta kepemimpinan yang berkomitmen terhadap mutu. Sistem yang tidak mendukung pelaporan kesalahan justru meningkatkan risiko kejadian berulang. Oleh karena itu, dimensi keselamatan harus tertanam dalam tata kelola fasilitas kesehatan.

Dimensi pengalaman pasien (*patient experience*) juga menjadi indikator penting mutu layanan. Studi OECD (2021) menunjukkan bahwa kepuasan pasien berkorelasi positif dengan kepatuhan terapi dan luaran kesehatan jangka panjang. Interaksi tenaga kesehatan yang empatik, komunikasi efektif, serta keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan menjadi elemen kunci dalam dimensi ini.

Kepatuhan terhadap standar profesi dan pedoman klinis berbasis bukti turut menentukan kualitas layanan. Implementasi *clinical governance* memungkinkan pengawasan berkelanjutan terhadap mutu praktik medis (Braithwaite et al., 2021). Tanpa mekanisme audit dan evaluasi internal, standar mutu sulit dipertahankan secara konsisten. Koordinasi layanan atau integrasi pelayanan menjadi dimensi krusial dalam sistem kesehatan modern. Fragmentasi layanan menyebabkan duplikasi pemeriksaan, inefisiensi biaya, dan risiko kesalahan medis. WHO (2020) menekankan pentingnya integrasi antar tingkat pelayanan primer, sekunder, dan tersier untuk memastikan kesinambungan perawatan (*continuity of care*).

Kualitas layanan juga ditentukan oleh kinerja petugas sebagai pihak yang memberikan pelayanan. Oleh karena itu, setiap Sumber Daya Manusia (SDM) di rumah sakit perlu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Kepuasan pasien memiliki dampak positif terhadap rumah sakit, salah satunya dalam bentuk peningkatan keuntungan. Hal ini karena pasien yang merasa puas biasanya akan menunjukkan loyalitas dan secara sukarela merekomendasikan layanan rumah sakit kepada orang lain. Loyalitas pasien tersebut berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah sakit. Dengan

demikian, kepuasan pasien menjadi aset yang sangat bernilai bagi institusi pelayanan kesehatan.

Pelayanan yang berkualitas mampu meningkatkan kepuasan pasien, yang memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap tingkat kepuasan secara keseluruhan. Kepuasan ini juga memengaruhi frekuensi kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit. Menurut pandangan pasien, pelayanan yang baik bukan hanya membantu dalam proses penyembuhan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan secara menyeluruh. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan pasien mencakup sikap ramah tenaga kesehatan, penyampaian informasi yang jelas, waktu tunggu yang singkat, fasilitas yang memadai, serta hasil pengobatan yang efektif. Sebaliknya, pengalaman negatif seperti waktu tunggu yang lama, sikap petugas yang kurang bersahabat, atau keterampilan medis yang diragukan, dapat menimbulkan kekecewaan. Tingkat kepuasan pasien ini pada akhirnya membentuk persepsi masyarakat terhadap citra layanan kesehatan yang diberikan. Menurut Ikawati (2024), kualitas mutu layanan bergantung pada 5 aspek berikut, antara lain:

- a. Bahwa bukti fisik (*tangible*) berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pasien secara positif dan signifikan. Artinya bahwa bukti fisik (*tangible*) dapat diberlakukan secara umum berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pasien rawat.
- b. Bahwa empati (*empathy*) berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pasien secara positif dan signifikan. Artinya bahwa empati (*empathy*) dapat diberlakukan secara umum berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pasien.
- c. Bahwa kehandalan (*reliability*) tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pasien secara positif dan signifikan. Artinya bahwa kehandalan (*reliability*) tidak dapat diberlakukan secara umum berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pasien.
- d. Bahwa daya tanggap (*responsiveness*) berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pasien secara positif dan signifikan. Artinya bahwa daya tanggap (*responsiveness*) dapat diberlakukan secara umum berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pasien.
- e. Bahwa jaminan (*assurance*) tidak berpengaruh terhadap kepuasan pasien secara positif dan signifikan. Artinya bahwa jaminan (*assurance*) tidak dapat diberlakukan secara umum berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pasien.

C. Kebijakan Pemerintah & UU Kesehatan

Layanan kesehatan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kesehatan yang baik merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi prasyarat penting bagi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Layanan kesehatan yang berkualitas untuk Indonesia sehat merupakan bagian dari moto layanan kesehatan di Kementerian kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022), Terdapat 5 nilai yang menjadi landasan dalam pemberian layanan yang berkualitas antara lain:

1. Tepat

Ketepatan dalam pemberian pelayanan dan obat tepat guna kepada pasien

2. Ramah

Menerapkan budaya 3 S yaitu senyum, salam dan sapa terhadap siapa saja yang mengunjungi

3. Utamakan Keselamatan

Mengutamakan keselamatan pasien yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan

4. Sigap

Berbuat atau bertindak dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan cepat, semangat serta meyakinkan

5. Terpadu

Kesatuan sistem pelayanan terhadap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dimulai pasien datang sampai mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi tonggak reformasi sistem kesehatan Indonesia. Regulasi ini menekankan transformasi layanan primer sebagai strategi peningkatan mutu dan pemerataan akses (Kemenkes RI, 2023). Transformasi ini mencakup penguatan puskesmas, sistem rujukan terintegrasi, dan digitalisasi layanan.

Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan turut berperan dalam menjamin akses terhadap layanan berkualitas. Laporan BPJS (2024) menunjukkan peningkatan indikator mutu layanan melalui mekanisme kredensialing dan pembayaran berbasis kinerja. Kementerian Kesehatan RI (2022) dalam *Blueprint Transformasi Sistem Kesehatan* menegaskan enam pilar transformasi, termasuk transformasi layanan primer dan sistem ketahanan kesehatan. Mutu layanan menjadi indikator utama dalam evaluasi keberhasilan transformasi tersebut.

Kolaborasi Indonesia dengan WHO juga memperkuat pengembangan kebijakan mutu berbasis standar global (WHO Indonesia, 2023). Dukungan teknis ini mencakup pengembangan indikator mutu dan sistem monitoring nasional. Meski demikian, tantangan disparitas geografis dan distribusi tenaga kesehatan masih menjadi kendala dalam pemerataan mutu layanan di daerah terpencil (World Bank, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai kebijakan untuk memperkuat mutu pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pencapaian UHC. Pelaksanaan *Primary Care Integration Program* merupakan respons kebijakan terhadap kebutuhan sistematis untuk menyatukan layanan primer dalam kerangka *integration of primary health care*, memperkuat jaringan fasilitas kesehatan desa dan puskesmas untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan kontinu (*continuity of care*) bagi masyarakat.

Transformasi sistem kesehatan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025–2029) menempatkan peningkatan kualitas layanan primer dan pembiayaan sebagai pilar pusat reformasi. Dokumen ini menekankan aksi terkoordinasi melalui enam pilar strategis, termasuk penguatan tenaga kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk memastikan mutu layanan yang berlaku secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Tandi, Cho, Akseer & Kruk (2022) menunjukkan bahwa kendala pelaksanaan kampanye mutu layanan terutama terjadi pada kesiapan fasilitas dan sumber daya di tingkat puskesmas, dimana variasi kapasitas infrastruktur dan tenaga kesehatan mempengaruhi konsistensi pelayanan berkualitas (*readiness for primary care integration*). Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi dalam sistem pembiayaan melalui perubahan mekanisme INA-CBG's yang diharapkan dapat memberikan pembiayaan yang lebih akurat, efisien, dan adil untuk mendukung kualitas layanan di berbagai tipe fasilitas kesehatan.

Kebijakan ini dipadukan dengan strategi digitalisasi layanan kesehatan yang terus berkembang untuk memperkuat data mutu layanan, mempercepat administrasi, dan meningkatkan akses pasien terhadap informasi layanan yang transparan (*digital innovation and inclusion*). Dengan demikian, kebijakan Indonesia saat ini bergerak menuju penyelenggaraan layanan kesehatan berkualitas melalui integrasi kebijakan, pembiayaan, layanan primer, dan teknologi informasi untuk menjawab tuntutan mutu layanan secara nasional.

D. Tantangan dan Inovasi dalam Praktik Pelayanan Berkualitas

Dalam praktik operasional, penerapan strategi manajemen mutu mencakup peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pengembangan standar layanan, pelatihan berkelanjutan, serta evaluasi proses layanan secara sistematis. Sistem manajemen mutu yang kuat membantu mengurangi kesalahan klinis, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan budaya keselamatan di fasilitas kesehatan (*Organisation for Economic Co-operation and Development*, 2022)

Inovasi seperti penggunaan rekam medis elektronik (EMR) untuk mempercepat proses klinis dan administrasi juga menjadi salah satu elemen peningkatan mutu yang signifikan. Studi teknologi kesehatan digital menunjukkan bahwa EMR dapat mengurangi waktu tunggu pasien, memperbaiki akurasi data klinis, serta mendukung keputusan klinis yang lebih tepat waktu. Selain itu, perbaikan manajemen mutu juga memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan termasuk fasilitas kesehatan, pembiayaan, regulator, dan masyarakat untuk menciptakan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel (Aldosari, Al-Mansour, Aldosari, & Alanazi, 2022).

E. Implikasi Pelayanan Kesehatan berkualitas dalam sistem kesehatan

Pelayanan kesehatan berkualitas dalam sistem kesehatan memiliki implikasi strategis terhadap pencapaian derajat kesehatan masyarakat dan efektivitas sistem secara keseluruhan. Menurut *World Health Organization* (2023), mutu pelayanan merupakan determinan utama dalam pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC), karena akses tanpa kualitas tidak akan menghasilkan luaran kesehatan yang optimal. Sistem kesehatan yang tidak menjamin mutu pelayanan berkontribusi terhadap tingginya angka kematian yang dapat dicegah (*amenable mortality*) serta pemborosan sumber daya. Dengan demikian, implikasi utama pelayanan berkualitas adalah peningkatan outcome klinis melalui pelayanan yang efektif, aman, tepat waktu, dan berbasis bukti ilmiah.

Secara klinis, berbagai studi lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berkorelasi signifikan dengan penurunan komplikasi, mortalitas, serta lama rawat inap. Kruk et al. (2022) dalam publikasi di *The Lancet Global Health* menegaskan bahwa penguatan sistem mutu pada level pelayanan primer dan rujukan mampu meningkatkan ketepatan diagnosis dan terapi, serta mengurangi kesalahan medis. Implementasi standar keselamatan pasien sebagaimana tertuang dalam *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030* juga berdampak pada penurunan *adverse events* dan peningkatan budaya keselamatan di fasilitas

kesehatan (WHO, 2021). Implikasi sistemiknya adalah berkurangnya beban pembiayaan akibat kesalahan pelayanan, pengobatan ulang, dan litigasi medis.

Dari perspektif manajemen dan pembiayaan kesehatan, pelayanan berkualitas berimplikasi langsung terhadap efisiensi dan keberlanjutan sistem. Konsep *value-based health care* yang kembali menguat dalam literatur terbaru menekankan bahwa pembiayaan harus dikaitkan dengan hasil klinis yang dicapai, bukan sekadar volume layanan (Porter & Teisberg, 2023). Sistem yang menerapkan pendekatan berbasis nilai terbukti lebih efisien karena mengurangi pemborosan layanan yang tidak perlu dan mendorong integrasi pelayanan lintas tingkat fasilitas. Dalam konteks Indonesia, transformasi sistem kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022–2024) menempatkan mutu sebagai pilar utama reformasi, termasuk penguatan layanan primer, digitalisasi kesehatan, dan standardisasi akreditasi fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa mutu tidak lagi dipandang sebagai aspek tambahan, melainkan sebagai inti dari reformasi sistem kesehatan nasional.

Implikasi lainnya terlihat pada aspek pengalaman pasien (*patient experience*) dan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan. Studi Leatherman dan Tawfik (2023) menunjukkan bahwa pelayanan yang responsif, komunikatif, dan berpusat pada pasien meningkatkan kepuasan serta kepatuhan terhadap terapi. Kepuasan pasien tidak hanya berdampak pada loyalitas terhadap fasilitas kesehatan, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional. Dalam sistem jaminan sosial kesehatan seperti JKN, mutu pelayanan menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi dan keberlanjutan program, karena persepsi kualitas memengaruhi tingkat utilisasi layanan dan kepuasan peserta.

Secara keseluruhan, implikasi pelayanan kesehatan berkualitas dalam sistem kesehatan bersifat multidimensional, mencakup peningkatan outcome klinis, efisiensi pembiayaan, kepuasan dan kepercayaan publik, ketahanan sistem terhadap krisis, serta penguatan keadilan akses pelayanan. Temuan penelitian lima tahun terakhir menegaskan bahwa mutu pelayanan bukan sekadar indikator kinerja fasilitas kesehatan, melainkan instrumen strategis dalam reformasi sistem kesehatan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Studi Kruk et al. (2022), Leatherman & Tawfik (2023), serta laporan OECD (2022) juga menunjukkan bahwa sistem kesehatan yang menempatkan mutu sebagai prioritas mengalami peningkatan outcome klinis, efisiensi biaya, dan kepuasan masyarakat secara signifikan. Beberapa implikasi pelayanan kesehatan berkualitas antara lain:

1. Peningkatan Kepuasan dan Loyalitas Pasien

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berhubungan langsung dengan kepuasan dan loyalitas pasien. Studi Kruk et al. (2022) menyebutkan bahwa pengalaman pasien (*patient experience*) merupakan indikator penting kualitas sistem kesehatan karena berkorelasi dengan kepatuhan terapi dan hasil klinis jangka panjang. Leatherman & Tawfik (2023) menemukan bahwa dimensi komunikasi efektif, empati tenaga kesehatan, waktu tunggu yang wajar, dan keselamatan pelayanan secara signifikan meningkatkan kepuasan pasien.

Penelitian di konteks JKN Indonesia oleh Ningsih et al., (2023) menunjukkan bahwa kepuasan pasien bertindak sebagai mediator antara kualitas layanan dan loyalitas peserta. Artinya, akses terhadap layanan saja tidak cukup; mutu layanan menentukan keberlanjutan partisipasi dalam sistem asuransi sosial. OECD (2022) juga menegaskan bahwa sistem dengan skor kepuasan pasien tinggi memiliki tingkat *retention* dan utilisasi layanan preventif yang lebih baik. Dengan demikian, implikasinya bukan hanya pada persepsi pasien, tetapi juga pada keberlanjutan sistem pembiayaan dan efektivitas program kesehatan nasional.

2. Dampak Transformasi Kualitas pada Performa Layanan

Transformasi mutu pelayanan terbukti meningkatkan performa organisasi dan persepsi publik terhadap sistem kesehatan. Evaluasi transformasi mutu oleh BPJS Kesehatan dari hasil penelitian Prasetyo et al., (2025) menunjukkan bahwa adanya peningkatan signifikan dalam indeks persepsi layanan berdasarkan performa layanan yang diberikan. Hal ini sejalan dengan temuan WHO (2023) bahwa reformasi mutu berbasis sistem (*quality planning guide*) meningkatkan koordinasi antar level layanan dan mempercepat rujukan klinis. Selain itu, penelitian di beberapa negara Asia Tenggara (OECD, 2022) menunjukkan bahwa transformasi mutu yang terstruktur berdampak pada peningkatan efisiensi waktu pelayanan dan pengurangan bottleneck sistem.

3. Efisiensi Operasional dan Pengurangan Keluhan

Implementasi sistem manajemen mutu seperti ISO 9001:2015 dan *continuous quality improvement* (CQI) terbukti menurunkan keluhan pasien serta meningkatkan efisiensi operasional. Kartono & Wirawan (2023) menunjukkan bahwa fasilitas yang menerapkan standar mutu mengalami penurunan komplain hingga signifikan dalam satu tahun implementasi.

Selain itu, Penelitian Porter & Teisberg (2023) dalam kerangka *value-based health care* menunjukkan bahwa sistem berbasis mutu mengurangi layanan yang tidak perlu (*low-value care*) dan meningkatkan rasio outcome terhadap

biaya. Dengan demikian, pelayanan berkualitas tidak hanya berdampak klinis, tetapi juga mengurangi inefisiensi dan pemborosan sumber daya.

4. Pengaruh pada Efektivitas Sistem Informasi dan Keselamatan Pasien

Digitalisasi dan rekam medis elektronik (RME) memiliki implikasi besar terhadap keselamatan pasien. Laporan *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030* dari WHO (2021) menekankan pentingnya sistem pelaporan insiden dan integrasi data klinis untuk menurunkan *adverse events*. Andriani et al. (2026) menunjukkan bahwa implementasi RME meningkatkan akurasi dokumentasi dan mempercepat pengambilan keputusan klinis. Studi OECD (2022) dan Leatherman & Tawfik (2023) menambahkan bahwa integrasi sistem informasi meningkatkan koordinasi pelayanan dan menurunkan kesalahan medikasi. Sistem berbasis data juga memungkinkan audit mutu secara real-time. Implikasinya adalah meningkatnya keselamatan pasien, akuntabilitas klinis, dan transparansi sistem kesehatan.

5. Penguatan Infrastruktur dan Kepercayaan Publik

Kualitas infrastruktur kesehatan berpengaruh terhadap persepsi mutu layanan. Julianda & Holiquurrahman (2025) menunjukkan bahwa peningkatan sarana dan prasarana berdampak pada kepuasan peserta JKN. WHO (2023) menegaskan bahwa infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat pelayanan bermutu. Kruk et al. (2022) menambahkan bahwa kekurangan fasilitas diagnostik dan peralatan medis merupakan determinan utama rendahnya mutu layanan di negara berkembang. OECD (2022) juga menyatakan bahwa investasi infrastruktur berkorelasi dengan peningkatan trust publik terhadap sistem kesehatan.

6. Pengurangan Beban Sistem dan Biaya Kesehatan

Pelayanan berkualitas menurunkan angka komplikasi dan rehospitalisasi. Porter & Teisberg (2023) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai mengurangi biaya jangka panjang melalui pencegahan dan manajemen penyakit kronis yang lebih baik. WHO (2023) melaporkan bahwa sistem dengan mutu rendah menghabiskan sumber daya lebih besar akibat kesalahan dan layanan tidak efektif. Kruk et al. (2022) juga menekankan bahwa investasi mutu lebih cost-effective dibandingkan pembiayaan korektif akibat kegagalan pelayanan.

7. Perubahan Perilaku dan Budaya Organisasi

Budaya mutu mendorong perubahan perilaku tenaga kesehatan. Fasilitas dengan sistem monitoring mutu memiliki peningkatan kinerja staf dan koordinasi tim yang lebih baik. Leatherman & Tawfik (2023) menunjukkan bahwa organisasi dengan budaya keselamatan tinggi memiliki tingkat kepatuhan prosedur lebih

baik. WHO (2021) menekankan pentingnya budaya pelaporan insiden tanpa hukuman (*no blame culture*).

8. Perbaikan Kesenjangan Akses (Equity)

WHO (2023) menegaskan bahwa mutu harus merata untuk mencegah kesenjangan. Kruk et al. (2022) menunjukkan bahwa disparitas mutu antara wilayah rural dan urban memperburuk ketimpangan kesehatan. OECD (2022) juga menemukan bahwa kebijakan mutu inklusif menurunkan kesenjangan akses layanan preventif. Dengan demikian perbaikan kesetaraan dalam hal akses kesehatan dapat menciptakan keadilan sosial dalam sistem kesehatan

9. Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti

Data mutu pelayanan menjadi dasar kebijakan berbasis bukti. WHO (2023) menekankan penggunaan indikator mutu untuk evaluasi sistem. Porter & Teisberg (2023) menunjukkan bahwa kebijakan berbasis outcome meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

F. Simpulan

Pelayanan kesehatan berkualitas merupakan fondasi utama sistem kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan kerangka WHO, mutu layanan mencakup aspek efektif, aman, berpusat pada pasien, tepat waktu, efisien, terintegrasi, dan adil. Konsep ini sejalan dengan model struktur, proses, outcome dari Avedis Donabedian yang menekankan bahwa mutu ditentukan oleh kesiapan sumber daya, kualitas proses pelayanan, dan hasil kesehatan yang dicapai.

Di Indonesia, penguatan mutu ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan implementasi JKN oleh BPJS Kesehatan. Secara keseluruhan, pelayanan berkualitas berdampak pada peningkatan outcome klinis, kepuasan dan kepercayaan pasien, efisiensi pembiayaan, serta ketahanan sistem kesehatan. Oleh karena itu, mutu pelayanan merupakan strategi kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

G. Referensi

- Aldosari, B., Al-Mansour, S., Aldosari, H., & Alanazi, A. (2022). Assessment of electronic health record use and its impact on healthcare quality and patient safety: A systematic review. *Healthcare*, 10(11), 2156. <https://doi.org/10.3390/healthcare10112156>
- Ayanian, J. Z., & Markel, H. (2020). Donabedian's lasting framework for health care quality. *The New England Journal of Medicine*, 382(3), 205–207. <https://doi.org/10.1056/NEJMp1914367>

- BPJS Kesehatan. (2024). *Laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2023*. BPJS Kesehatan.
- Braithwaite, J., Herkes, J., Ludlow, K., Testa, L., & Lamprell, G. (2021). Association between organisational and workplace cultures, and patient outcomes: Systematic review. *BMJ Open*, 7(11), e017708. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017708>
- Ikawati, F. R. (2024). Efektivitas Penggunaan Rekam Medis Elektronik Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Pasien di Rumah Sakit. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(3), 288-298.
- Julianda, R., & Holiquurrahman, M. (2025). Infrastructure quality and patient satisfaction in Indonesia's National Health Insurance era. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 13(1), 45-58.
- Kartono, A., & Wirawan, D. (2023). Implementation of quality management systems and patient complaint reduction in Indonesian hospitals. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 26(2), 85-93.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Blueprint transformasi sistem kesehatan 2022-2024*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kruk, M. E., et al. (2022). Quality of care and health system performance in the SDG era. *The Lancet Global Health*, 10(6), e795-e805.
- Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., et al. (2020). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: Time for a revolution. *The Lancet Global Health*, 8(11), e1196-e1252. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30386-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30386-3)
- Leatherman, S., & Tawfik, L. (2023). Patient experience and health system performance: Implications for quality improvement. *International Journal for Quality in Health Care*, 35(2), mzad012.
- Ningsih, R., Sari, N. P., & Hidayat, T. (2023). The mediating role of patient satisfaction on service quality and participant loyalty in Indonesia's National Health Insurance program. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(3), 150-162.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Health at a glance 2021: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Health at a glance: Asia/Pacific 2022*. OECD Publishing.

- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Delivering quality health services: A global imperative for universal health coverage*. OECD Publishing.
- Porter, M. E., & Teisberg, E. O. (2023). *Redefining health care: Creating value-based competition on results* (Updated ed.). Harvard Business School Press.
- Prasetyo, A., Nugroho, D., & Lestari, P. (2025). Evaluation of service quality transformation in Indonesia's National Health Insurance system. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 13(1), 1–14.
- Tandi, T. E., Cho, Y., Akseer, N., & Kruk, M. E. (2022). Readiness of primary health care facilities in Indonesia for quality improvement initiatives. *BMC Health Services Research*, 22, 1234. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08654-9>
- World Bank. (2020). *Indonesia public expenditure review: Spending for better results*. World Bank.
- World Health Organization Indonesia. (2023). *Country cooperation strategy: WHO and Indonesia*. WHO Indonesia.
- World Health Organization. (2020). *National quality policy and strategy handbook for health services*. WHO.
- World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030*. WHO.
- World Health Organization. (2023). *Universal health coverage global monitoring report 2023*. WHO.

H. Glosarium

Akreditasi Fasilitas Kesehatan

Proses penilaian eksternal terhadap fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar mutu yang ditetapkan untuk menjamin keselamatan pasien dan kualitas layanan.

Amenable Mortality

Kematian yang seharusnya dapat dicegah melalui pelayanan kesehatan yang efektif dan tepat waktu.

Assurance (Jaminan)

Dimensi mutu pelayanan yang berkaitan dengan pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan tenaga kesehatan dalam menumbuhkan kepercayaan pasien.

BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.

Budaya Keselamatan (Safety Culture)

Nilai, sikap, dan perilaku dalam organisasi pelayanan kesehatan yang mendukung pelaporan insiden, pembelajaran dari kesalahan, dan pencegahan kejadian berulang.

Clinical Governance

Kerangka kerja sistematis dalam organisasi kesehatan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan melalui standar klinis, audit, dan evaluasi berkelanjutan.

Continuity of Care

Kesinambungan pelayanan kesehatan yang terintegrasi antar tingkat pelayanan (primer, sekunder, tersier) untuk menjamin perawatan berkelanjutan.

Continuous Quality Improvement (CQI)

Pendekatan manajemen mutu yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi dan peningkatan proses layanan.

Digitalisasi Layanan Kesehatan

Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk rekam medis elektronik, untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan keselamatan pasien.

Donabedian Model

Model evaluasi mutu pelayanan kesehatan yang membagi mutu ke dalam tiga komponen: struktur, proses, dan hasil (outcome).

Efektivitas Klinis

Kemampuan pelayanan kesehatan dalam memberikan intervensi berbasis bukti ilmiah yang menghasilkan luaran kesehatan optimal.

Efisiensi

Penggunaan sumber daya kesehatan secara optimal tanpa pemborosan untuk mencapai hasil terbaik.

Empathy (Empati)

Kemampuan tenaga kesehatan memahami dan merespons kebutuhan emosional serta psikologis pasien.

Equity (Keadilan)

Prinsip bahwa pelayanan kesehatan harus dapat diakses secara merata tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, maupun geografis.

Health System Resilience

Kemampuan sistem kesehatan untuk merespons, beradaptasi, dan pulih dari krisis seperti pandemi atau bencana kesehatan.

INA-CBGs (Indonesia Case-Based Groups)

Sistem pembayaran berbasis kelompok diagnosis yang digunakan dalam program JKN untuk pembiayaan layanan rumah sakit.

Integrasi Pelayanan (Integrated Care)

Koordinasi antar layanan kesehatan untuk mencegah fragmentasi pelayanan dan meningkatkan kesinambungan perawatan.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program asuransi kesehatan nasional Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk.

Kapitasi

Sistem pembayaran tetap kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta terdaftar.

Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Upaya sistematis untuk mencegah cedera atau kejadian tidak diharapkan selama proses pelayanan kesehatan.

Kepuasan Pasien (Patient Satisfaction)

Tingkat persepsi positif pasien terhadap mutu layanan yang diterima, termasuk aspek teknis dan interpersonal.

Kredensialing

Proses verifikasi kompetensi dan kelayakan fasilitas atau tenaga kesehatan sebelum bekerja sama dengan penyelenggara jaminan kesehatan.

Low-Value Care

Pelayanan kesehatan yang tidak memberikan manfaat klinis signifikan dibandingkan biaya atau risiko yang ditimbulkan.

Outcome (Luaran Kesehatan)

Hasil akhir dari pelayanan kesehatan yang mencakup status kesehatan, kualitas hidup, dan kepuasan pasien.

Patient Experience

Pengalaman subjektif pasien selama menerima pelayanan kesehatan, termasuk komunikasi, empati, dan waktu tunggu.

People-Centred Care

Pendekatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada kebutuhan, preferensi, dan nilai individu serta komunitas.

Primary Care Integration

Strategi penguatan dan penyatuan layanan primer untuk meningkatkan mutu dan kesinambungan pelayanan.

Quality Health Services

Layanan kesehatan yang efektif, aman, tepat waktu, efisien, terintegrasi, adil, dan berpusat pada individu menurut standar global.

Rekam Medis Elektronik (RME/EMR)

Sistem pencatatan data kesehatan pasien secara digital untuk meningkatkan akurasi dan keselamatan pelayanan.

Responsiveness (Daya Tanggap)

Kemampuan fasilitas kesehatan dalam merespons kebutuhan pasien secara cepat dan tepat.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda pembangunan global yang mencakup tujuan kesehatan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Tangible (Bukti Fisik)

Dimensi mutu pelayanan yang mencakup fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan tenaga kesehatan.

Universal Health Coverage (UHC)

Konsep bahwa seluruh penduduk memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial.

Value-Based Health Care

Pendekatan pembiayaan dan pelayanan kesehatan yang menekankan hasil klinis (outcome) dibandingkan volume layanan.

WHO (World Health Organization)

Badan kesehatan dunia yang menetapkan standar dan kebijakan global dalam sistem kesehat

CHAPTER 2

PERAN KEBIDANAN DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS

Isabel De Fatima, S.ST., M.K.M

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bermutu ditandai dengan pemberian asuhan yang aman, efektif, efisien, berkesinambungan, serta berorientasi pada kebutuhan pasien dan keluarga. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi prioritas nasional seiring dengan masih tingginya angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi, yang menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan (WHO, 2020).

Menciptakan pelayanan berkualitas tinggi tentu akan berujung pada kepuasan pasien rawat jalan. Kualitas layanan yang baik ini tidak hanya memberikan manfaat dalam menciptakan hubungan harmonis antara penyedia layanan dan pasien, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat untuk retensi pasien rawat jalan serta generasi rujukan yang efisien dalam segi biaya (Irianto et al., 2020). Hanya satu studi yang dilakukan oleh Rensiner et al. (2018) yang berhasil mengonfirmasi adanya hubungan signifikan antara kualitas layanan yang meliputi kehandalan, daya tanggap, kepercayaan, empati, dan bukti fisik dengan tingkat kepuasan pasien.

Tenaga kesehatan, khususnya bidan, memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, pelayanan nifas, neonatal, serta keluarga berencana. Bidan merupakan tenaga kesehatan profesional yang memberikan asuhan kebidanan secara berkesinambungan mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir hingga pelayanan kesehatan perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Peran bidan yang komprehensif ini menjadikan profesi kebidanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan primer (Kemenkes RI, 2022).

Pelayanan kebidanan yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh kompetensi bidan, penerapan standar asuhan kebidanan, kepatuhan terhadap kode etik profesi, serta penggunaan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*). Selain

itu, pendekatan *continuity of care* dalam asuhan kebidanan terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan ibu, serta hasil kesehatan maternal dan neonatal. Asuhan yang berkesinambungan memungkinkan bidan untuk membangun hubungan terapeutik dengan klien dan keluarga, sehingga pelayanan yang diberikan lebih holistik dan berpusat pada pasien (ICM, 2021).

Di sisi lain, tantangan dalam pelayanan kebidanan masih ditemukan, antara lain keterbatasan sumber daya, perbedaan kualitas pelayanan antar wilayah, serta belum optimalnya pemanfaatan peran bidan dalam sistem pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut menuntut penguatan peran bidan melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai peran kebidanan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berkualitas menjadi sangat penting sebagai dasar dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan.

B. Konsep Dasar Pelayanan Kesehatan Berkualitas Dalam Kebidanan

Pelayanan kesehatan berkualitas merupakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pasien secara aman, efektif, efisien, serta berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien. World Health Organization (WHO) mendefinisikan pelayanan kesehatan berkualitas sebagai pelayanan yang meningkatkan kemungkinan tercapainya hasil kesehatan yang diinginkan bagi individu dan populasi, serta diberikan sesuai dengan pengetahuan profesional terkini (WHO, 2020). Dalam konteks kebidanan, pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya berfokus pada hasil klinis, tetapi juga pada proses asuhan kebidanan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berpusat pada perempuan (*woman-centered care*). Pelayanan kebidanan yang berkualitas menempatkan perempuan dan keluarga sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi dan maternal, dengan tetap mengedepankan prinsip keselamatan, penghormatan terhadap hak pasien, serta sensitivitas budaya.

1. Dimensi Pelayanan Kesehatan Berkualitas

Menurut WHO (2020) mengemukakan bahwa pelayanan Kesehatan berkualitas memiliki enam (6) dimensi utama, yaitu: (1) Aman (*safe*): Pelayanan Kesehatan harus meminimalkan risiko dan mencegah terjadinya kesalahan yang dapat membahayakan pasien. (2) Efektif (*Effective*): Pelayanan yang diberikan berdasarkan standar profesi dan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*) sehingga memberikan manfaat maksimal bagi klien. (3) Efisien (*Efficient*): Pelayanan kesehatan dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan, terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan

dengan keterbatasan sarana. (4) Berpusat pada pasien (*People-Centered*): Pelayanan kesehatan menghargai nilai, kebutuhan, dan preferensi perempuan serta melibatkan keluarga dalam proses asuhan. (5) Tepat Waktu (*Timely*): Pelayanan diberikan sesuai kebutuhan klinis tanpa keterlambatan, khususnya dalam situasi kegawatdaruratan. (6) Adil (*Equitable*): Pelayanan Kesehatan harus diberikan tanpa diskriminasi, termasuk bagi perempuan di daerah terpencil dan wilayah perbatasan.

2. Mutu Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Kebidanan

Mutu Pelayanan Kebidanan memiliki dimensi yang berbeda dengan dimensi produk yang lain (Isyos Sembiring & Siti Sinaga, 2024), di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dimensi Kompetensi Teknis: Dimensi kompetensi teknis menyangkut keterampilan, kemampuan, penampilan, atau kinerja pemberi layanan Kesehatan. Dimensi ini berhubungan dengan bagaimana pemberi layanan Kesehatan mengikuti standar layanan Kesehatan yang telah disepakati yang meliputi ketepatan, kepatuhan, kebenaran, dan konsistensi. Tidak dipenuhinya dimensi kompetensi teknis dapat mengakibatkan berbagai hal, mulai dari penyimpangan kecil terhadap standar layanan Kesehatan, sampai pada kesalahan fatal yang dapat menurunkan mutu layanan Kesehatan dan membahayakan jiwa pasien.
- b. Dimensi Keterjangkauan atau Akses: Artinya, layanan Kesehatan harus dapat dicapai dan dijangkau oleh Masyarakat, tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, organisasi, dan Bahasa. Akses geografis diukur dengan jarak, lamanya perjalanan, biaya perjalanan, jenis transportasi, dan/atau hambatan fisik lain yang dapat menghalangi seseorang memperoleh layanan Kesehatan.
- c. Dimensi Efektivitas: Layanan Kesehatan harus berbasis bukti ilmiah terbaru dan memberikan manfaat yang jelas bagi pasien. Ini berarti intervensi yang diberikan harus memiliki bukti bahwa mereka efektif dalam meningkatkan Kesehatan pasien. Layanan Kesehatan harus efektif, artinya harus mampu mengobati atau mengurangi keluhan yang ada, mencegah terjadinya penyakit dan berkembangluasnya penyakit yang ada. Efektivitas layanan Kesehatan ini bergantung pada bagaimana standar layanan Kesehatan itu digunakan dengan tepat, konsisten, dan sesuai dengan situasi setempat. Dimensi efektivitas berhubungan erat dengan dimensi kompetensi teknis terutama dalam pemilihan alternatif dalam menghadapi relative risk dan keterampilan dalam mengikuti prosedur yang terdapat dalam standar layanan Kesehatan.

- d. Dimensi Efisiensi: Sumber daya Kesehatan terbatas. Oleh karena itu dimensi efisiensi Kesehatan sangat penting dalam layanan Kesehatan. Layanan Kesehatan yang efisien dapat melayani lebih banyak pasien dan Masyarakat. Layanan Kesehatan yang tidak efisien umumnya berbiaya mahal, kurang nyaman bagi pasien, memerlukan waktu lama, dan menimbulkan risiko yang lebih besar pada pasien. Dengan melakukan analisis efisiensi dan efektivitas kita dapat memilih intervensi yang paling efisien.
- e. Dimensi Kesenambungan: Dimensi kesinambungan layanan Kesehatan artinya pasien harus dapat dilayani sesuai dengan kebutuhannya, termasuk rujukan jika diperlukan tanpa mengulangi prosedur diagnosis dan terapi yang tidak perlu. Pasien harus selalu mempunyai akses ke layanan Kesehatan yang dibutuhkannya. Apabila Riwayat penyakit pasien terdokumentasi dengan lengkap, akurat, dan terkini maka layanan Kesehatan rujukan yang diperlukan pasien dapat terlaksana dengan tepat, waktu dan tempat. Kemampuan layanan Kesehatan untuk menyediakan perawatan yang konsisten dan terkoordinasi sepanjang waktu dan antar berbagai penyedia layanan.
- f. Dimensi Keamanan: Layanan Kesehatan harus aman baik bagi pasien, pemberi layanan maupun Masyarakat sekitarnya. Layanan Kesehatan yang bermutu harus aman dari risiko cedera, infeksi, efek samping, atau bahaya lain. Oleh karena itu, harus disusun suatu prosedur yang akan menjamin keamanan kedua belah pihak.
- g. Dimensi Kenyamanan: Dimensi kenyamanan tidak berpengaruh langsung dengan efektivitas layanan Kesehatan tetapi memengaruhi kepuasan pasien/konsumen sehingga mendorong pasien untuk datang berobat Kembali ke tempat tersebut. Kenyamanan dan kenikmatan dapat menimbulkan kepercayaan pasien terhadap organisasi layanan Kesehatan.
- h. Dimensi Informasi: Layanan Kesehatan yang bermutu harus mampu memberikan informasi yang jelas tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana layanan Kesehatan itu akan/ atau telah dilaksanakan. Dimensi informasi ini sangat penting pada tingkat puskesmas dan rumah sakit.
- i. Dimensi Ketepatan Waktu: Agar berhasil, layanan Kesehatan harus dilakukan dalam waktu dan cara yang tepat oleh pemberi layanan yang tepat, menggunakan peralatan dan obat yang tepat, serta biaya yang tepat (efisien). Mengurangi keterlambatan dalam pemberi layanan Kesehatan. Layanan yang diberikan tepat waktu dapat mencegah komplikasi lebih lanjut dan meningkatkan hasil Kesehatan.
- j. Dimensi Hubungan Antarmanusia: Hubungan antara pemberi layanan Kesehatan (*provider*) dengan pasien atau masyarakat (konsumen), pemerintah

daerah, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), atau antar sesama pemberi layanan Kesehatan (dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas). Hubungan antarmanusia yang baik akan menimbulkan kepercayaan dan kredibilitas dengan cara saling menghargai, menjaga rahasia, saling menghormati, responsive, memberi perhatian, dan lain-lain.

- k. Dimensi Keadalian (*Equity*) : Layanan Kesehatan harus dapat diakses dan adil bagi semua orang, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, status ekonomi, atau faktor lainnya. Keadilan memastikan bahwa semua individu mendapatkan layanan yang mereka butuhkan tanpa perbedaan perlakuan.
 - l. Dimensi Keterpusatan pada Pasien (*patient-Centeredness*) : Layanan harus berfokus pada kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai pasien. Ini melibatkan komunikasi yang baik antara pasien dan penyedia layanan, serta partisipasi pasien dalam pengambilan Keputusan mengenai perawatan mereka.
3. Prinsip Pelayanan Kesehatan Berkualitas dalam Kebidanan
- Prinsip pelayanan Kesehatan berkualitas dalam kebidanan meliputi:
- a. Berbasis standar dan evidence-based practice
 - b. Keselamatan ibu dan bayi sebagai prioritas utama
 - c. Pelayanan yang beretika dan menghormati hak pasien
 - d. Pelayanan yang sensitif terhadap sosial budaya

Dengan demikian, konsep dasar pelayanan Kesehatan berkualitas dalam kebidanan menekankan pada kesinambungan antara mutu klinis, keselamatan pasien, pendekatan humanistik, serta profesionalisme bidan. Pemahaman dan penerapan konsep ini menjadi fondasi penting dalam Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dan derajat Kesehatan ibu dan anak.

C. Peran Strategis Bidan dalam Pelayanan Kesehatan

Bidan merupakan tenaga Kesehatan profesional yang memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan Kesehatan, khususnya pada pelayanan Kesehatan ibu dan anak, Kesehatan reproduksi Perempuan, serta pelayanan keluarga berencana. Peran bidan mencakup Upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan.

1. Peran Bidan dalam Pelayanan Promotif dan Preventif

Pelayanan promotif merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya, sedangkan pelayanan preventif bertujuan mencegah terjadinya masalah kesehatan dan komplikasi. Dalam kebidanan, pelayanan promotif dan preventif menjadi fokus utama, karena sebagian besar masalah kesehatan ibu dan bayi dapat dicegah melalui edukasi dan deteksi dini.

- a. Peran bidan dalam pelayanan promotif, antara lain:
 - 1) Penyuluhan dan edukasi Kesehatan
 - 2) Konseling Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
 - 3) Pemberdayaan Perempuan dan keluarga
 - b. Peran bidan dalam pelayanan preventif

Pelayanan preventif yang dilakukan bidan antara lain:

 - 1) Deteksi dini faktor risiko kehamilan dan persalinan
 - 2) Pencegahan komplikasi maternal dan neonatal
 - 3) Pencegahan infeksi
2. Peran Bidan dalam Pelayanan Kuratif dan Rehabilitatif
- a. Pelayanan kuratif dalam kebidanan

Pelayanan kuratif merupakan Upaya pengobatan dan penanganan masalah Kesehatan sesuai dengan kewenangan bidan. Dalam praktik kebidanan, pelayanan kuratif dilakukan berdasarkan standar asuhan kebidanan dan kompetensi bidan, serta berfokus pada penanganan kasus normal dan deteksi dini komplikasi untuk dirujuk secara tepat.

Bentuk pelayanan kuratif yang dilakukan oleh bidan, adalah:

 - 1) Asuhan persalinan normal
 - 2) Penanganan kegawatdaruratan dasar maternal dan neonatal
 - 3) Pelayanan nifas dan perawatan bayi baru lahir

Pelayanan kuratif yang diberikan secara tepat dan profesional berkontribusi pada keselamatan ibu dan bayi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kebidanan.
 - b. Pelayanan Rehabilitatif dalam Kebidanan

Pelayanan rehabilitatif bertujuan memulihkan dan mempertahankan fungsi kesehatan ibu dan bayi setelah mengalami masalah kesehatan atau proses persalinan. Peran bidan dalam pelayanan rehabilitatif antara lain:

 - 1) Pemantauan pemulihan ibu nifas
 - 2) Dukungan menyusui dan laktasi
 - 3) Pendampingan Kesehatan mental ibu

Pelayanan rehabilitatif yang optimal membantu ibu kembali berfungsi secara fisik dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup ibu dan keluarga.

Peran bidan dalam pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Pendekatan *continuity of care* memungkinkan bidan untuk memberikan asuhan kebidanan yang holistik, berfokus pada keselamatan dan kebutuhan pasien, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan (ICM, 2021).

D. Asuhan Kebidanan Berkualitas dan Berkelanjutan

Asuhan kebidanan berkualitas dan berkelanjutan merupakan pendekatan pelayanan kebidanan yang menempatkan perempuan sebagai pusat asuhan dan diberikan secara terus-menerus oleh tenaga kesehatan yang kompeten sepanjang siklus reproduksi. Salah satu model asuhan yang terbukti efektif dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan adalah *Continuity of Care* (CoC). Pendekatan ini menekankan kesinambungan asuhan mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, perawatan bayi baru lahir hingga pelayanan keluarga berencana, sehingga asuhan yang diberikan bersifat holistik, terintegrasi, dan berkesinambungan (ICM, 2021).

1. Konsep Asuhan Kebidanan Berkelanjutan (*Continuity of Care*)

Continuity of Care dalam kebidanan didefinisikan sebagai pemberian asuhan kebidanan secara berkesinambungan oleh satu atau sekelompok kecil bidan kepada seorang perempuan sepanjang masa kehamilan, persalinan, nifas, dan periode antar kehamilan, termasuk pelayanan keluarga berencana. Model ini memungkinkan terjalinnya hubungan terapeutik yang kuat antara bidan dan klien, sehingga bidan dapat memahami kebutuhan, kondisi, serta faktor risiko yang dimiliki oleh perempuan secara lebih mendalam (Sandall et al., 2016).

Asuhan kebidanan berkelanjutan mencakup beberapa bentuk kesinambungan, yaitu kesinambungan informasi, kesinambungan manajemen, dan kesinambungan hubungan. Kesinambungan informasi memastikan bahwa data kesehatan ibu terdokumentasi dan digunakan secara konsisten dalam setiap tahap pelayanan. Kesinambungan manajemen menjamin bahwa rencana asuhan disesuaikan dengan kondisi ibu dari waktu ke waktu. Sementara itu, kesinambungan hubungan memungkinkan adanya kepercayaan dan komunikasi yang efektif antara bidan dan klien.

2. Asuhan Kebidanan dari Kehamilan hingga Keluarga Berencana

Asuhan kebidanan berkelanjutan dimulai sejak masa kehamilan melalui pelayanan antenatal yang komprehensif, mencakup pemeriksaan fisik, pemantauan kesejahteraan ibu dan janin, deteksi dini faktor risiko, serta edukasi kesehatan. Pada masa persalinan, bidan memberikan asuhan persalinan normal yang aman, berfokus pada keselamatan ibu dan bayi, serta penghormatan terhadap pilihan dan kebutuhan perempuan.

Selanjutnya, pada masa nifas dan neonatal, bidan melanjutkan asuhan melalui pemantauan pemulihan ibu, dukungan menyusui, perawatan bayi baru lahir, serta deteksi dini komplikasi pasca persalinan. Asuhan berkelanjutan ditutup dengan pelayanan keluarga berencana, yang bertujuan membantu

perempuan merencanakan kehamilan berikutnya secara aman dan sehat. Pendekatan ini memastikan tidak adanya kesenjangan pelayanan antar tahap kehidupan reproduksi perempuan (ICM, 2021).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Continuity of Care* dalam kebidanan memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan ibu. Hubungan yang berkelanjutan antara bidan dan klien meningkatkan rasa aman, kepercayaan, serta partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan terkait asuhan kebidanan. Kondisi ini berkontribusi pada pengalaman persalinan yang lebih positif dan bermakna bagi ibu.

Selain meningkatkan kepuasan, *Continuity of Care* juga terbukti menurunkan angka intervensi medis yang tidak perlu serta meningkatkan kepatuhan ibu terhadap anjuran kesehatan. Model asuhan ini memungkinkan bidan untuk melakukan pemantauan yang lebih intensif dan responsif terhadap perubahan kondisi ibu dan bayi, sehingga kualitas pelayanan kebidanan menjadi lebih optimal (Sandall et al., 2016).

Studi sistematis yang dilakukan oleh Sandall et al. (2016) menunjukkan bahwa perempuan yang menerima asuhan kebidanan dengan model *Continuity of Care* memiliki risiko lebih rendah mengalami komplikasi persalinan, seperti persalinan prematur dan intervensi obstetri yang berlebihan. Selain itu, model ini berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan outcome maternal dan neonatal secara keseluruhan.

Penerapan *Continuity of Care* juga berperan penting dalam deteksi dini faktor risiko dan komplikasi, sehingga rujukan dapat dilakukan secara tepat waktu. Dengan demikian, asuhan kebidanan berkelanjutan tidak hanya meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan keselamatan dan kesejahteraan ibu dan bayi.

E. Penguatan Peran Bidan dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas Berkelanjutan

Penguatan peran bidan menjadi krusial karena bidan berada di garis terdepan pelayanan kesehatan primer, khususnya dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dengan penguatan peran yang optimal, bidan dapat berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta meningkatkan kualitas hidup perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Dalam kebidanan, pelayanan Kesehatan berkualitas berkelanjutan diwujudkan melalui: asuhan kebidanan berkesinambungan, praktik kebidanan berbasis bukti, pendekatan berpusat pada Perempuan dan penguatan peran bidan dalam komunitas.

Penguatan peran bidan dalam pelayanan kesehatan berkualitas berkelanjutan, antara lain:

1. Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidan

Kompetensi bidan merupakan landasan utama dalam pemberian pelayanan kesehatan berkualitas. Bidan harus memiliki kompetensi klinis, komunikasi efektif, pemahaman etik dan hukum, serta kemampuan pengambilan keputusan berbasis bukti ilmiah. *International Confederation of Midwives* (ICM, 2019) menegaskan bahwa pengembangan profesional berkelanjutan merupakan kewajiban bidan untuk menjaga mutu pelayanan.

Peningkatan kompetensi bidan dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan klinis, supervisi praktik, dan refleksi profesional. Kompetensi yang kuat akan meningkatkan keselamatan pasien serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kebidanan.

2. Penguatan Peran Bidan dalam Asuhan Kebidanan Berkelanjutan

Asuhan kebidanan berkelanjutan (*continuity of care*) merupakan model pelayanan di mana bidan memberikan asuhan secara konsisten sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, perawatan bayi baru lahir, hingga pelayanan keluarga berencana. Model ini terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan ibu (Sandall et al., 2016). Penelitian menunjukkan bahwa model *continuity of care* berkontribusi pada penurunan intervensi medis yang tidak perlu, penurunan komplikasi persalinan, serta peningkatan outcome maternal dan neonatal (Sandall et al., 2016).

3. Penguatan Dukungan Sistem dan Kebijakan

Optimalisasi peran bidan memerlukan dukungan sistem pelayanan dan kebijakan kesehatan yang kuat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar profesi, kewenangan praktik, serta regulasi praktik mandiri bidan sebagai bentuk penguatan peran bidan dalam sistem kesehatan nasional. Dukungan kebijakan yang konsisten akan memastikan bidan dapat bekerja sesuai kompetensi, memperoleh perlindungan hukum, serta mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai dalam memberikan pelayanan kebidanan.

4. Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan

Pelayanan kesehatan berkualitas berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas profesi dan lintas sektor. Bidan perlu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan keluarga dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

Penguatan peran bidan merupakan strategi penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berkualitas berkelanjutan. Melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme, penerapan asuhan kebidanan berkesinambungan, penguatan

peran promotif dan preventif, dukungan kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor, bidan dapat memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan perempuan. Dengan demikian, bidan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

F. Simpulan

Peran bidan sangat penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Bidan tidak hanya memberikan asuhan kebidanan sesuai standar, tetapi juga berperan sebagai pendidik, konselor, dan pendamping bagi ibu, bayi, keluarga, serta masyarakat. Pelaksanaan peran ini secara optimal mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khususnya pada kesehatan ibu dan anak. Kualitas pelayanan kebidanan dipengaruhi oleh kompetensi bidan, kepatuhan terhadap standar dan etika profesi, serta kemampuan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistem kesehatan berupa kebijakan yang jelas, peningkatan kapasitas bidan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kerja sama lintas profesi. Dengan demikian, penguatan peran bidan menjadi langkah penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Optimalisasi peran kebidanan tidak hanya berdampak pada keselamatan dan kepuasan pasien, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

G. Referensi

- International Confederation of Midwives. (2021). *Global standards for midwifery education*. ICM.
<https://www.google.com/search?q=International+Confederation+of+Midwives.+>(2021).
- Isyos Sembiring, Siti Sinaga (2024). *Mutu Pelayanan Kebidanan Dan Kebijakan Kesehatan*. Banten: CV. AA Risky
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Kemenkes RI. <https://kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2022>
- Krismanto, & Irianto, S. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(2), 154-165.
<https://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/26677/pdf>
- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4).

World Health Organization. (2020). *Quality of care in maternal, newborn, child and adolescent health*. WHO <https://humanjourney.us/health/global-health/maternal-and-child-health/>

H. Glosarium

CoC	= <i>Continuity of Care</i>
ICM	= <i>International Confederation of Midwives</i>
WHO	= <i>World Health Organization</i>

CHAPTER 3

KONTRIBUSI KEPERAWATAN DALAM MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan secara umum diartikan pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui upaya upaya pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya. Pelayanan kesehatan ini diberikan secara profesional oleh tenaga kesehatan baik dokter, dokter gigi, perawat, bidan, radiografer, apoteker, dan lain sebagainya. Kementerian Kesehatan (2023), menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Keperawatan merupakan sebuah profesi yang berdedikasi untuk menjunjung tinggi hak setiap orang memperoleh standar kesehatan tertinggi melalui komitmen bersama dalam menyediakan perawatan yang kolaboratif, aman secara budaya, dan berfokus pada orang.” Pelayanan keperawatan mencakup upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan orang sakit dan akhirnya dukungan serta advokasi terhadap akses layanan kesehatan yang adil dan keselamatan pasien. Pelayanan Keperawatan adalah

Gambaran pelayanan kesehatan khususnya keperawatan saat ini menunjukkan masih perlu adanya upaya peningkatan kualitas dalam berbagai hal, hal ini menjadi suatu yang urgen untuk dibahas. Beberapa studi literatur dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan belum optimal, yang berdampak langsung pada kepuasan pasien. Penelitian tinjauan pustaka menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti prosedur medis, praktek administrasi, keselamatan pasien, infrastruktur dan kualitas tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien, sementara pelayanan yang tidak profesional atau tidak responsif berdampak pada rendahnya kepuasan pasien (Harefa, AS, 2025)

Pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit regional digambarkan di beberapa studi masih mengalami kurangnya profesionalisme, sikap staf yang

kurang ramah, lambatnya respon layanan, dan komunikasi yang kurang efektif terhadap pasien, dan hal ini memengaruhi kualitas keseluruhan layanan kesehatan, mutu pelayanan belum sepenuhnya memenuhi standar profesional dan harapan pasien, terutama dalam aspek non-medis (komunikasi, respon cepat, empati. (Heintz,F,Bellbachir,N.Curry,E. 2025). Inti dari permasalahan tersebut adalah mutu pelayanan belum sepenuhnya memenuhi standar profesional dan harapan pasien, terutama dalam aspek non-medis (komunikasi, respon cepat, empati)

Latar belakang lain yang menimbulkan kondisi diatas adalah tingkat kelelahan tenaga kesehatan menjadi masalah penting yang memengaruhi kualitas layanan. Kelelahan tenaga kesehatan dapat menyebabkan turunnya kualitas pelayanan, terutama dalam hal kecepatan respons dan ketelitian tindakan pelayanan, yang dampaknya adalah meningkatnya kesalahan pelayanan atau menurunnya kepuasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dampak kelelahan tenaga kesehatan berkontribusi pada pelayanan yang kurang responsif dan kurang berkualitas. Hal lain yang berkontribusi adalah kondisi ruang tunggu, alat medis, serta infrastruktur yang menjadi pendukung masih menjadi penghambat penting dalam kualitas pelayanan kesehatan di beberapa daerah. Kurangnya fasilitas dukungan seperti peralatan medis dan ruang layanan yang memadai memengaruhi persepsi profesionalisme dan kenyamanan pasien, terutama di daerah terpencil. Di lain pihak, dari aspek Implementasi Standar Mutu & Akreditasi harusnya dapat meningkatkan mutu pelayanan, namun standar mutu yang dilaksanakan juga belum sepenuhnya didukung sumber daya atau pengelolaan yang efektif (Manderos, C.Kawatu, P.A.T, Pangaribuan, M. 2024).

Situasi dalam pelayanan Keperawatan pun demikian, kualitas pelayanan keperawatan masih perlu ditingkatkan kualitas layanan keperawatan yang baik terkait secara signifikan dengan kepuasan pasien; tetapi layanan keperawatan yang dinilai kurang baik cenderung membuat pasien tidak puas. Salah satu penyebab kondisi ini adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan di kalangan beberapa perawat menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas layanan keperawatan, sehingga solusi potensial yang disarankan adalah pelatihan berkelanjutan dan pendidikan profesi yang lebih kuat. Penyebab lain dari sisi perawat adalah aspek komunikasi perawat dengan pasien Yang akan sangat menentukan persepsi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Efektivitas komunikasi dan hubungan interpersonal antara perawat dan pasien memengaruhi kualitas layanan, terutama dalam konteks home care atau layanan lanjutan dari rumah sakit. Melihat alasan ini jelas penting adanya penguatan keterampilan komunikasi dan sikap empati dari perawat, yang pada akhirnya memberikan kontribusi nyata pada persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan atau pelayanan keperawatan

B. Konsep Mutu dan Keselamatan Pasien

1. Beberapa konsep terkait Mutu

a. Pengertian Mutu (Quality)

Secara umum, mutu (quality) adalah tingkat kesesuaian suatu pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan dan kemampuan pelayanan tersebut dalam memenuhi kebutuhan serta harapan pengguna.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, mutu tidak hanya diukur dari hasil klinis, tetapi juga dari proses, keselamatan, efisiensi, dan kepuasan pasien.

Definisi menurut beberapa ahli:

WHO:

Mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat pelayanan yang meningkatkan kemungkinan hasil kesehatan yang diinginkan dan konsisten dengan pengetahuan profesional terkini.

Institute of Medicine (IOM)

Mutu pelayanan kesehatan adalah sejauh mana layanan kesehatan untuk individu dan populasi meningkatkan kemungkinan hasil kesehatan yang diinginkan dan konsisten dengan pengetahuan profesional terkini.

Juran:

Quality is "fitness for use" kesesuaian produk/jasa untuk digunakan sesuai kebutuhan pengguna.

b. Teori dan Model Mutu dalam Pelayanan Kesehatan

1) Teori Donabedian (Model Struktur–Proses–Hasil)

Teori Donabedian adalah model mutu paling klasik dan paling banyak digunakan dalam pelayanan kesehatan dan keperawatan. Penjelasan dari aspek struktur, proses dan hasil sebagai berikut:

a) Struktur (Structure)

Menggambarkan sumber daya dan kondisi organisasi:

- Sumber Daya Manusia (jumlah & kompetensi perawat)
- Sarana prasarana
- Kebijakan, SOP dan sistem manajemen

b) Proses (Process)

Menggambarkan bagaimana pelayanan diberikan, terutama beberapa komponen penting berikut:

- Asuhan keperawatan
- Komunikasi terapeutik
- Pemberian obat
- Dokumentasi keperawatan

c) Hasil (Outcome)

Hasil dari pelayanan berupa dampak pelayanan terhadap pasien, yang dapat menghasilkan beberapa harapan sebagai berikut

- Kesembuhan
- Kepuasan pasien
- Penurunan komplikasi
- Penurunan angka kejadian tidak diinginkan

2) Total Quality Management (TQM)

TQM menekankan bahwa mutu adalah tanggung jawab semua orang dalam organisasi, bukan hanya pimpinan.

a) Prinsip utama TQM:

- Fokus pada pelanggan (pasien & keluarga)
- Perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*)
- Keterlibatan seluruh staf
- Pengambilan keputusan berbasis data

Implementasi dalam keperawatan sebagai berikut:

- a) Tindakan Audit keperawatan
- b) Monitoring indikator mutu
- c) Budaya mutu dan keselamatan pasien

3) Continuous Quality Improvement (CQI)

CQI merupakan pendekatan sistematis untuk kegiatan penting sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi masalah mutu
- b) Menganalisis penyebab
- c) Melakukan perbaikan berkelanjutan

Berikut ini adalah contoh alat yang bisa digunakan untuk CQI:

- a) Plan–Do–Check–Act (PDCA)
- b) Root Cause Analysis (RCA)
- c) Audit klinis

4) Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan (IOM)

Enam dimensi mutu pelayanan kesehatan menurut IOM menegaskan bahwa pelayanan yang bermutu tidak cukup hanya efektif secara klinis, tetapi juga harus aman, berorientasi pada pasien, tepat waktu, efisien, dan adil. Keenam dimensi ini saling terkait dan menjadi dasar dalam pengembangan patient safety, clinical governance, dan peningkatan mutu berkelanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Berikut ini penjelasan masing masing komponen dari 6 dimensi mutu pelayanan Kesehatan sebagai berikut

a) Aman (Safe)

Pelayanan kesehatan harus melindungi pasien dari cedera atau bahaya yang seharusnya dapat dicegah selama proses asuhan kesehatan.

Inti dari konsep diatas adalah sebagai berikut:

- Menghindari kesalahan medis (medical error)
- Mencegah kejadian tidak diharapkan (KTD/adverse events)
- Memastikan keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan lingkungan

Contoh penerapan dalam situasi klinik

- Identifikasi pasien secara benar
- Pemberian obat dengan prinsip "6 benar"
- Pencegahan infeksi (hand hygiene, APD)
- Pelaporan dan pembelajaran insiden keselamatan pasien

b) Efektif (Effective)

Pelayanan kesehatan diberikan berdasarkan bukti ilmiah terbaik (evidence-based practice) dan memberikan manfaat klinis yang optimal bagi pasien yang membutuhkan.

Inti dari konsep diatas adalah:

- Tepat indikasi
- Tepat intervensi
- Tidak melakukan tindakan yang tidak perlu atau tidak bermanfaat

Contoh penerapan dalam situasi klinik:

- Penggunaan panduan praktik klinis (*clinical pathway*)
- Asuhan keperawatan berbasis evidence
- Evaluasi hasil pelayanan (*outcome-oriented care*)

c) Berorientasi pada Pasien (*Patient-centered*)

Pelayanan kesehatan harus menghormati nilai, preferensi, kebutuhan, dan harapan pasien serta keluarganya, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.

Inti dari konsep diatas adalah bahwa pasien sebagai mitra aktif, menggunakan komunikasi terapeutik dan menghargai hak dan martabat pasien

Contoh penerapan dalam situasi klinik:

- Informed consent
- Edukasi pasien dan keluarga
- Pendekatan *Family-Centered Care*
- Asuhan yang mempertimbangkan budaya dan keyakinan pasien

d) Tepat Waktu (*Timely*)

Pelayanan kesehatan harus diberikan tanpa keterlambatan yang tidak perlu, baik bagi pasien maupun penyedia layanan.

Inti konsep diatas Adalah mengurangi waktu tunggu dan mencegah perburukan kondisi akibat keterlambatan pelayanan

Contoh penerapan dalam situasi klink sebagai berikut:

- Respon cepat pada kondisi gawat darurat
- Pengurangan antrean pelayanan
- Pelayanan keperawatan sesuai standar waktu respon (*response time*)

e) Efisien (*Efficient*)

Pelayanan kesehatan harus menggunakan sumber daya secara optimal dan menghindari pemborosan tanpa mengurangi mutu dan keselamatan.

Inti konsep diatas Adalah tidak ada duplikasi Tindakan dan pemanfaatan sumber daya secara tepat guna

Contoh penerapan dalam situasi klinik sebagai berikut:

- Penggunaan alat dan obat sesuai kebutuhan
- Alur pelayanan yang efektif
- Manajemen keperawatan dan beban kerja yang seimbang

f) Adil (*Equitable*)

Pelayanan kesehatan harus diberikan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, usia, status sosial ekonomi, pendidikan, lokasi geografis, atau kondisi tertentu.

Inti dari konsep diatas Adalah kesetaraan akses dan mutu pelayanan dan tidak ada perlakuan berbeda yang merugikan pasien

Contoh penerapan dalam situasi klinik:

- Pelayanan yang sama bagi pasien BPJS maupun non-BPJS
- Akses pelayanan bagi kelompok rentan (anak, lansia, disabilitas)
- Pemerataan mutu pelayanan di berbagai wilayah

2. Konsep Keselamatan Pasien

a. Pengertian Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera atau kerugian pada pasien akibat proses pelayanan kesehatan.

Berikut ini Definisi dari WHO (2021) dan Permenkes no 11, 2017

WHO (2021)

Patient safety is the prevention of errors and adverse effects to patients associated with health care.

Permenkes RI No. 11 Tahun 2017:

Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman melalui upaya identifikasi risiko, pelaporan, analisis insiden, dan pembelajaran dari insiden.

b. Konsep Dasar Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien berfokus pada pencegahan kesalahan (error prevention), pengurangan risiko cedera dan perbaikan sistem, bukan menyalahkan individu

Prinsip penting yang harus dipegang Adalah *No blame culture / just culture*, pendekatan system dan pembelajaran dari insiden

c. Komponen Sistem Keselamatan Pasien

Menurut WHO dan Kementerian Kesehatan, sistem keselamatan pasien meliputi:

- 1) Identifikasi risiko
- 2) Pelaporan insiden keselamatan pasien
- 3) Analisis insiden (RCA)
- 4) Tindak lanjut dan perbaikan
- 5) Pembelajaran dan edukasi staf
- 6) Monitoring dan evaluasi

d. Jenis Insiden Keselamatan Pasien

Berikut ini Adalah beberapa jenis Insiden Keselamatan Pasien

- 1) Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) Insiden yang menyebabkan cedera pada pasien

- 2) Kejadian Nyaris Cedera (KNC / Near Miss)
 - 3) Kejadian Tidak Cedera (KTC)
 - 4) Kejadian Potensial Cedera (KPC)
 - 5) Sentinel Event (kejadian serius seperti kematian tak terduga)
- e. Sasaran Keselamatan Pasien
- Berdasarkan WHO (2021) dan standar akreditasi rumah sakit (KARS) (2022), sasaran keselamatan pasien adalah sebagai berikut
- 1) Identifikasi pasien dengan benar
 - 2) Komunikasi efektif
 - 3) Keamanan obat yang perlu diwaspadai
 - 4) Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien
 - 5) Pengurangan risiko infeksi
 - 6) Pengurangan risiko pasien jatuh
- f. Hubungan antara mutu pelayanan dan keselamatan pasien
- Antara mutu pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan kepada pasien dengan keselamatan pasien memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu
- 1) Keselamatan pasien adalah inti dari mutu pelayanan kesehatan
 - 2) Pelayanan tidak dapat disebut bermutu jika tidak aman
 - 3) Mutu tinggi selalu mencakup pelayanan yang aman, berbasis bukti dan berorientasi pada pasien

C. Peran strategis Tenaga Kesehatan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Berkualitas

Secara makro, peran strategis tenaga kesehatan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Promosi Kesehatan

Upaya pencegahan dan promosi kesehatan sebagai langkah *prevensi primer*, sebelum masalah itu betul betul terjadi.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut

- a. Melakukan imunisasi, pendidikan kesehatan masyarakat, dan deteksi dini penyakit.
- b. Memberikan penyuluhan pola hidup sehat dan program pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
- c. Peran ini membantu menurunkan angka kesakitan (morbidity) melalui pencegahan lebih awal terhadap penyakit.
Contoh: Program imunisasi menurunkan kejadian penyakit menular serius seperti campak dan polio.

2. Diagnosa dan Perawatan
 - a. Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan memberikan layanan klinis langsung di fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit).
 - b. Memberikan diagnosa tepat waktu, tata laksana penyakit akut dan kronis, serta layanan rujukan
3. Rehabilitasi dan Pemulihan
 - a. Mendukung pasien pasca-pengobatan penyakit kronis atau pasca-operasi.
 - b. Termasuk terapi fisik, psikologi klinis, dan gizi untuk mengembalikan kualitas hidup.
4. Manajemen Kesehatan dan Kebijakan

Tenaga kesehatan juga berperan dalam pengambilan keputusan sistemik seperti perencanaan layanan, evaluasi mutu pelayanan, peningkatan capaian SDM kesehatan, serta penguatan data seperti NHTA (National Health Workforce Accounts) untuk tata kelola yang lebih baik. (WHO, 2021)

Tenaga kesehatan bukan hanya memberikan pengobatan, tetapi juga mengurangi beban penyakit melalui pencegahan, edukasi, dan sistem pelayanan yang kuat, sehingga berdampak pada menurunkan angka morbiditas dan mortalitas

5. Kategori tenaga kesehatan yang berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Berdasarkan data jumlah tenaga kesehatan Nasional di Indonesia, BPS dan Kemenkes (2025), total jumlah tenaga kesehatan di tahun 2025 adalah 1.58 juta orang, yang mencakup berbagai profesi kesehatan sebagai berikut:

Menurut data BPS dan Kemenkes (2025), kategori tenaga kesehatan adalah sebagai berikut

Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah (≈)	Peran Utama
Perawat	~603.046 orang	Layanan klinis dasar, asuhan keperawatan, manajemen pasien
Bidan	~362.212 orang	Pelayanan ibu dan anak, persalinan, KB
Tenaga medis (dokter, spesialis)	~207.174 orang	Diagnosa & terapi medis
Tenaga kefarmasian	~131.079 orang	Penyediaan dan pengelolaan obat
Tenaga teknik biomedika	~83.877 orang	Mendukung alat kesehatan
Kesehatan masyarakat	~61.585 orang	Promosi kesehatan & pencegahan penyakit

Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah (≈)	Peran Utama
Lainnya (gizi, lingkungan, psikologi, dll)	variatif	Peran pendukung layanan terpadu

Perawat dan bidan merupakan bagian terbesar SDM kesehatan, karena mereka adalah garda terdepan pelayanan primer dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di puskesmas dan rumah sakit.

Dalam kaitannya dengan upaya menurunkan angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian mortalitas), kontribusi tenaga kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Perbaikan layanan antenatal dan perinatale yang menurunkan kematian ibu dan bayi.
- b. Imunisasi lengkap yang mengurangi kematian akibat penyakit menular berat.
- c. Penanganan penyakit tidak menular secara lebih baik melalui pemeriksaan kesehatan rutin, deteksi risiko penyakit jantung, stroke dan lain lain

Kontribusi tenaga kesehatan sangatlah krusial dalam pencapaian kesehatan berkualitas, terutama melalui upaya pencegahan penyakit dan promotif edukasi masyarakat, Diagnosis dan perawatan klinis yang efektif dan penanganan penyakit yang berdampak langsung pada menurunkan morbiditas dan mortalitas. Sementara Perawat, bidan, dan tenaga medis tetap menjadi pilar utama pelayanan kesehatan di Indonesia, dan upaya peningkatan kualitas serta distribusinya merupakan kunci dalam mencapai cakupan kesehatan semesta (WHO, 2021)

6. Kategori Ketenagaan Keperawatan di Indonesia

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, tenaga keperawatan yang berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan berkualitas dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Perawat Vokasi (D3 Keperawatan)

Peran utama dari perawat vokasi adalah sebagai berikut:

- 1) a. Memberikan asuhan keperawatan dasar sesuai standar prosedur melaksanakan tindakan keperawatan seperti perawatan luka, Pemberian obat sesuai instruksi dan monitoring tanda vital
- 2) b. Mendampingi pasien selama perawatan dan rehabilitasi. Kontribusi yang diharapkan terhadap kualitas layanan adalah sebagai berikut:
- 3) c. Menjadi tulang punggung pelayanan langsung (direct care), terutama di ruang rawat inap.
- 4) d. Menjamin kontinuitas perawatan pasien 24 jam.

b. Perawat Profesional (Ners)

Peran utama perawat profesional dalam konteks pemberian layanan kesehatan/keperawatan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan asuhan keperawatan komprehensif (bio-psiko-sosial-spiritual).
- 2) Melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pengkajian keperawatan
 - b) Penegakan diagnosa keperawatan
 - c) Perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan keperawatan
- 3) c.Edukasi kesehatan pasien dan keluarga.
- 4) d.Koordinasi dengan tenaga kesehatan lain (dokter, farmasi, gizi).

Kontribusi kualitas layanan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin keselamatan pasien (patient safety).
- 2) Meningkatkan mutu layanan melalui praktik berbasis bukti (evidence based nursing).
- 3) Sangat berperan dalam pelayanan promotif dan preventif.

c. Perawat Spesialis (Spesialis Keperawatan, S2 Keperawatan Spesialis)

Kategori perawat pada level ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perawat Spesialis Keperawatan Medikal Bedah
- 2) Perawat Spesialis Keperawatan Anak
- 3) Perawat Spesialis Jiwa
- 4) Perawat Spesialis Keperawatan Komunitas
- 5) Perawat Spesialis Keperawatan Gawat Darurat

Adapun peran utama yang diharapkan dari perawat dengan kategori tersebut diatas adalah:

- 1) Menangani kasus kompleks dan berisiko tinggi.
- 2) Konsultan keperawatan bagi perawat umum.
- 3) Pengembangan standar asuhan dan SOP klinis
- 4) Pelatihan dan supervisi perawat lain.

Sementara itu dalam hal kontribusi kualitas layanan diharapkan dapat Meningkatkan outcome klinis pasien, menurunkan angka komplikasi, lama rawat, dan kesalahan tindakan, dan sangat berperan dalam unit khusus (ICU, NICU, HD, jiwa, paliatif).

d. Perawat Manajer/Perawat Struktural (Biasanya Ners/S2 Manajemen Keperawatan)

Peran utama yang diharapkan adalah dalam Manajemen SDM keperawatan, pengawasan dan pengelolaan keselamatan pasien

1) Dalam hal manajemen SDM Keperawatan terutama difokuskan pada aspek berikut:

- a) Perencanaan jumlah dan kompetensi perawat
- b) Penjadwalan dinas

2) Dalam pengawasan mutu pelayanan keperawatan perawat manajer (sering disebut kepala ruangan, kepala bidang, atau unit nurse manager) memiliki peran sentral dalam memastikan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan di rumah sakit sesuai standar profesional dan aman bagi pasien. Beberapa kontribusi penting meliputi:

a) Perencanaan Mutu dan Standarisasi, diantaranya

- Menetapkan dan memastikan penerapan standar pelayanan keperawatan sesuai pedoman profesi dan kebijakan rumah sakit.
- Mengembangkan, memperbaiki, dan mensosialisasikan Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk praktik keperawatan yang aman dan efektif.
- Perawat manajer bertanggung jawab menyelaraskan aktivitas unit dengan visi dan misi organisasi serta tujuan mutu pelayanan.

b) Organisasi Sumber Daya Manusia

- Mengatur staffing/perencanaan jadwal, sehingga ketersediaan perawat sesuai kebutuhan klinis dan tidak menimbulkan kelelahan berlebih.
- Meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan, mentoring, dan coaching, sehingga kompetensi teknis klinik dan aspek keselamatan terus meningkat.

c) Pengawasan dan Evaluasi

- Melakukan supervisi aktif terhadap praktik keperawatan memonitor kepatuhan terhadap standar, prosedur, dokumentasi, dan etika profesi.
- Menganalisis indikator mutu keperawatan (misalnya angka kejadian jatuh, infeksi, kesalahan medikasi) untuk menentukan area perbaikan.
- Memberikan umpan balik dan melakukan evaluasi kinerja perawat pelaksana secara rutin untuk menjamin kualitas asuhan.

d) Promosi Budaya Mutu

- Mendorong budaya pelaporan yang terbuka tanpa hukuman (*just culture*), sehingga kesalahan atau risiko dapat dianalisis untuk perbaikan proses pelayanan.
- Memimpin atau berpartisipasi dalam kegiatan *quality improvement* (peningkatan mutu), seperti audit internal, diskusi kasus risiko, dan pertemuan tim lintas profesi.

Secara keseluruhan, fungsi perawat manajer adalah memastikan praktik keperawatan dilakukan sesuai standar, aman, dan berfokus terhadap kebutuhan pasien yang secara langsung berkaitan dengan mutu keseluruhan pelayanan keperawatan.

Fokus Perawat Manajer dalam Pengelolaan Keselamatan Pasien & Risiko

Keselamatan pasien (*patient safety*) adalah bagian tak terpisahkan dari mutu pelayanan. Perawat manajer berperan aktif dalam beberapa kegiatan berikut ini:

a. Identifikasi & Penilaian Risiko

- 1) Menerapkan sistem asesmen risiko untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada perawatan pasien.
- 2) Menentukan area risiko tinggi (mis., kesalahan obat, infeksi nosokomial, jatuh pasien) untuk pencegahan dini.

b. Pelaporan dan Analisis Insiden Keselamatan

- 1) Mendorong pelaporan insiden (*incident reporting*) oleh staf keperawatan tanpa rasa takut akan sanksi.
- 2) Mengkaji dan menganalisis akar masalah dari insiden yang dilaporkan untuk menentukan langkah perbaikan (*root cause analysis*).

c. Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Pasien

- 1) Menyelenggarakan pelatihan berkala untuk perawat tentang protokol keselamatan seperti:
 - a) Pencegahan jatuh
 - b) Pencegahan infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs)
 - c) Keselamatan medikasi
 - d) Standar komunikasi efektif antar shift
- 2) Pendidikan ini membantu meningkatkan kesadaran dan keterampilan staf dalam mencegah risiko yang dapat membahayakan pasien.

d. Integrasi Keselamatan Pasien dalam Sistem Manajemen

- 1) Menerapkan *Patient Safety Goals* dan mengintegrasikannya pada proses kerja harian setiap perawat.
- 2) Melakukan monitoring dan audit rutin, serta menggabungkan hasilnya dalam laporan mutu untuk evaluasi manajemen.
- 3) Mendorong pengembangan budaya keselamatan pasien yang kuat di unit kerja, yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama.

e. Kolaborasi Interdisipliner

- 1) Berkoordinasi dengan dokter, apoteker, fisioterapis, manajemen risiko rumah sakit, dan komite keselamatan pasien untuk menangani risiko secara terpadu.
- 2) Menjadi penghubung antara tim keperawatan dan manajemen rumah sakit untuk memastikan strategi keselamatan pasien diimplementasikan secara efektif.

Dampak Implementasi Peran Perawat Manajer terhadap Mutu dan Keselamatan Pasien

Berdasarkan bukti penelitian dan kajian ilmiah:

- a. Kepemimpinan perawat manajer berkorelasi dengan penurunan kejadian insiden keselamatan, lebih banyak pelaporan kesalahan, dan peningkatan kepuasan pasien terkait pelayanan.
- b. Perawat manajer yang menerapkan strategi kepemimpinan transformasional cenderung meningkatkan budaya keselamatan dan praktik keselamatan secara signifikan di unit perawatan.
- c. Lingkungan kerja yang sehat dengan pengawasan dan dukungan manajerial yang baik membantu meningkatkan kualitas asuhan dan keterlibatan staf dalam keselamatan pasien.

Perawat manajer/perawat struktural tidak hanya bertanggung jawab atas administrasi dan organisasi staf, tetapi juga memegang peran penting dalam pengawasan mutu klinik keperawatan, sebagai berikut:

- a. Implementasi sistem keselamatan pasien
- b. Identifikasi risiko klinis dan mitigasi
- c. Meningkatkan budaya keselamatan dan kepatuhan staf terhadap standar

Semua fungsi ini saling mendukung terciptanya pelayanan keperawatan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi di rumah sakit.

d. Perawat Komunitas (Perawat Kesehatan Masyarakat)

Peran utama yang diharapkan dari perawat Komunitas adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan keperawatan di masyarakat:
 - 1) Kunjungan rumah
 - 2) Posyandu, Posbindu PTM
- 2) Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
- 3) Pemantauan penyakit kronis (hipertensi, DM, TBC).
- 4) Pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Kontribusi kualitas layanan dari perawat komunitas terutama diharapkan dapat ikut serta dalam upaya sebagai berikut:

- 1) Menurunkan angka kesakitan melalui pencegahan primer dan sekunder.
- 2) Mengurangi beban rumah sakit.
- 3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

e. Sistem Ketenagaan Keperawatan di Rumah Sakit

- 1) Sistem Ketenagaan keperawatan terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Rumah Sakit dan di Komunitas (Masyarakat)

a) Karakteristik Sistem ketenagaan di Rumah Sakit adalah sebagai berikut

- (1) Berbasis jenjang kompetensi (vokasional, ners, spesialis).
- (2) Menggunakan model asuhan keperawatan, antara lain:
 - Model Tim
 - Model Primary Nursing
 - Model Fungsional (masih ditemukan di RS dengan SDM terbatas)

b) Struktur Umum terdiri atas

- (1) Perawat Pelaksana (D3 / Ners)
- (2) Ketua Tim / Primary Nurse (Ners)
- (3) Clinical Instructor / Perawat Spesialis
- (4) Kepala Ruangan (Ners / S2)
- (5) Bidang Keperawatan

c) Fokus Utama dari sistem ketenagaan di Rumah Sakit adalah sebagai berikut

- (1) Pelayanan kuratif dan rehabilitatif
- (2) Keselamatan pasien
- (3) Akreditasi rumah sakit
- (4) Penanganan kasus akut dan kompleks

Perlu diingat bahwa Rumah sakit sangat bergantung pada perawat profesional dan spesialis untuk menjamin mutu layanan dan keselamatan pasien.

2) Sistem Ketenagaan Keperawatan di Masyarakat (Puskesmas)

a) Karakteristik Sistem di Puskesmas

- (1) Dominasi perawat Ners dan perawat komunitas.
- (2) Pendekatan keluarga dan wilayah kerja.
- (3) Terintegrasi dengan program Kesehatan Nasional

3) Peran Perawat di Puskesmas adalah sebagai berikut

a) Pelayanan keperawatan individu dan keluarga.

b) Program:

- (1) Kesehatan ibu dan anak
- (2) Imunisasi
- (3) Pencegahan PTM
- (4) Kesehatan jiwa masyarakat

c) Surveilans dan pelaporan kesehatan.

4) Fokus Utama pelayanan di Puskesmas adalah sebagai berikut

- a) Promotif dan preventif
- b) Deteksi dini penyakit
- c) Pengendalian faktor risiko
- d) Pemberdayaan masyarakat

Catatan penting untuk ketenagaan keperawatan di Puskesmas, perawat berperan strategis sebagai ujung tombak sistem kesehatan nasional, terutama dalam menurunkan angka kesakitan jangka panjang.

D. Rekomendasi Strategis

Tujuan secara umum adalah untuk meningkatkan mutu, keselamatan pasien, kepuasan pasien, dan profesionalisme perawat melalui penguatan sistem, kompetensi, dan budaya mutu pelayanan keperawatan> Beberapa strategi yang direkomendasikan adalah sebagai berikut

1. Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme Perawat

Hal ini direkomendasikan karena kompetensi klinis tidak merata, kurangnya pelatihan berkelanjutan, adanya gap antara teori dan praktik

Program yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut

a. Continuing Nursing Education (CNE) berkelanjutan

b. Pelatihan berbasis:

- 1) Evidence-Based Nursing (EBN)
- 2) Patient Safety & Clinical Reasoning

- 3) Komunikasi terapeutik & empati
- c. Clinical mentoring & preceptorship bagi perawat junior
- d. Penguatan peran perawat spesialis dan perawat klinis (PK I–V)

Dari implementasi program diatas, indikator Keberhasilan yang dapat dievaluasi adalah sebagai berikut

- a. Peningkatan kompetensi klinis
 - b. Penurunan insiden kesalahan keperawatan
 - c. Kepuasan pasien meningkat
2. Optimalisasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan (SDKI–SLKI–SIKI)

Rekomendasi ini dilatar belakangi permasalahan dokumentasi tidak lengkap, Standar belum konsisten diterapkan, Fokus administratif lebih banyak dari pada asuhan pasien

Untuk itu program yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut

- a. Standarisasi Clinical Pathway Keperawatan
- b. Audit keperawatan rutin & supervisi klinis
- c. Pemanfaatan Sistem Informasi Keperawatan Terintegrasi
- d. Pelatihan dokumentasi asuhan berbasis outcome

Dari implementasi program diatas, indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi adalah sebagai berikut

- a. Kepatuhan dokumentasi meningkat
 - b. Asuhan lebih terstruktur & terukur
 - c. Outcome pasien lebih jelas
3. Perbaikan Beban Kerja & Kesejahteraan Perawat

Rekomendasi ini dilatar belakangi permasalahan Burnout & kelelahan tinggi; Rasio perawat dan pasien tidak ideal

Program yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut

- a. Penyesuaian rasio perawat–pasien berbasis acuity level
- b. Penjadwalan kerja yang adil & fleksibel
- c. Program well-being perawat:
 - 1) Konseling psikologis
 - 2) Dukungan manajemen stres
- d. Sistem penghargaan & insentif berbasis kinerja

Dari implementasi program diatas, indikator Keberhasilan yang dapat dievaluasi adalah sebagai berikut

- a. Burnout menurun
 - b. Retensi perawat meningkat
 - c. Kinerja dan empati meningkat
4. Penguatan Komunikasi Terapeutik & Patient-Centered Care

Permasalahan yang melatar belakangi adalah komunikasi kurang empatik dan pasien dan keluarga merasa kurang dilibatkan

Program yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan komunikasi terapeutik & budaya caring
- b. Implementasi Family-Centered Care (FCC)
- c. Pelibatan pasien dan keluarga dalam:
 - 3) Pengambilan keputusan
 - 4) Edukasi kesehatan
- d. Penguatan informed consent berbasis komunikasi

Dari implementasi program diatas, indikator Keberhasilan yang dapat dievaluasi adalah sebagai berikut

- a. Kepuasan pasien & keluarga meningkat
 - b. Komplain pelayanan menurun
 - c. Hubungan terapeutik lebih baik
5. Penguatan Kepemimpinan Keperawatan & Budaya Mutu

Permasalahan yang melatar belakangi adalah supervisi yang belum optimal dan budaya mutu belum kuat

Program strategis yang dapat dikembangkan

- a. Pengembangan Nursing Leadership berbasis Transformasional
- b. Pelatihan manajerial bagi kepala ruang
- c. Budaya:
 - 1) Patient safety
 - 2) Pelaporan insiden tanpa menyalahkan
- d. Integrasi mutu keperawatan dengan akreditasi RS

Dari implementasi program diatas, indikator Keberhasilan yang dapat dievaluasi adalah sebagai berikut

- a. Kepemimpinan efektif
- b. Budaya keselamatan meningkat
- c. Mutu pelayanan berkelanjutan

6. Pemanfaatan Teknologi & Inovasi Pelayanan Keperawatan

Permasalahan yang melatar belakangi adalah dokumentasi manual & tidak efisien dan beban administrasi tinggi

Program strategis yang dapat dikembangkan

- a. Digitalisasi asuhan keperawatan
- b. Electronic Nursing Record (ENR)
- c. Tele-nursing untuk edukasi & follow-up pasien
- d. Pemanfaatan data untuk evaluasi mutu

Dari implementasi program diatas, indikator Keberhasilan yang dapat dievaluasi adalah sebagai berikut

- a. Efisiensi kerja meningkat
- b. Waktu kontak langsung dengan pasien bertambah
- c. Data mutu lebih akurat

E. Simpulan

Secara umum, *masalah kualitas pelayanan kesehatan dan keperawatan di Indonesia* meliputi pelayanan yang belum cukup profesional & responsif, sehingga kepuasan pasien masih perlu ditingkatkan lagi. Kelelahan tenaga kesehatan dan beban kerja tinggi dapat memengaruhi performa disamping infrastruktur dan fasilitas yang tidak merata, terutama di daerah terpencil. Sementara standar mutu dan akreditasi yang belum diikuti optimal, termasuk beban kerja staf juga ikut berkontribusi terhadap mutu pelayanan kesehatan. Kualitas layanan keperawatan yang belum stabil, juga dapat terkait dengan kepatuhan pada standar, keterampilan, dan komunikasi.

Melihat posisinya, perawat di masyarakat (Puskesmas) berperan strategis sebagai ujung tombak sistem kesehatan nasional, terutama dalam menurunkan angka kesakitan jangka panjang, sementara dalam tatanan pelayanan klinik, Rumah Sakit sangat bergantung pada perawat profesional dan spesialis untuk menjamin mutu layanan dan keselamatan pasien.

F. Referensi

- Altunsoy, C., & Dag, G. S. (2025). Knowledge and competence with patient safety as perceived by nursing students in clinical practice. *BMC Nursing*, 24, Article 767. <https://doi.org/10.1186/s12912-025-03288-2>
- Capriani, D., & Rismayana. (2025). Peran tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan dasar. *Jurnal*

- Dellialvi, M., & Isbandono, P. (2023). Analisis indikator mutu pelayanan kesehatan menurut standar Permenkes Nomor 30 Tahun 2022 di RSUD Waluyo Jati Kraksaan. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, 1(3), 612–627.
- Donabedian, A. (1988). *The quality of care: How can it be assessed?* Journal of the American Medical Association.
- Fauziah, E. S., Putri, T. N., Maulida, H., & Amelia, Y. (2023). Hubungan pengetahuan perawat dengan pemenuhan indikator mutu ruang perawat di RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara. *Getsempena Health Science Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.46244/ghsj.v4i1.3380>
- Fredrik H., Nabil B, Edward C. (2025). Adra Strategic Research, Innovation, and Deployment. Agenda 2025-2027
- Harefa, A.S (2025). Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien: Tinjauan Literatur Tentang Hubungannya dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Penelitian Keperawatan Kontemporer (IKBIS)*. Volume 5 No.5. page: 517-534
- Institute of Medicine (IOM). (2001). *Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century*.
- Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (1999). *Juran's Quality Handbook*
- KARS. (2022). *Standar Akreditasi Rumah Sakit Nasional (SNARS)*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien*.
- Kim, J., & Lee, M. (2025). Evaluating the outcomes of patient safety education programs in nursing education: A scoping review. *BMC Nursing*. <https://doi.org/10.1186/s12912-025-02858-8>
- Lee, et al. *Nurse Managers' Leadership, Patient Safety, and Quality of Care* (systematic review) — membahas hubungan kepemimpinan perawat unit dengan hasil keselamatan pasien dan mutu perawatan.
- Manderos, C.Kawatu, P.A.T, Pangaribuan, M. 2024 Vol. 13 No. 1 (2024): VOLUME 13, No 1. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Unstrat*
- Novitasari, D., Fatimah, D. R., & Dai, A. (2025). Pengaruh kompetensi perawat terhadap kualitas layanan di ruang rawat inap jantung di RSUD Aloe Saboe. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 5293–5302.
- Nurambiya. (2025). Studi tentang kolaborasi antara perawat dan tim kesehatan dalam meningkatkan pelayanan keperawatan. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(3). <https://doi.org/10.59585/bajik.v3i3.844>
- Nursalam. (2020). *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Salemba Medika.

- Ost, E., Muntlin Athlin, Å., Jansson, I., & Björkström, M. E. (2024). The association between nursing work environment and evidence-based practice implementation and quality of care. *International Journal of Nursing Studies*, 149, 104681. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2023.104681>
- Ramadhani, R., Gusrianti, & Yuliza, W. T. (2025). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tenaga kesehatan di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Kota Padang. *Gudang Jurnal Ilmu Kesehatan*, 4(1). <https://doi.org/10.59435/gjik.v4i1.1821>
- Rumadaul, N. S., & Dedi, B. (2025). Pengaruh evaluasi berkala kinerja perawat terhadap mutu pelayanan keperawatan. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 5204–5213. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i2.48825>
- Simamora, R. H. (2021). *Manajemen Keperawatan*. Jakarta : EGC.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Keseh atan
- World Health Organization. (2021). *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030*.

G. Glosarium

A

Advokasi: Upaya aktif perawat untuk melindungi, membela, dan memperjuangkan hak serta kepentingan pasien agar memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan bermutu.

Audit Keperawatan Proses evaluasi sistematis terhadap asuhan keperawatan, meliputi dokumentasi, proses, dan hasil keperawatan untuk menilai kesesuaian dengan standar dan meningkatkan mutu pelayanan.

Audit Klinis: Kegiatan penilaian mutu pelayanan klinis secara menyeluruh (medis, keperawatan, dan profesi lain) dengan membandingkan praktik yang dilakukan terhadap standar klinis yang ditetapkan.

B

Budaya Mutu Nilai, sikap, dan perilaku bersama dalam organisasi kesehatan yang menjadikan mutu dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan pelayanan.

C

Continuing Nursing Education (CNE) : Pendidikan berkelanjutan bagi perawat setelah pendidikan formal untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.

Clinical reasoning: Proses berpikir sistematis perawat dalam mengumpulkan data, menganalisis masalah, menetapkan diagnosis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan.

Clinical Mentoring : hubungan pembimbingan profesional di mana perawat senior membimbing, mendukung, dan mengembangkan kemampuan klinis dan profesional perawat junior secara berkelanjutan.

Clinical Preceptorship: Model pembelajaran klinik dengan pendampingan langsung, di mana perawat preceptor membimbing perawat baru atau mahasiswa dalam praktik nyata di lahan klinik.

D

Digitalisasi asuhan keperawatan: Pemanfaatan teknologi digital untuk perencanaan, pelaksanaan, dan dokumentasi asuhan keperawatan, sehingga pelayanan lebih efisien, akurat, dan terintegrasi.

E

Evidence-Based Nursing (EBN): Pendekatan asuhan keperawatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis perawat, dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan.

Electronic Nursing Record: Sistem dokumentasi keperawatan berbasis elektronik yang mencatat pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi keperawatan secara terstruktur dan aman.

K

Kepuasan pasien: Tingkat perasaan pasien setelah membandingkan harapan dengan pengalaman nyata terhadap pelayanan kesehatan dan keperawatan yang diterimanya.

Kejadian Nyaris Cedera (KNC / Near Miss): Insiden yang berpotensi mencederai pasien tetapi tidak terjadi cedera, baik karena keberuntungan maupun tindakan pencegahan tepat waktu.

Kejadian Tidak Cedera (KTC): Insiden yang terjadi pada pasien tetapi tidak menimbulkan cedera atau dampak klinis, meskipun kesalahan atau kejadian telah berlangsung.

Kejadian Potensial Cedera (KPC): Kondisi atau situasi yang sangat berpotensi menimbulkan cedera, namun belum terjadi insiden pada pasien.

Komunikasi Terapeutik: Komunikasi profesional yang direncanakan secara sadar oleh perawat untuk membantu pasien memahami masalah, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan proses penyembuhan.

M

Mutu: Tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pasien secara aman, efektif, efisien, tepat waktu, dan berpusat pada pasien.

Model Tim: Model pelayanan keperawatan di mana sekelompok perawat dipimpin oleh perawat profesional untuk memberikan asuhan kepada sekelompok pasien.

Model Primary Nursing: Model asuhan keperawatan di mana satu perawat bertanggung jawab penuh terhadap asuhan pasien sejak masuk hingga keluar pelayanan.

Model Fungsional: Model pelayanan keperawatan yang membagi tugas berdasarkan fungsi atau aktivitas tertentu, misalnya perawat khusus obat, perawat perawatan luka.

P

Patients"safety: Sistem pelayanan yang bertujuan mencegah cedera akibat kesalahan tindakan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan.

R

Root Cause Analysis: Metode analisis sistematis untuk mengidentifikasi akar penyebab utama suatu insiden keselamatan pasien agar tidak terulang kembali.

S

Sentinel Event: Kejadian serius dan tidak diharapkan (misalnya kematian tak terduga, cacat permanen) yang menuntut investigasi segera dan mendalam.

T

Tele Nursing: Pemberian asuhan keperawatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi (telepon, video call, aplikasi digital) untuk edukasi, monitoring, dan konsultasi pasien.

CHAPTER 4

KONTRIBUSI GIZI DALAM PENINGKATAN STATUS KESEHATAN PASIEN

Bdn. Ika Putri Ramadhani, M.Biomed

A. Pendahuluan

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah. Di Indonesia, tantangan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan seringkali lebih kompleks dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan kesehatan yang rendah, serta pola hidup yang kurang sehat. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan, budaya, ekonomi, dan aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019).

Identifikasi permasalahan Kesehatan merupakan hal penting yang harus dilakukan agar intervensi yang dilakukan dapat dilakukan dengan tepat sasaran sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendiagnosis masalah-masalah Kesehatan yang berada di lingkungan masyarakat serta upaya menentukan intervensi pemecahan masalah guna meminimalkan terjadinya masalah (Rezal & Nurfadilah, 2024).

Permasalahan kesehatan adalah kesenjangan antara yang terjadi dengan apa yang dikehendaki di bidang kesehatan. Identifikasi permasalahan kesehatan merupakan bagian utama dari siklus pemecahan masalah, dimana siklus pemecahan masalah merupakan proses yang terus menerus yang ditunjukkan untuk pembangunan bidang kesehatan dan proses perbaikan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua komponen masyarakat (Arifa, S. I., Azam, M., Handayani, & Oktia, W. K. 2019).

Penyakit darah tinggi yang lebih dikenal yang mendapat perhatian dari semua kalangan masyarakat, mengingat dampak yang ditimbulkannya baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga membutuhkan penanggulangan jangka panjang yang menyeluruh dan terpadu (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Penyakit hipertensi menimbulkan angka morbiditas (kesakitan) dan mortalitasnya (kematian) yang

tinggi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang timbul akibat adanya interaksi dari berbagai faktor risiko yang dimiliki seseorang (Susanti et al., 2020).

B. Konsep dasar Isi Piringku

Isi piringku merupakan pedoman yang disusun oleh kementerian kesehatan dengan cara mengampanyekan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Dan dalam satu piring setiap kali makan, setengah piring diisi dengan sayur dan buah, kemudian setengah piring lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk. Selain itu, isi piringku ini juga memuat ajakan untuk mengonsumsi 8 gelas setiap harinya, melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari, dan mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan setelah makan. Berdasarkan program dari pemerintah kemenkes RI "isi piringku" adalah upaya untuk mendorong masyarakat mengonsumsi makanan gizi seimbang yang disederhanakan dan digambar secara visual agar mudah dipahami oleh semua masyarakat Indonesia. Untuk porsi dan jenis makanan yang ada dalam isi piringku ini disesuaikan dengan usia dan beban aktivitasnya. Pembagian makanan dalam "isi piringku" adalah $\frac{1}{2}$ porsi piring makan terdiri dari sayur dan buah-buahan, $\frac{1}{4}$ piring makan diisi dengan protein (ikan, ayam, daging, kacang-kacangan dan lainnya), $\frac{1}{4}$ piring lainnya diisi dengan karbohidrat/makanan pokok (biji-bijian utuh, nasi, gandum, jagung, dan lainnya) (Dinkes provinsi Sumatera Barat, 2024).

Menurut "Buku Saku Isi Piringku" yang dikeluarkan oleh health promoting university dari universitas Gadjah Mada bahwa isi piringku ini bertujuan mengkampanyekan pola makan sehat dengan pemenuhan gizi seimbang bagi mahasiswa atau masyarakat umum. Dalam buku saku isi piringku yang dikeluarkan oleh UGM ini menjelaskan bahwa porsi makan dari isi piringku ini, dalam satu piring setiap kita makan, $\frac{2}{3}$ bagian dari setengah piring masing-masing untuk makanan pokok dan untuk sayuran, $\frac{1}{3}$ bagian dari setengah piring masing-masing untuk lauk-pauk dan buah. Kemudian dalam satu hari, kita dianjurkan untuk makan sumber karbohidrat 3-4 porsi, makan sayur 3-4 porsi, buah 2-3 porsi, makanan sumber protein hewani dan nabati 2-4 porsi. Selain itu, kita perlu membatasi jumlah gula 15 dan garam dalam makanan kita, dan rutin mengonsumsi air putih minimal 2 liter setiap hari. Dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. (UGM). Jadi bisa disimpulkan dari ketiga sumber ini bahwa "Isi Piringku" adalah upaya pemerintah kemenkes RI untuk mendorong masyarakat melakukan kebiasaan mengonsumsi makanan yang bergizi dan bernutrisi yang terdiri dari 50% buah dan sayur, dan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Selain itu di "isi piringku" ini pemerintah kemenkes menerapkan beberapa poin tambahan seperti, mencuci tangan sebelum dan

sesudah makan, minum air putih 2 liter perhari, menjaga pola hidup bersih dan sehat dan menjaga tinggi dan berat badan agar tetap ideal (Farida, N., Farida, I. N., & Sahertian, J. 2022).



Gambar 4.1

Isi Piringku

Sumber: Promkes.kemenkes

"Di zaman baru atau New Normal ini sangat penting menjaga imun tubuh, karena disaat imunitas tubuh kita lemah, maka akan banyak kuman-kuman atau virus-virus yang dapat masuk dengan mudahnya ke dalam tubuh dan tentunya hal itu dapat menimbulkan infeksi". (Prof. Dr. Endang L Achadi). Agar imun tubuh kita dapat bekerja dengan optimal, tentunya penting bagi kita perlu untuk menerapkan pola makan sehat 22 setiap harinya. Pemenuhan gizi seimbang ini dapat digambarkan dengan "isi piringku". Karena itu ada beberapa alasan mengapa kita harus menerapkan "isi piringku", yaitu: 1. Mencegah Kondisi Kelebihan Berat Badan Ternyata selain kekurangan gizi, masalah nutrisi pada anak Indonesia adalah kelebihan berat badan. Itulah mengapa kita harus peduli dengan penerapan isi piringku guna memiliki berat badan yang sesuai tidak lebih dan juga tidak kekurangan berat badan yang tentunya hal ini akan dapat membuat kerugian bagi diri kita yaitu seperti berat badan, kekurangan gizi dan lainnya. 2. Mendukung Perumbuhan Tulang Dan Tubuh Kita harus memastikan nutrisi bagi anak-anak kita nutrisi penting itu terdiri dari multivitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak agar nantinya tumbuh fisik anak kita seperti tulang dan giginya dapat terpenuhi dengan baik. 3. Membantu Pertumbuhan Otak Dengan kita menerapkan isi piringku dengan benar, kita semua mendapatkan banyak manfaat, salah satunya

mendukung pertumbuhan otak. F. Dampak Tidak Menerapkan Isi Piringku Setelah kita mengetahui manfaat apa yang akan kita peroleh jika menerapkan “isi piringku” ini kita tentunya harus juga mengetahui apa yang akan menjadi dampak jika kita tidak menerapkan “isi Piringku” pada kehidupan sehari-hari kita. Porsi Isi Piringku terdiri makanan pokok yakni sumber karbohidrat dengan porsi 2/3 dari 1/2 piring. Lalu dilengkapi dengan lauk pauk dengan porsi 1/3 dari 1/2 piring, untuk setengah piring lainnya diisi dengan proporsi sayur-sayuran dengan porsi 2/3 dan buah-buahan dengan porsi 1/3 (Kementerian kesehatan RI, 2018).

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Isi Piringku. Padahal dengan menerapkan Isi Piringku, stunting bisa dicegah sejak awal. Tak hanya menerapkan Isi Piringku, 23 para remaja diharapkan dapat menerapkan gaya hidup sehat seperti mencuci tangan pakai sabun, berolahraga, memantau berat badan. Dengan cara ini, maka remaja masa kini tidak hanya menjaga kesehatan sendiri, tapi juga akan berdampak di masa yang akan datang, dimana mereka akan melahirkan generasi yang sehat dan bebas stunting. Mengonsumsi nasi dalam jumlah berlebih bisa berdampak buruk dan memunculkan masalah kesehatan. Di sisi lain juga ternyata bagi penderita penyakit atau gangguan tertentu, nasi justru bisa memperburuk kondisi kesehatannya. Karena itu banyak tenaga kesehatan yang menyarankan untuk lebih variatif dalam mengonsumsi makanan pokok seperti singkong, sagu, jagung dan ubi jalar. Selanjutnya dampak jika kita tidak mengonsumsi sayur adalah menurunnya daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang baik dibutuhkan untuk memerangi radikal bebas, virus, bakteri, dan kuman penyakit lainnya. Selain sayur-sayuran ada juga dampak jika kita tidak mengonsumsi buah-buahan adalah jika dalam jangka pendek mungkin dapat sering mengalami gangguan pencernaan, seperti sembelit, diare dan wasir. Namun, dalam jangka panjang bisa juga meningkatkan risiko anemia, kardiovaskular, hingga kanker. Kemudian ada lauk-pauk dimana lauk-pauk adalah pendamping makanan pokok yang berfungsi untuk sumber zat pembangun tubuh, biasanya memiliki kandungan protein yang berguna sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Jika tidak dikonsumsi maka protein tidak dapat digunakan untuk sumber cadangan energi dan sistem kekebalan tubuh. Tidak hanya makanan, panduan makan gizi seimbang dari “isi Piringku” juga meliputi minum air putih 8 gelas per hari, jika tidak menerapkan maka dampaknya begitu besar yaitu tidak dapat memelihara fungsi ginjal, dehidrasi, risiko kanker kandung kemih, pencernaan tidak lancar, kulit menjadi rusak dan tidak dapat mengontrol kalori. Selain makan dan minum ada juga aktivitas fisik, dan tentunya kita semua tau dampak apa yang akan terjadi jika kita kurang dalam melakukan aktivitas fisik ini, dampak yang akan terjadi misalnya dapat 24 menyebabkan berat badan yang

tidak terkontrol dan hal ini tentunya berpengaruh bagi kesehatan tubuh kita karena nantinya tubuh kita akan cepat lemas, obesitas, kekurangan dan kelebihan berat badan, nafsu makan yang tidak normal, dan masih banyak dampak buruk lainnya jika kita tidak melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari kita (Kementerian kesehatan RI, 2018).

C. Kandungan dan Fungsi zat Gizi

Zat gizi ialah unsur yang penting didalam nutrisi dikarenakan zat gizi tersebut bisa memberikan fungsi tersendiri kepada nutrisi, kebutuhan nutrisi tidak akan berfungsi secara optimal jika tidak mengandung beberapa zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, samalahnya juga zat gizi yang cukup pada kebutuhan nutrisi dapat memberikan nilai yang optimal. Ada beberapa komponen zat gizi yang dibutuhkan pada nutrisi bayi dan anak yang jumlahnya sangat berbeda untuk setiap umur, umumnya zat gizi dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan makro dan golongan mikro: untuk zat gizi golongan makro terdiri dari kalori dan H₂O (air), untuk kalori berasal dari karbohidrat, protein dan lemak, sedangkan kelompok gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Berikut adalah penjelasan dari golongan zat gizi makro dan mikro:

1. Karbohidrat

Karbohidrat ialah sumber energi yang tersedia dan mudah didapat disetiap makanan, dan zat gizi ini harus tersedia dalam jumlah yang cukup karena apabila terjadi kekurangan karbohidrat sebanyak 15% dari kalori yang ada, dapat menyebabkan kelaparan dan berat badan menurun. Sebaliknya, apabila jumlah kalori yang tersedia atau yang berasal dari karbohidrat dalam jumlah yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan berat badan (obesitas). Sumber karbohidrat yang cukup didapatkan dari susu, padi-padian, buah-buahan, sukrosa, sirup, tepung, dan sayur-sayuran. Kebutuhan nutrisi tidak bisa berfungsi secara optimal kalau tidak mengandung beberapa zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, demikian juga zat gizi yang cukup pada kebutuhan nutrisi akan memberikan nilai yang optimal (Putri, H., Suryarini, Y., & Roza, D. 2023).



Gambar 4.2
Karbohidrat
(Sumber : <https://yankes.kemkes.go.id>)

2. Lemak

Ialah zat gizi yang berfungsi dalam pengangkut vitamin A, D, E, K yang larut dalam lemak. Komponen lemak terdiri atas lemak alamiah sebanyak 98 % diantaranya trigliserida, dan gliserol sedangkan 2% nya sisanya asam lemak bebas yang diantaranya adalah na monogliserida, digliserida, kolesterol dan fosfolipid termasuk lesitin, sefalin, sfingomielin dan serebrosid. Lemak ini ialah sumber yang kaya akan energi, sebagai pelindung organ tubuh seperti pembuluh darah, bot saraf, organ dan lain-lain terhadap suhu tubuh, dapat membantu rasa kenyang (penundaan waktu pengosongan lambung), komponen lemak dalam tubuh harus tersedia dalam jumlah yang cukup sebab kekurangan lemak akan menyebabkan terjadinya perubahan kulit 30 khususnya asam linoleat yang rendah, berat badan kurang. Sumber lemak yang cukup dapat diperoleh dari susu, mentega, kuning telur, daging, ikan, keju, kacang-kacangan, dan minyak sayu (Putri, H., Suryarinilsih, Y., & Roza, D. 2023).



Gambar 4.3 Lemak
(Sumber : <https://m.klikdokter.com>)

3. Protein

Protein ialah zat gizi dasar yang berfungsi untuk pembentukan protoplasma sel, selain itu tersedianya protein dalam jumlah yang cukup penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel jaringan dan sebagai larutan untuk keseimbangan osmotik, Protein ini terdiri dari 24 asam amino diantaranya sembilan asam amino esensial seperti: threonin, valin, leusin, WE isoleusin, lisin, triptofan, fenilalanin, metionin, dan histidin. Sedangkan selebihnya ialah asam amino nonesensial. Jumlah protein dalam tubuh tersebut harus tersedia dalam jumlah yang cukup, karena apabila jumlahnya kurang dapat menyebabkan kelemahan, edema, kwashiorkor (apabila kekurangan protein saja), atau marasmus (jika kekurangan protein dan kalori) komponen zat gizi protein banyak diperoleh dari susu, telur, daging, ikan, unggas, keju, kedele, kacang, buncis, dan padi-padian (Ulya, Z., Iskandar, A., & Asih, F. T. 2017).



Gambar 4.4 Protein
(Sumber: <https://www.rsipati.com>)\

4. Air

Air ialah kebutuhan nutrisi yang sangat penting, mengingat kebutuhan air pada bayi relatif tinggi 75-80 % dari berat badan dibandingkan dengan orang dewasa yang hanya 55-60 %. Air bagi tubuh dapat berfungsi sebagai pelarut untuk perlukaan seluler, sebagai medium untuk ion, transport nutrisi dan produk buangan dan pengaturan suhu tubuh. Sumber zat air dapat diperoleh dari air dan semua makanan.

5. Vitamin

Vitamin adalah senyawa organik yang 15 digunakan untuk mengkatalisator metabolisme sel yang dapat berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan dan dapat mempertahankan organisme. Vitamin yang dibutuhkan diantaranya ialah:

- a. Vitamin A (retinol) harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan mempunyai pengaruh didalam kemampuan fungsi mata serta pertumbuhan tulang dan gigi dan dalam pembentukan maturasi epitel, vitamin ini dapat diperoleh dari hati, minyak ikan, susu, kuning telur, margarin, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan.
- b. Vitamin B kompleks (thiamin) ialah vitamin yang larut dalam air akan tetapi tidak larut dalam lemak, yang dapat menyebabkan penyakit beri- beri, kelelahan, anoreksia, konstipasi, nyeri kepala, insomnia, takikardia, edema, asam piruvat dalam darah akan meningkat apabila tersedia dalam jumlah yang kurang. Kebutuhan vitamin ini dapat diperoleh dari dalam hati, daging, susu, padi, biji-bijian, kacang, dan lain-lain.
- c. Vitamin B2 (riboflavin) merupakan vitamin yang dapat sedikit larut dalam air, vitamin ini harus tersedia dalam jumlah yang cukup, bila tidak mencukupi dapat menyebabkan fotofobia, penglihatan kabur, gagal tumbuh. Vitamin ini dapat ditemukan pada susu, keju, hati, daging, telur, ikan, sayuran hijau dan nasi.
- d. Vitamin B12 (sianokobalamin) merupakan vitamin yang sedikit larut dalam air. Pada vitamin ini sangat baik untuk maturasi sel darah merah dalam sumsum tulang, pengaruh kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan anemia dan vitamin ini dapat diperoleh dari daging organ, ikan, telur, susu dan keju.
- e. Vitamin C (asam askorbat) merupakan vitamin yang larut dalam air yang mudah dioksidasi dan dipercepat oleh panas dan cahaya. Kekurangan vitamin ini dapat thshmenyebabkan lamanya proses penyembuhan luka, New vitamin ini dapat tersedia dalam tomat, buah semangka, kubis, sayur-sayuran hijau.
- f. Vitamin D merupakan vitamin yang dapat larut dalam lemak dan akan stabil dalam suasana panas, vitamin ini berguna dalam mengatur penyerapan dan agpengendapan kalsium dan fosfor dengan memengaruhi Vet permeabilitas membran usus, mengatur kadar alkali fosfatase serum, kekurangan vitamin ini akan menyebabkan pertumbuhan jelek dan osteomalasia. Vitamin ini dapat diperoleh dari dalam susu, margarin, minyak ikan, pemaparan cahaya matahari atau sumber ultraviolet lain.
- g. Vitamin E merupakan vitamin yang larut dalam lemak dan tidak stabil terhadap sinar ultraviolet yang dapat berfungsi dalam meminimalkan oksidasi

karoten, vitamin A dan asam linoleat serta menstabilkan membran apabila terjadi kekurangan dapat menyebabkan hemolisis sel darah merah pada bayi prematur dan akan menyebabkan kehilangan keutuhan syaraf. Vitamin E dapat diperoleh dari minyak, biji-bijian, dan kacang-kacangan.

- h. Vitamin K merupakan vitamin yang larut dalam lemak yang dapat berfungsi sebagai pembentuk protombin, faktor koagulasi II, VII, IX, X yang harus tersedia dalam tubuh yang cukup, apabila terjadi kekurangan dapat menyebabkan perdarahan dan metabolisme tulang yang tidak stabil. Vitamin ini tersedia dalam sayuran berdaun hijau, daging dan hati.

6. Mineral

Mineral ialah komponen zat gizi yang tersedia dalam kelompok mikro, yang terdiri dari kalsium, klorida, khromium, kobalt, tembaga, fluorin, yodium, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium. Natrium, sulfur dan seng. Kesemuanya harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Mineral Kalsium adalah mineral yang berguna untuk pengaturan struktur tulang dan gigi, kontraksi otot, iritabilitas syaraf, koagulasi darah, kerja jantung dan produksi susu. Apabila kekurangan kalsium dapat mengakibatkan mineralisasi tulang dan gigi yang jelek, osteomalasia, osteoporosis, rakhitis dan gangguan pertumbuhan. Tersedianya kalsium ini dapat diperoleh dari susu, keju, sayur-sayuran berdaun hijau, kerang. Klorida sangat berguna dalam pengaturan osmotik, keseimbangan asam basa, yang tersedia dalam garam, daging, susu, dan telur. Khromium berguna untuk glikemia dan metabolisme insulin yang terdapat dalam ragi, tembaga yang berguna untuk pembentukan sel darah merah, pembentukan hemoglobin, penyerapan besi, kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, osteoporosis. Fluor adalah mineral yang berguna untuk struktur gigi dan tulang yang bila tersedia dalam jumlah sedikit menyebabkan karies gigi. 34 Sumber fluoride ditemukan di air, makanan laut, tumbuhan. Mineral yodium yang bila kurang dapat menyebabkan penyakit gondok, mineral tersebut terdapat pada garam. Besi merupakan mineral yang merupakan struktur dari hemoglobin untuk pengangkutan CO₂ dan O₂ (Farida, N., Farida, I. N., & Sahertian, J. 2022).

D. Gizi Masyarakat Dan Gizi Kuliner

1. Konsep Dasar Gizi Masyarakat

Apa itu gizi masyarakat?

Gizi masyarakat adalah studi yang berkaitan dengan promosi kesehatan melalui tindakan pencegahan penyakit terkait gizi di masyarakat serta intervensi atau program yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah gizi tersebut.

Profesional kesehatan memerlukan pendekatan yang multidisiplin, terorganisir serta berskala besar karena berkaitan dengan populasi masyarakat yang besar.

Oleh karena itu, gizi masyarakat bersifat multidisiplin dan dibangun di atas dasar perpaduan ilmu gizi, ilmu sosial dan ilmu biologi, perilaku, serta manajerial. Berbeda dengan bidang ilmu gizi lain seperti dietetik atau ilmu gizi klinis, seorang ahli gizi masyarakat dituntut memiliki kompetensi untuk mengatasi masalah gizi masyarakat terutama pada kelompok yang rentan. Gizi masyarakat juga dijelaskan sebagai suatu ilmu dan seni untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit serta memperpanjang usia harapan hidup, melalui upaya-upaya preventif yang terorganisir dalam masyarakat (Farida, N., Farida, I. N., & Sahertian, J. 2022).

2. Masalah gizi masyarakat

Salah satu penentu kesehatan seseorang adalah makanan yang dikonsumsi. Apabila setiap harinya seseorang cukup mengkonsumsi sumber energi dan zat gizi yang sesuai dengan kebutuhannya, maka orang tersebut berada dalam tingkat kesehatan gizi yang optimum. Akan tetapi, jika seseorang mengalami kekurangan atau kelebihan zat gizi tertentu dalam jangka waktu yang lama akan berakibat buruk terhadap kesehatan. Keadaan ini disebut salah gizi (malnutrition) jika yang terjadi adalah gizi kurang, sebaliknya jika yang terjadi adalah kelebihan gizi, maka disebut sebagai gizi lebih (overnutrition).

Seorang tenaga profesional dibidang gizi harus mampu mempromosikan dengan baik upaya-upaya pencegahan masalah gizi pada populasi rentan, dimulai dari identifikasi jenis dan besaran masalah gizi, memahami mengapa dan bagaimana suatu masalah gizi terjadi serta mampu merencanakan strategi serta mengambil tindakan intervensi yang tepat dan akhirnya mampu melakukan evaluasi terhadap dampak intervensi terhadap populasi tersebut. Dalam kelompok masyarakat, masalah gizi tidak hanya terkait dengan makanan akan tetapi terkait dengan berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi (ketersediaan sumber daya keuangan), keterjangkauan terhadap fasilitas/pelayanan kesehatan, kebijakan pertanian (produksi dan harga berbagai bahan makanan), faktor

sosial budaya setempat serta kemauan politik. Ada beberapa permasalahan gizi di Indonesia yang sudah terkendali melalui program pemerintah maupun yang belum. Permasalahan gizi tersebut meliputi :

Kurang Vitamin A (KVA)

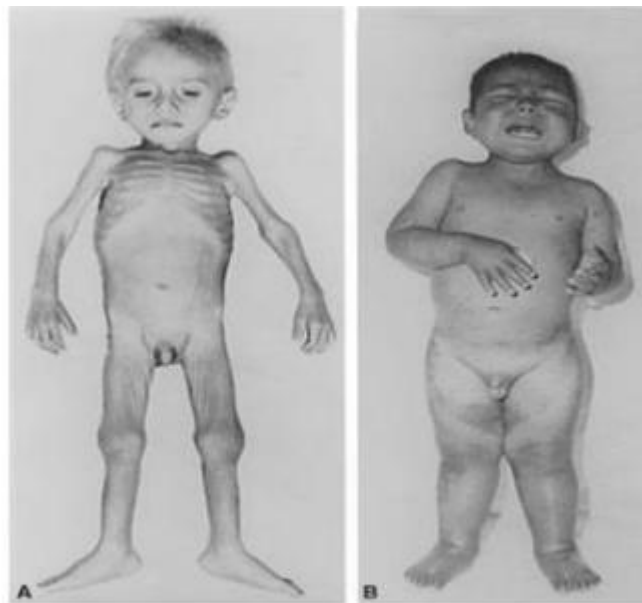
Kekurangan Vitamin A (KVA) subklinis ditandai dengan kadar vitamin A dalam darah yang rendah dan hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan laboratorium.

Vitamin A diperlukan untuk pertumbuhan dan kekebalan tubuh, penglihatan yang baik serta pemeliharaan epitel yang sehat. Kekurangan vitamin A berdampak pada

kondisi rabun senja hingga kebutaan total jika tidak mendapat penanganan yang cepat. KVA juga menurunkan kekebalan sehingga meningkatkan risiko infeksi penyakit. Masalah KVA adalah salah satu masalah gizi yang menyerupai fenomena gunung es yang tampak sedikit dipermukaan tapi sebenarnya merupakan permasalahan yang serius dan membutuhkan perhatian yang besar.

3. KEP (Kurang Energi Protein)

KEP dapat ditemukan di negara maju meskipun jumlahnya tidak sebanding dengan yang ditemukan pada negara berkembang. KEP disebabkan oleh asupan zat gizi makro (energi dan protein) yang tidak memadai. Kurangnya asupan energi yang parah dikenal sebagai marasmus sedangkan kurang asupan protein dikenal sebagai kwashiorkor. Risiko terbesar kejadian KEP adalah anak-anak namun tidak menutup kemungkinan KEP dapat terjadi pada orang dewasa, dan juga pada kondisi penyakit tertentu misalnya AIDS atau TB. Pengukuran antropometri seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala diperlukan untuk menilai status KEP pada seseorang.



Gambar 1. A: Wasting parah pada bayi dengan marasmus. B: Edema dan lesi kulit pada anak berusia 3 tahun dengan kwashiorkor.

Gambar 4.4
Anak dengan Kurang Energi Protein

a. GAKI

Istilah ini mengacu pada kondisi kesehatan yang sangat rendah karena asupan yodium yang tidak memadai. Kurangnya asupan yodium menyebabkan kelenjar tiroid tidak dapat memproduksi hormon dalam jumlah yang cukup. Manifestasi paling umum dari kondisi kekurangan yodium pada orang dewasa adalah pembesaran pada tiroid yang dikenal sebagai gondok, sedangkan pada anak-anak menyebabkan kretinisme. Kekurangan yodium saat hamil dapat menyebabkan keterbelakangan mental hingga kelainan bawaan pada janin yang bersifat permanen atau tidak dapat diubah.

b. Anemia Defisiensi Besi (ADB)

ADB disebabkan karena adanya penurunan produksi hemoglobin sehingga kadar hemoglobin dalam darah rendah. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gejala tergantung dari tingkat penurunan hemoglobin. Beberapa gejala yang dapat muncul diantaranya adalah sesak napas ketika melakukan aktifitas fisik, mudah merasa lelah dan lesu. Manifestasi ADB meliputi terlihat pucat, kuku, lidah dan langit-langit lunak. Pada anak-anak, mudah mengalami gangguan konsentrasi. Kelompok yang rentan adalah anak usia sekolah, remaja putri, wanita usia subur dan ibu hamil.

c. Gizi kurang

Gizi kurang dapat terjadi sejak lahir, ditandai dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) atau kurang dari 2500 gram (2,5kilogram). Bayi BBLR biasanya memiliki kondisi kesehatan yang buruk dan rentan mengalami infeksi. Beberapa risiko yang ditimbulkan pada kondisi gizi kurang diantaranya anemia, kurang vitamin, osteoporosis, kekebalan tubuh menurun, hingga masalah pada pertumbuhan dan perkembangan.

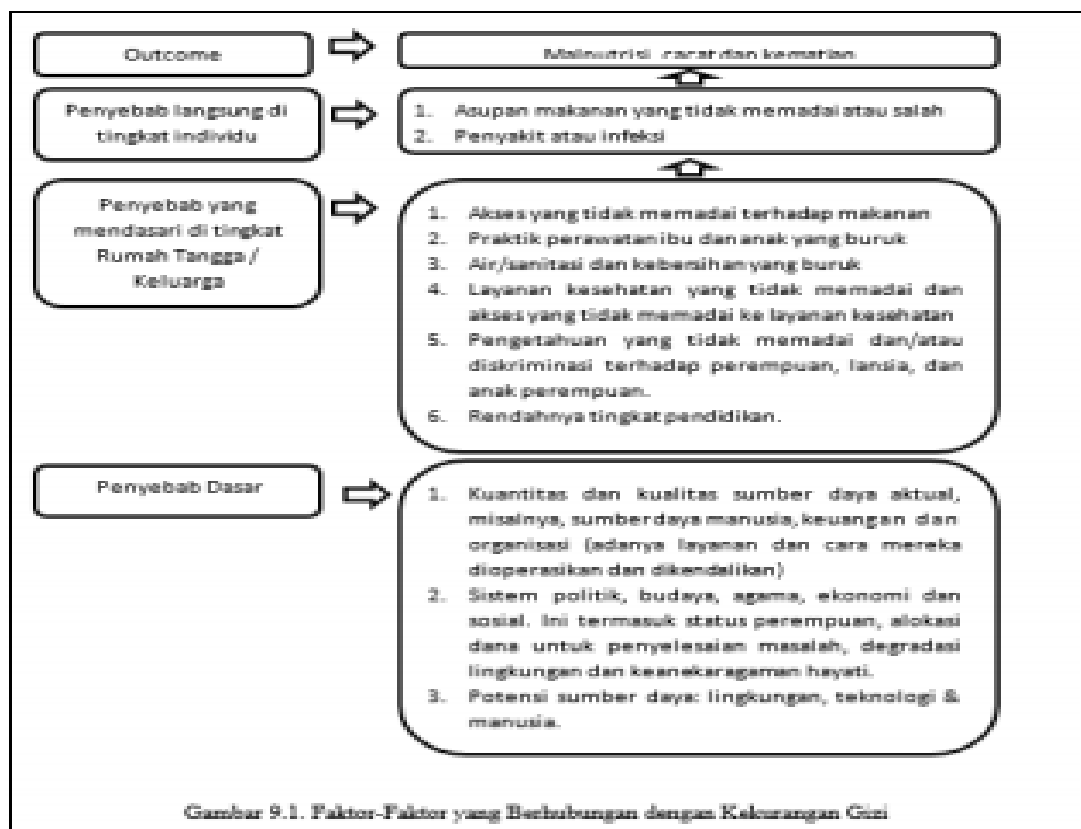
d. Obesitas

Obesitas atau kegemukan dapat terjadi karena energi yang masuk dan energi yang keluar tidak seimbang. Jika beberapa masalah gizi lain disebabkan karena kekurangan nutrisi tertentu, pada kejadian obesitas masalah gizi disebabkan adanya asupan kalori yang melebihi kebutuhan seseorang dan ditambah lagi minimnya aktifitas/gerak. Obesitas pada anak meningkatkan risiko komplikasi ortopedik (tulang) serta gangguan pernafasan.

e. Stunting

Salah satu masalah gizi di Indonesia yang belum terselesaikan hingga sekarang adalah stunting. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang sesuai kebutuhan dalam waktu lama. Stunting dapat terjadi sejak dalam kandungan dan akan terlihat saat anak berusia 2 tahun yang ditandai dengan tubuh pendek, postur anak lebih kecil dari seusianya meskipun proporsi

tubuh cenderung normal, serta pertumbuhan tulang lebih lambat. Pada beberapa kalangan masyarakat, stunting dianggap normal dan dikaitkan dengan keturunan. Akan tetapi, risiko yang dapat disebabkan oleh stunting diantaranya terhambatnya perkembangan otak, risiko pengembangan penyakit tidak menular, hingga menurunkan produktifitas di usia muda. Tindakan pencegahan stunting diantaranya adalah memenuhi asupan gizi sejak awal kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan anak. Pemberian ASI eksklusif serta konsumsi gizi seimbang pada bayi dan balita juga perlu diperhatikan (Rezal, F., & Nurfadilah H, S. 2024).



E. Strategi/intervensi untuk mengatasi masalah gizi

Untuk menghadapi masalah gizi masyarakat, berbagai strategi dapat dilakukan dan secara luas dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Strategi diet atau strategi pangan

Strategi diet atau strategi pangan adalah strategi yang menggunakan makanan untuk mengatasi masalah gizi, misalnya dengan meningkatkan ketersediaan makanan tinggi mikronutrien untuk mengatasi defisiensi mikronutrien. Diversifikasi pangan, modifikasi diet, fortifikasi pangan serta pendidikan gizi termasuk jenis strategi pangan. Strategi ini memiliki keuntungan yaitu berkelanjutan serta mempunyai manfaat jangka panjang. Selain itu,

strategi ini lebih hemat biaya, dapat disesuaikan dengan budaya daerah setempat serta minim risiko toksisitas/overdosis jika dibandingkan pendekatan dengan obat-obatan.

2. Pendekatan berbasis gizi dan obat-obatan Pendekatan ini menggunakan suplemen gizi yang didistribusikan pada kelompok rentan atau kelompok beresiko. Pemberian vitamin A, tablet Fe dan asam folat adalah bagian dari pendekatan berbasis gizi dan obat-obatan. Beberapa kekurangan dari strategi ini adalah bersifat jangka pendek, relatif mahal serta jangkauannya terbatas, dimana dalam satu kelompok sasaran pasti memiliki lebih dari satu masalah gizi yang bervariasi dan memerlukan penanganan yang tidak sama (Soesanto, E. 2012).

Konsep Dasar Gizi Kuliner

Gizi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan. Sedangkan kuliner yang berasal dari bahasa inggris *culinary* berhubungan dengan kegiatan memasak, seni membuat masakan atau seni kuliner yang dimulai dari memilih bahan makanan, mengolah/memasak hingga menyajikan makanan dengan tampilan yang menarik. Orang yang bertugas membuat masakan dikenal sebagai chef. Dengan demikian, gizi kuliner dapat berarti :

1. Ilmu dan seni untuk menerapkan prinsip ilmu gizi dengan kombinasi pengetahuan ilmiah (sains) tentang makanan, yang ditampilkan melalui penguasaan ketrampilan dibidang kuliner.
2. Penggabungan ilmu gizi dan ilmu pengetahuan ilmiah (sains) tentang makanan akan menciptakan hidangan makanan yang tidak hanya enak, tapi juga sehat dan bergizi sehingga menghasilkan perilaku makan yang sehat. Hal-hal yang dipelajari didalam gizi kuliner secara luas berkaitan dengan pemahaman dan kegiatan membuat makanan yang terdiri atas ; pemilihan bahan makanan, persiapan bahan makanan sebelum diolah, penyimpanan bahan makanan sebelum dan sesudah di masak, pengolahan dan pemasakan makanan, penggunaan alat masak hingga alat untuk menyajikan makanan, penyajian makanan yang baik serta higienis dan sesuai dengan prinsip kesehatan (Soesanto, E. 2012).

F. Konsep Memasak Sehat Dan Menyehatkan

Tenaga profesional gizi yang mempelajari tentang kuliner diharapkan tidak hanya dapat membuat masakan yang lezat tetapi juga tetap memperhatikan aspek gizi dari makanan yang dimasak. Untuk menerapkan konsep memasak yang sehat (*Healthy Cooking*) maka perlu memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Kenali sifat dari setiap bahan makanan, misalnya ; kandungan gizinya, fungsi bahan makanan tersebut dalam suatu masakan serta komponen bioaktif yang baik bagi tubuh.
2. Pahami berbagai jenis teknik memasak. Hal ini karena masing-masing teknik memasak akan memberi hasil masakan yang berbeda, baik dari segi tampilannya atau juga efek terhadap zat gizi yang terkandung dalam bahan makanan.
3. Memasak yang sehat bukan saja tentang menyajikan makanan bergizi, tapi juga aman, saniter serta menarik. Pahami cara pemilihan bahan yang baik, cara perlakuan persiapan memasak yang baik hingga cara penghidangan makanan.

G. Jenis Penyelenggaraan Gizi Kuliner

Penyelenggaraan gizi kuliner secara umum terdiri dari beberapa komponen yang saling menunjang dan saling terkait. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah ;

1. Pengadaan makanan

Komponen pengadaan makanan memiliki beberapa subkomponen diantaranya adalah :

- a. Perencanaan bahan makanan hingga perencanaan hidangan
- b. Pengecekan serta penyimpanan bahan makanan
- c. Pengolahan bahan makanan yang dimulai dari persiapan bahan makanan, hingga proses memasak dengan berbagai teknik memasak. 2 hal yang menjadi kunci dalam memasak yang baik adalah besar (kualitas) panas yang diberikan serta lama (waktu) pemberian panas.
- d. Berbagai teknik memasak secara garis besar berdasarkan sumber panas yang diberikan terdiri dari 3 kategori, diantaranya adalah;
 - 1) Memasak dengan panas kering (*dry heat cooking*) diartikan sebagai panas yang ditransferkan ke makanan tidak menggunakan air/uap tapi menggunakan alat yang panas dan udara yang panas. Beberapa contoh teknik memasak ini adalah; *baking* dan *roasting* (oven), *grilling* dan *broilling* serta *barbecue*, menyangrai, *microwave cooking*.

- 2) Memasak dengan panas basah (*moist heat cooking*), metode ini menggunakan cairan sebagai pengantar panas ke makanan. 154 Beberapa contoh teknik memasak ini adalah; merebus (*boilling*), *simmering* (memasak diatas api kecil), *blancing* (blansir), *stewing* (mengungkep), *poaching* (memasak dengan air hampir mendidih), *steaming* (mengukus), *bain marie* (mengetim), *pressure cooking* (memasak dengan panci ditekan).
- 3) Memasak dengan minyak atau lemak (*fat cooking*), metode ini menggunakan media minyak/lemak panas baik dalam jumlah banyak maupun sedikit. Beberapa contoh teknik memasak ini adalah; *frying* (menggoreng), *sauteeing* (menumis), *shallow frying* (memasak dengan minyak sedikit pada wajan ceper), *braising* (kombinasi lemak, cairan dan panas kering), *flambeying* (memberikan api pada saat memasak).

Setiap metode yang dipakai akan memberikan hasil akhir yang berbeda antara satu dengan yang lain. Pada metode panas kering hasil masakan akan berkurang kadar airnya, berat makanan juga akan berkurang jika dibandingkan dengan berat sebelum dimasak, makanan menjadi kering, kecoklatan dan jika dibiarkan terlalu lama akan menjadi keras dan alot. Sebaliknya pada penggunaan metode panas basah, makanan menjadi lebih lunak, volume dan beratnya bertambah, mudah di makan karena teksturnya lunak, dapat mengurangi kerusakan zat gizi dalam makanan. Pada metode minyak, minyak mempunyai titik didih diatas 100°C, sehingga memasak makanan dengan minyak panas yang tinggi akan menyebabkan kadar air makanan berkurang, makanan lebih gurih dan nilai energi akan bertambah. Hasil makanan akan menjadi lebih kering dan berkembang.

2. Pengadaan tempat

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan komponen pengadaan tempat diantaranya adalah:

- a. Area dapur perlu dirancang secara efisien dan tempat pembuangan limbah harus memenuhi syarat bersih, sehat dan hygienis.
- b. Letak dapur berada didalam bangunan induk atau diluar
- c. Luas tempat disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan dilokasi, jumlah serta volume bahan makanan yang akan diolah.

Rencana urutan kerja/kegiatan di dapur meliputi :

Penerimaan Bahan Makanan → penyimpanan (*Storage*) → persiapan (*food preparation*) → pemasakan (*cooking*) → mengatur makanan → menghidangkan (*serving*) → makan (*dining*) → membersihkan (*washing up*) → membuang sisa makanan (*waste disposal*)

- d. Bahan bangunan mudah dibersihkan, anti lalat, tidak mudah terbakar, tahan benturan serta menarik.
- e. Berwarna terang, dapat menangkap serta merefleksikan kembali sinar dengan optimal.

Tabel 9.1. Warna berdasarkan kemampuan untuk merefleksikan sinar

Warna	% Refleksi	Warna	% Refleksi
Putih	89	Putih gading	74
Krem	72	Keabu-abuan	65
Kekuning-kuningan	64	Hijau muda	60
Abu-abu muda	55		

- f. Dapur diatur agar ada kesesuaian urutan/aliran bahan makanan yang dimulai dari penyimpanan persiapan pencucian pemasakan penghidangan atau pendistribusian
 - g. Bentuk dapur dapat beragam, diantaranya ada bentuk lorong, U, L atau bentuk garis.
3. Pengadaan biaya
- Pengadaan biaya perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya :
- a. Pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan yang direncanakan
 - b. Memperhatikan daya beli konsumen
 - c. Dipengaruhi oleh tempat/daerah, keadaan, musim, besar porsi dan bentuk makanan.
 - d. Biaya pengeluaran (*total cost*) + laba (*profit*) = harga jual Yang termasuk biaya pengeluaran, meliputi :
 - 1) Biaya pengadaan bahan makanan
 - 2) Biaya transportasi
 - 3) Upah tenaga kerja
 - 4) Biaya sewa alat, dan biaya lain-lain

4. Pengadaan tenaga

Pada komponen pengadaan tenaga, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah :

- a. Penyelenggaraan gizi kuliner secara massal memerlukan suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang tenaga profesional.
- b. Pimpinan tersebut haruslah mempunyai pengetahuan yang mumpuni tentang ilmu gizi dasar, pengetahuan tentang bahan makanan, cara penyimpanannya, pengolahan, penghidangan hingga evaluasi dan pembuatan laporan.
- c. Tenaga penyelenggara harus bersih, rapi, sehat dan higienis.

5. Pengadaan alat

Pengadaan alat kuliner dapat dilakukan dengan memperhatikan jenis-jenis peralatan kuliner, diantaranya adalah :

- a. Alat untuk mengolah bahan makanan
- b. Alat untuk menghidangkan makanan
- c. Alat untuk makan dan minum
- d. Peralatan elektronik dapur

Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penempatan alat adalah :

- a. Tempatkan alat di tempat yang tepat sehingga mudah diambil
- b. Alat yang sering dipakai ditaruh pada tempat yang mudah diambil
- c. Alat yang jarang dipakai dapat disimpan pada tempat penyimpanan
- d. Tempat penyimpanan barang dibuat tidak terlalu tinggi/dapat dijangkau
- e. Gudang tidak terlalu jauh dari tempat pengolahan makanan
- f. Tempat pencucian atau sumber air berada pada posisi yang strategis atau pada bagian tengah
- g. Peralatan memasak diletakkan didekat kompor

H. Cita Rasa dan Penampilan

Cita rasa pada makanan dapat timbul karena adanya rangsangan pada indrapenciuman, penglihatan serta pengecap manusia. Makanan yang akan dihidangkan harus memenuhi syarat yaitu citarasa yang memberi kepuasan bagi yang mengkonsumsinya, serta aman dari zat berbahaya atau mikroba. Aspek utama dalam citarasa suatu makanan adalah penampilan ketika dihidangkan serta rasa makanan tersebut ketika dimakan. Menurut Soesanto (2012) penampilan makanan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Warna makanan

Perubahan warna pada makanan misalnya perubahan warna sayur atau buah yang pucat/tidak segar akan mengurangi bahkan menghilangkan selera makan. Ini dapat dicegah dengan teknik pemasakan atau dengan pemberian warna.

2. Bentuk makanan

Makanan dapat disajikan dalam beberapa bentuk diantaranya ; disajikan dalam bentuk aslinya, dibentuk dengan cara mengiris atau memotong bahan makanan, menyerupai bentuk aslinya tapi bukan bahan makanan yang utuh, serta dalam bentuk sajian khusus misalnya nasi tumpeng.

3. Tekstur makanan

Konsistensi/tekstur makanan dapat mempengaruhi sensitivitas indra pengecap, misalnya makanan yang padat/kental dapat memberi rangsangan lambat terhadap indera pengecap. Tekstur/konsistensi dapat dipengaruhi oleh cara memasak serta lama memasak.

4. Porsi makanan

Untuk penentuan porsi makan, sebaiknya memperhatikan beberapa hal, diantaranya ; ukuran/porsi dapat mempengaruhi penampilan makanan, ukuran juga mempengaruhi perencanaan termasuk perencanaan untuk pengadaan dan pemakaian bahan pangan, penggunaan alat, hingga mempengaruhi biaya yang akan dianggarkan.

5. Cara penyajian makanan

Dalam tahap penyajian makanan, sebaiknya perlu memperhatikan beberapa hal yaitu pemilihan alat yang akan dipakai untuk menyajikan makanan, tampilan/susunan makanan ditempat penyajian, serta penghias untuk mempercantik hidangan. Sedangkan rasa makanan ditentukan oleh indera pengecap dan indera pencium. Rasa makanan ditentukan oleh beberapa komponen berikut ini:

a. Aroma makanan

Aroma terbentuk dari menguapnya senyawa-senyawa pada makanan akibat reaksi enzimatis/nonenzimatis, dimana asam amino yang terbentuk bereaksi dengan gula pereduksi. Faktor yang mempengaruhi aroma makanan diantaranya proses pemasakan pada suhu yang tinggi atau penggunaan aroma sintetis pada makanan, misalnya aroma buah.

b. Keempukan makanan

Makanan yang empuk dapat meningkatkan intensitas rangsangan sehingga makanan empuk akan lebih nikmat daripada makanan keras. Cara pengolahan atau pemasakan dapat mempengaruhi keempukan makanan.

Penggunaan alat modern, atau penambahan bahan tertentu juga dapat membuat makanan menjadi lebih empuk.

c. Bumbu yang dipakai serta bahan penyedap

Penggunaan bumbu pada masakan dapat membangkitkan selera dan memberi rasa khas pada makanan. Bumbu masak yang dipakai umumnya dari golongan rempah-rempah. Selanjutnya rasa pada makanan akan diperbaiki atau ditunjang dengan tambahan penyedap seperti sledri, kecap, kemangi, atau MSG.

I. Higiene dan Sanitasi

Untuk dapat menyediakan makanan yang sehat dan bersih, higiene dan sanitasi ditempat pengolahan makanan adalah hal yang harus selalu diperhatikan. Berikut beberapa hal yang terkait dengan higiene dan sanitasi ditempat pengolahan makanan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan higiene dan sanitasi individu, yang meliputi :
 - a. Melengkapi fasilitas mencuci tangan
 - b. Adanya aturan yang tegas untuk para pekerja terkait cuci tangan, rapih dan bersih termasuk kebersihan kuku dan menggunakan kerapihan rambut.
 - c. Pekerja difasilitasi pakaian kerja dan penutup kepala
 - d. Fasilitas jamban dan kamar mandi yang bersih
 - e. Pemeriksaan kesehatan rutin pada pekerja.
2. Pemeliharaan higiene dan sanitasi makanan olahan, yang meliputi :
 - a. Menghindari kemungkinan pencemaran pada makanan, misalnya dengan menggunakan alat untuk mengambil makanan
 - b. Jenis makanan panas dijaga suhunya agar tetap panas (140°F)
 - c. Perlu diperhatikan agar rentang waktu makanan jadi hingga disajikan tidak terlalu lama.
 - d. Sediakan lemari pendingin/lemari es.

J. Referensi

- Arifa, S. I., Azam, M., Handayani, & Oktia, W. K. (2019). Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Penyakit Ginjal Kronik Pada Penderita Hipertensi Di Indonesia. *Jurnal MKMI*, 13(4), 319–328.
- Astuty, D. A., Sinaga, A. F., Syahlan, N., Siregar, S. M., Sofi, S., Zega, R. S., Annisa, A., & Dila, T. A. (2022). Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Hipertensi Di Kelurahan Medan Tenggara. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 136–147. <https://doi.org/10.14710/jkm.v10i2.32252>

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Laporan Nasional Riskesdas 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Farida, N., Farida, I. N., & Sahertian, J. (2022). Implementasi Metode Naïve Bayes Classification Dalam Menentukan Gizi Balita Menggunakan IndeksAntropometri. 107–112. http://repository.unpkediri.ac.id/id/eprint/6449%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/6449/3/RAMA_55201_18103020203_0704108701_0707079001_01_font_ref.pdf Fauzan, M. A., Nurmalasari, Y., & Anggunan, A. (2021).
- Hubungan Status Gizi dengan Prestasi Belajar. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 10(1), 105– 111. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i1.517>
- Muafiah, A. F. (2019). No TitleEΛENH. Aγαη, 8(5), 55
- Kementeria kesehatan RI (2018). Isi Piringku Sekali Makan. <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographicp2ptm/obesitas/isi-piringku-sekali-makan> Dinas Kesehatan Tangerang (2023). Isi Piringku Kini Kaya Protein.<https://dinkes.tangerangkab.go.id/2023/02/15/aja-kan-isi-piringku-kini-kaya-protein-hewani-disuluhpuskesmas-cisauk-kepada-masyarakat/>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang Yayi Suryo prabandari, Msi, Ph (2022). Buku Saku Isi Piringku. Daerah Istimewa Yogyakarta: ugmsehat. <https://hpu.ugm.ac.id/2022/11/02/buku-saku-isipiringku/> Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (2020). <https://dinkes.jogjaprovo.go.id=poster+cuci+tangan+pakai+sabun>.
- Putri, H., Suryarinilsih, Y., & Roza, D. (2023). Efektivitas Jus Mentimun Terhadap Tekanan Darah Pasien Hipertensi. JHCN Journal of Health and Cardiovascular Nursing, 3, 63–70. <https://doi.org/10.36082/jhcn.v3i2.1334>
- Rezal, F., & Nurfadilah H, S. (2024). Identifikasi Masalah Kesehatan Serta Intervensinya Melalui Pengalaman Belajar Lapangan di Desa Lapuko, Kecamatan Moramo, Konawe Selatan. Veompuh Journal, 1(1), 66–70. <https://doi.org/10.37887/vj.v1i1.18>

- Ritonga, M. D. R., & Susilawati. (2022). Masalah Sanitasi di Wilayah Pesisir Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(1), 1046–1054. <https://katadata.co.id/berita/2020/01/06/baru83-peserta-bpjs-kesehatan-per-akhir-2019->
- Soesanto, E. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Praktik Lansia Hipertensi Dalam Mengendalikan Kesehatannya Di Puskesmas Mranggen Demak. *FIKKes Jurnal Keperawatan*, 3(2), 98–108. 95
- Susanti, N., Siregar, P. A., & Falefi, R. (2020). Determinan Kejadian Hipertensi Masyarakat Pesisir Berdasarkan Kondisi Sosio Demografi dan Konsumsi Makan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*, 2(1), 43–52.
- Ulya, Z., Iskandar, A., & Asih, F. T. (2017). Pengaruh pendidikan kesehatan dengan media poster terhadap pengetahuan manajemen hipertensi pada penderita hipertensi. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 12(1), 38–44. <http://www.jks.fikes.unsoed.ac.id/index.php/jks/article/view/97>

CHAPTER 5

PERAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DALAM MUTU LAYANAN BERBASIS KOMUNITAS

Maulia Isnaini, S.ST., Bdn., M.Keb

A. Konsep Mutu Layanan Kesehatan Berbasis Komunitas

1. Definisi Mutu Layanan Kesehatan

Mutu layanan kesehatan pada dasarnya menggambarkan sejauh mana layanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif, efisien, aman, tepat waktu, serta bersifat berpusat pada pengguna (*patient-centered*) (World Health Organization, 2018) (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018). Standar mutu kesehatan yang baik mencakup keseluruhan upaya untuk mencapai keseimbangan antara hasil klinis, kepuasan pasien, serta tanggung jawab etis dan profesional dari penyelenggara layanan (Kruk, et al., 2018). Mutu bukan hanya ukuran teknis dari intervensi klinis, tetapi juga merupakan pengalaman sosial budaya dan nilai yang dialami oleh masyarakat saat memperoleh layanan (World Health Organization, 2025).

Meskipun berbagai laporan internasional telah merumuskan standar mutu secara komprehensif, implementasinya di tingkat komunitas sering kali menghadapi kesenjangan antara standar normatif dan realitas lapangan. Tantangan utama bukan terletak pada kurangnya kerangka konseptual, melainkan pada kapasitas sistem dalam menerjemahkan prinsip mutu ke dalam praktik operasional yang konsisten. Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, dimensi mutu sering kali masih berfokus pada aspek administratif dan pemenuhan indikator, sementara dimensi pengalaman pasien dan keberlanjutan pelayanan belum sepenuhnya menjadi prioritas strategis. Oleh karena itu, redefinisi mutu berbasis komunitas perlu menekankan keseimbangan antara indikator kuantitatif dan nilai sosial yang dirasakan masyarakat.

2. Kerangka Konseptual Layanan Berbasis Komunitas

Mutu layanan tidak bisa dilepaskan dari pendekatan layanan kesehatan primer (*primary health care / PHC*). WHO mendefinisikan PHC sebagai pendekatan menyeluruh yang mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan palliative care yang terintegrasi, serta dilakukan sedekat

mungkin dengan kebutuhan masyarakat setempat (World Health Organization, 2019). PHC memfokuskan pada pemberdayaan individu dan komunitas sehingga mereka terlibat dalam pengambilan keputusan tentang kesehatan mereka sendiri, serta mengurangi ketimpangan akses terhadap layanan vital (World Health Organization, 2021).

Konsep ini secara historis juga dituangkan dalam model *Community-Oriented Primary Care (COPC)*, yang memadukan perawatan individual dengan pendekatan populasi, di mana kebutuhan kesehatan suatu komunitas dianalisis bersama masyarakat sendiri dan solusi dirancang secara partisipatif oleh tenaga kesehatan dan masyarakat (Marrone, Nieman, & Coco, 2022); (Luisi & Ha¨mel, 2024). Pendekatan COPC menekankan bahwa pelayanan kesehatan terbaik adalah pelayanan yang bertanggung jawab terhadap definisi dan prioritas masalah kesehatan oleh komunitas itu sendiri.

3. Dimensi Mutu Layanan Berbasis Komunitas

Mutu layanan kesehatan berbasis komunitas memiliki beberapa dimensi penting:

a. Aksesibilitas dan Keterjangkauan

Aksesibilitas berarti layanan tersedia pada saat dibutuhkan oleh masyarakat tanpa hambatan geografi, biaya, atau budaya. Keterjangkauan juga menandakan bahwa masyarakat dapat memperoleh layanan tanpa tekanan finansial yang berlebihan, aspek yang sangat krusial bagi keberhasilan universal health coverage (World Health Organization, 2021) (World Health Organization, 2023). Ini sejalan dengan prinsip PHC yang menekankan pelayanan yang dapat dijangkau oleh semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi (World Health Organization, 2019).

b. Komprehensivitas dan Koordinasi Layanan

Mutu pelayanan tidak hanya soal mengobati penyakit, tetapi juga berperan dalam pencegahan, promotif, dan rehabilitatif. Layanan yang bermutu harus mencakup kebutuhan kesehatan sepanjang hayat, termasuk deteksi dini penyakit, pengelolaan penyakit kronik, serta tindak lanjut pasca-perawatan (Kruk, et al., 2018). Selain itu, koordinasi antara berbagai tingkat layanan (misalnya dari puskesmas ke rumah sakit rujukan) menjadi komponen kunci mutu yang meningkatkan kesinambungan perawatan pasien (Solikha D. A., Butler, Setiawan, Korda, & Kelly, 2025).

c. Partisipasi Masyarakat

Konsep mutu layanan berbasis komunitas tidak lengkap tanpa partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan (Luisi & Ha¨mel, 2024) (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022).

Keterlibatan tersebut bersifat strategis, karena masyarakat yang dilibatkan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap konteks kesehatan lokal dan merasa memiliki tanggung jawab atas hasil program kesehatan. Pendekatan partisipatif memperkuat legitimasi program dan meningkatkan kepatuhan terhadap intervensi kesehatan (Marrone, Nieman, & Coco, 2022).

d. Pengalaman Pengguna dan Pusat Pada Individu

Aspek *patient-centeredness* atau berpusat pada pengguna layanan merupakan dimensi penting mutu (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018). Ini melibatkan penghormatan terhadap hak pasien, komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan masyarakat, serta responsif terhadap kebutuhan emosional dan sosial pasien. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi pasien terhadap kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang baik, empati tenaga kesehatan, serta kemudahan proses layanan (Julvata, Feer, & Dratva, 2023) (Nutbeam & Muscat, 2021).

Keempat dimensi mutu tersebut menunjukkan bahwa mutu layanan berbasis komunitas bersifat multidimensional dan tidak dapat diukur hanya melalui capaian klinis. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan untuk menilai mutu berdasarkan output program semata, seperti cakupan layanan atau angka kunjungan. Pendekatan ini berisiko mengabaikan kualitas interaksi antara tenaga kesehatan dan masyarakat yang justru menjadi fondasi kepercayaan publik. Dengan demikian, sistem evaluasi mutu perlu mengintegrasikan indikator proses dan pengalaman pengguna secara lebih sistematis agar mencerminkan kualitas layanan yang sesungguhnya.

4. Mutu Layanan dalam Kerangka Sistem Kesehatan Nasional

Layanan kesehatan berbasis komunitas merupakan bagian integral dari sistem kesehatan nasional dan merupakan landasan utama dalam mencapai *universal health coverage (UHC)* (World Health Organization, 2021). Menurut laporan WHO, sistem kesehatan yang kuat menempatkan PHC dan pelayanan komunitas sebagai fondasi untuk menghasilkan sistem yang responsif, adil, dan berkelanjutan (World Health Organization, 2019). Pendekatan PHC juga mendorong integrasi lintas sektor seperti pendidikan, lingkungan, dan ekonomi, yang semuanya memengaruhi determinan sosial kesehatan masyarakat (World Health Organization, 2025).

5. Konsep Mutu dalam Praktik di Indonesia

Mutu layanan kesehatan berbasis komunitas di Indonesia sering diterapkan melalui puskesmas dan program seperti Posyandu, kampanye

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta program desa siaga (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2019). Studi di beberapa puskesmas menunjukkan bahwa persepsi mutu layanan signifikan berkaitan dengan tingkat kepuasan pasien dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan primer (Solikha D. A., Butler, Setiawan, Korda, & Kelly, 2025) (Kurniawan, Putra, & Setiawan, 2024). Hal ini mencerminkan pentingnya kualitas layanan tidak hanya dalam hal medis tetapi juga dalam pengelolaan pengalaman pasien dan manajemen fasilitas kesehatan.

Meskipun regulasi dan kebijakan nasional telah memberikan landasan kuat bagi penguatan pelayanan berbasis komunitas, tantangan implementasi masih terlihat pada variasi kapasitas antar wilayah. Ketimpangan sumber daya manusia, infrastruktur, serta dukungan manajerial menyebabkan mutu layanan tidak selalu merata. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan mutu tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup pengembangan kompetensi tenaga kesehatan masyarakat, supervisi berkelanjutan, serta inovasi berbasis kebutuhan lokal. Tanpa strategi tersebut, upaya transformasi layanan primer berisiko berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.

B. Peran Strategis Tenaga Kesehatan Masyarakat

1. Konsep Peran Strategis Tenaga Kesehatan Masyarakat

Peran strategis tenaga kesehatan masyarakat merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan sistem kesehatan yang berorientasi pada pelayanan kesehatan primer dan berbasis komunitas (World Health Organization, 2019). Secara konseptual, peran ini merujuk pada kontribusi profesional tenaga kesehatan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi upaya kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan (Turnock, 2016). Dalam kerangka *evidence-based public health*, tenaga kesehatan masyarakat bertanggung jawab mengintegrasikan data epidemiologi, konteks sosial, serta kebutuhan komunitas ke dalam perencanaan program kesehatan (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025).

Tenaga kesehatan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis program kesehatan, tetapi juga sebagai penggerak sosial yang memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan pendekatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pelayanan kesehatan primer (Luisi & Ha¨mel, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan

masyarakat yang menekankan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan kesehatan (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022) (Luisi & Haïmel, 2024). Dalam konteks Indonesia, penguatan peran ini tercermin dalam kebijakan penyelenggaraan Puskesmas yang menempatkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagai fungsi utama pelayanan primer (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2019).

Secara kritis, peran strategis ini tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga normatif dan advokatif. Tenaga kesehatan masyarakat dituntut memiliki kapasitas analitis untuk mengidentifikasi determinan sosial kesehatan serta memengaruhi kebijakan lokal melalui advokasi berbasis bukti (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025) (World Health Organization, 2025)

2. Peran sebagai Perencana dan Analis Masalah Kesehatan

Tenaga kesehatan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam melakukan analisis situasi kesehatan melalui surveilans epidemiologi, identifikasi faktor risiko, serta pemetaan kebutuhan komunitas (Turnock, 2016). Proses ini menjadi fondasi dalam penyusunan program intervensi berbasis kebutuhan lokal (needs-based planning).

Pendekatan berbasis data menjadi semakin penting dalam era transformasi sistem kesehatan, di mana pengambilan keputusan harus didukung oleh bukti ilmiah yang valid (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025). Studi menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan primer yang menggunakan data secara sistematis dalam perencanaan program memiliki performa mutu layanan yang lebih baik dibandingkan yang tidak (Kurniawan, Putra, & Setiawan, 2024) (Solikha D. A., Butler, Setiawan, Korda, & Kelly, 2025)

Namun demikian, tantangan di lapangan sering kali berkaitan dengan keterbatasan kapasitas analisis data dan sistem informasi kesehatan yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan kompetensi analitik dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kebutuhan strategis dalam peningkatan mutu layanan berbasis komunitas (Nadrian, 2024).

3. Peran sebagai Edukator dan Promotor Kesehatan

Sebagai promotor kesehatan, tenaga kesehatan masyarakat berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan (health literacy) masyarakat melalui edukasi yang sistematis dan kontekstual. Literasi kesehatan terbukti berkontribusi terhadap peningkatan perilaku preventif dan kepatuhan terhadap terapi (Julvata, Feer, & Dratva, 2023) (Nutbeam & Muscat, 2021).

Pendekatan edukatif yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk memahami, mengevaluasi,

dan menggunakan informasi kesehatan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Strategi ini sejalan dengan prinsip promosi kesehatan dalam kerangka pelayanan primer global (World Health Organization, 2019).

Secara analitis, keberhasilan edukasi kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi interpersonal dan sensitivitas budaya tenaga kesehatan. Jika pendekatan komunikasi tidak adaptif terhadap konteks sosial, maka efektivitas intervensi promotif dapat menurun meskipun materi edukasi telah disusun secara ilmiah.

4. Peran sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dimensi penting dalam peningkatan mutu layanan berbasis komunitas. Tenaga kesehatan masyarakat berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi masalah, perencanaan solusi, dan evaluasi program (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022) (Marrone, Nieman, & Coco, 2022).

Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja pelayanan primer dan kepuasan pengguna layanan (Kurniawan, Putra, & Setiawan, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa mutu layanan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis tenaga kesehatan, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam sistem pelayanan.

Secara kritis, pemberdayaan yang bersifat simbolik tanpa transfer kapasitas nyata berpotensi menciptakan partisipasi semu. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan harus dirancang secara berkelanjutan dengan indikator yang terukur dan mekanisme evaluasi partisipatif.

5. Peran dalam Monitoring dan Evaluasi Mutu

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen esensial dalam siklus peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement). Tenaga kesehatan masyarakat bertanggung jawab memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya mencapai target kuantitatif, tetapi juga memenuhi standar keselamatan dan kualitas layanan (World Health Organization, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa sistem monitoring yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan meningkatkan akurasi pelaporan dan efektivitas pengambilan keputusan manajerial (Nadrian, 2024) (Solikha D. A., Butler, Setiawan, Korda, & Kelly, 2025). Hal ini menegaskan bahwa transformasi digital menjadi faktor pendukung penting dalam penguatan mutu layanan primer.

Namun, penguatan sistem monitoring harus diimbangi dengan budaya evaluatif yang konstruktif. Tanpa budaya organisasi yang mendukung refleksi

dan perbaikan berkelanjutan, sistem evaluasi cenderung hanya menjadi kewajiban administratif tanpa dampak substantif terhadap mutu layanan.

C. Perencanaan Layanan Berbasis Kebutuhan Komunitas

1. Konsep Dasar Perencanaan Layanan Kesehatan

Perencanaan layanan kesehatan komunitas merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan kesehatan suatu populasi dan merancang intervensi yang tepat guna, efektif, serta responsif terhadap konteks lokal. Dalam perspektif sistem kesehatan, perencanaan menjadi komponen kunci dalam memastikan pelayanan primer berjalan secara terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat (World Health Organization, 2019) (World Health Organization, 2021).

Perencanaan tidak hanya mencakup aspek teknis medis, tetapi juga mempertimbangkan determinan sosial kesehatan seperti kondisi ekonomi, pendidikan, lingkungan, serta faktor budaya yang memengaruhi perilaku kesehatan (World Health Organization, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pelayanan kesehatan primer yang menempatkan komunitas sebagai pusat sistem pelayanan.

Dalam konteks masyarakat, perencanaan layanan yang efektif harus dilakukan secara partisipatif. Pelibatan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah hingga pemilihan strategi intervensi terbukti meningkatkan legitimasi program dan keberlanjutan implementasi (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022) (Marrone, Nieman, & Coco, 2022). Pendekatan partisipatif memperkuat sense of ownership sehingga intervensi lebih adaptif dan diterima secara sosial.

2. Tahapan Perencanaan Layanan Berbasis Komunitas

Perencanaan layanan berbasis kebutuhan komunitas terdiri dari tahapan sistematis yang saling berkaitan. Model seperti PRECEDE–PROCEED dan pendekatan *community health planning* menekankan pentingnya integrasi analisis data, partisipasi komunitas, serta evaluasi berkelanjutan (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025).

a. Pengkajian Situasi Kesehatan (Health Situation Assessment)

Pengkajian situasi kesehatan merupakan langkah awal untuk mengumpulkan data terkait indikator kesehatan, determinan sosial, serta persepsi masyarakat. Pendekatan berbasis data (*evidence-based planning*) memungkinkan identifikasi kebutuhan secara objektif dan komprehensif (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025). Dalam sistem kesehatan yang berorientasi mutu, penggunaan data epidemiologis dan surveilans

komunitas menjadi fondasi pengambilan keputusan (Kruk, et al., 2018). Di Indonesia, pengkajian situasi sering dilakukan melalui survei kesehatan, forum warga, serta diskusi kelompok terfokus yang memungkinkan pemetaan kebutuhan kontekstual (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2019).

b. Penetapan Prioritas Masalah Kesehatan

Setelah pengkajian dilakukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan prioritas berdasarkan besaran masalah, dampak terhadap kualitas hidup, ketersediaan sumber daya, serta kesiapan masyarakat. Penetapan prioritas membantu optimalisasi sumber daya yang terbatas agar difokuskan pada masalah dengan beban terbesar (Kruk, et al., 2018). Pendekatan ini juga harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat, karena legitimasi sosial merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi program (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022). Tanpa keseimbangan antara data epidemiologis dan perspektif komunitas, prioritas program berisiko tidak relevan atau kurang mendapat dukungan sosial.

c. Perumusan Tujuan dan Sasaran Program

Tujuan dan sasaran program harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan realistis. Prinsip perencanaan berbasis mutu menekankan pentingnya indikator yang terdefinisi dengan baik untuk memudahkan evaluasi dan akuntabilitas (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018). Perumusan sasaran yang spesifik juga memudahkan integrasi program dengan sistem monitoring nasional dan indikator kinerja pelayanan primer (World Health Organization, 2023).

d. Pemilihan Strategi Intervensi dan Perencanaan Implementasi

Strategi intervensi harus berbasis bukti ilmiah serta mempertimbangkan konteks sosial budaya komunitas. Pendekatan evidence-based public health menekankan pentingnya penggunaan intervensi yang telah terbukti efektif dalam literatur ilmiah (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025). Selain itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kolaborasi antara tenaga kesehatan masyarakat, pemangku kepentingan lokal, dan kelompok Masyarakat (Marrone, Nieman, & Coco, 2022). Tanpa dialog partisipatif, strategi intervensi berisiko mengalami resistensi sosial atau kegagalan implementasi.

e. Penetapan Indikator dan Rencana Evaluasi

Indikator kinerja merupakan instrumen penting dalam menilai efektivitas dan mutu program. Sistem kesehatan yang kuat menempatkan evaluasi sebagai bagian integral dari siklus perencanaan (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018). Evaluasi berbasis indikator

memungkinkan identifikasi kesenjangan layanan dan perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement) (World Health Organization, 2023). Dengan demikian, perencanaan tidak berhenti pada tahap desain, tetapi berlanjut pada pemantauan dampak dan penyesuaian strategi.

3. Perencanaan Berbasis Bukti dan Partisipatif

Perencanaan yang efektif harus bersifat evidence-based dan community-centered. Integrasi data epidemiologis dengan perspektif komunitas memperkuat relevansi dan efektivitas intervensi (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025). Partisipasi masyarakat dalam tahap awal perencanaan berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan, pengurangan resistensi sosial, serta keberlanjutan program (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022) (Marrone, Nieman, & Coco, 2022).

Dalam konteks Indonesia, forum musyawarah desa dan mekanisme partisipatif lokal terbukti meningkatkan dukungan terhadap program sanitasi, deteksi dini penyakit, dan promosi perilaku hidup sehat (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2019). Secara kritis, partisipasi yang bermakna bukan hanya pelibatan simbolik, tetapi pemberian ruang nyata bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

4. Tantangan dalam Perencanaan Layanan Berbasis Kebutuhan Komunitas

Meskipun perencanaan berbasis kebutuhan komunitas menawarkan banyak keuntungan, terdapat sejumlah tantangan dalam praktiknya, antara lain:

a. Keterbatasan Data Valid dan Relevan

Kualitas data yang rendah dapat menghambat identifikasi kebutuhan secara akurat dan mengurangi efektivitas perencanaan (Kruk, et al., 2018).

b. Ketimpangan Partisipasi Masyarakat

Kelompok marginal sering kali kurang terwakili dalam proses perencanaan, sehingga berisiko memperlebar kesenjangan kesehatan (World Health Organization, 2025).

c. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan tenaga, waktu, dan pendanaan seringkali menjadi hambatan untuk menyusun rencana yang holistik dan komprehensif (World Health Organization, 2023).

d. Hambatan Sosial Budaya

Nilai budaya dan norma sosial dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program yang direncanakan (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022).

Strategi untuk mengatasi tantangan ini mencakup peningkatan kapasitas data dan surveilans, pendekatan komunikasi yang sensitif budaya, serta penguatan mekanisme partisipasi yang inklusif.

D. Implementasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Komunitas

1. Konsep Dasar Implementasi Pelayanan Berbasis Komunitas

Implementasi pelayanan kesehatan berbasis komunitas merupakan tahapan pelaksanaan program kesehatan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat yang telah diidentifikasi melalui proses perencanaan. Implementasi tidak hanya mencakup tindakan klinis, tetapi juga melibatkan pendekatan sosial, budaya, edukatif, dan pemberdayaan yang menempatkan komunitas sebagai pusat pelayanan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa layanan kesehatan tidak sekadar tersedia, tetapi relevan, efektif, bermutu, dan dapat diterima oleh Masyarakat (World Health Organization, 2019) (World Health Organization, 2021).

Pelayanan kesehatan berbasis komunitas merupakan bagian integral dari pendekatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) yang menekankan integrasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara komprehensif (World Health Organization, 2019). Pendekatan ini juga berakar pada prinsip pemberdayaan masyarakat (community empowerment), yaitu meningkatkan kapasitas komunitas agar mampu menjaga dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022) (Marrone, Nieman, & Coco, 2022). Dengan demikian, implementasi layanan berbasis komunitas bukan sekadar fase operasional, melainkan proses transformasional yang memperkuat hubungan antara sistem kesehatan dan masyarakat.

2. Tahapan Pelaksanaan Implementasi

Implementasi layanan berbasis komunitas mencakup beberapa tahapan penting yang saling berkaitan:

a. Preparasi dan Mobilisasi Sumber Daya

Tahap awal implementasi mencakup persiapan dan mobilisasi sumber daya manusia, material, sarana prasarana, serta dukungan manajerial. Tenaga kesehatan masyarakat berperan sebagai koordinator dalam mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kader kesehatan, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah. Mobilisasi sumber daya yang efektif akan meningkatkan kapasitas sistem dalam merespons kebutuhan komunitas secara cepat dan terkoordinasi. Selain itu, sistem kesehatan yang kuat menekankan pentingnya

penguatan tata kelola dan manajemen program dalam implementasi pelayanan primer (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018).

b. Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif

Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit merupakan inti implementasi layanan berbasis komunitas. Kegiatan edukasi kesehatan, kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, imunisasi, deteksi dini penyakit, serta intervensi lingkungan merupakan bentuk nyata integrasi upaya promotif dan preventif dalam pelayanan primer (World Health Organization, 2019).

Pendekatan preventif yang dilakukan secara rutin dan berbasis bukti terbukti mampu menurunkan beban penyakit serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Kruk, et al., 2018). Dalam konteks implementasi berbasis komunitas, keberhasilan kegiatan promotif-preventif sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan kualitas komunikasi kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan masyarakat (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022).

c. Kolaborasi dan Koordinasi Implementasi Lintas Sektor

Implementasi pelayanan berbasis komunitas tidak dapat dilakukan secara sektoral. Pendekatan determinan sosial kesehatan menegaskan bahwa faktor pendidikan, lingkungan, pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi berkontribusi signifikan terhadap derajat kesehatan masyarakat (World Health Organization, 2025). Oleh karena itu, tenaga kesehatan masyarakat berperan sebagai penghubung (*bridging actor*) dalam koordinasi lintas sektor. Kolaborasi yang efektif antar sektor memperluas cakupan intervensi, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memperkuat ketahanan sistem kesehatan dalam jangka panjang (World Health Organization, 2021).

d. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Pemberdayaan komunitas pada tahap implementasi berarti masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi program. Partisipasi yang bermakna meningkatkan rasa memiliki serta mempercepat perubahan perilaku kesehatan (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022) (Marrone, Nieman, & Coco, 2022). Pendekatan partisipatif juga memperkuat kapasitas kolektif masyarakat untuk merespons tantangan kesehatan secara mandiri, sehingga program lebih berkelanjutan dan tidak bergantung sepenuhnya pada intervensi eksternal (World Health Organization, 2019).

3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan yang Efektif

Agar implementasi pelayanan kesehatan berbasis komunitas efektif, beberapa prinsip harus dipenuhi:

a. Responsif terhadap Kebutuhan dan Konteks Lokal

Implementasi yang efektif harus berbasis pada data kebutuhan kesehatan yang akurat dan partisipatif. Pendekatan *evidence-based public health* menekankan pentingnya penggunaan bukti ilmiah sekaligus mempertimbangkan konteks sosial budaya komunitas (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025). Program yang responsif mencerminkan pemahaman terhadap nilai budaya, norma sosial, serta karakteristik demografis masyarakat setempat.

b. Keterlibatan Aktif Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip utama dalam implementasi layanan berbasis komunitas. Partisipasi bukan sekadar kehadiran dalam kegiatan, tetapi keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi program. Pendekatan ini meningkatkan legitimasi program dan memperkuat keberlanjutan (Marrone, Nieman, & Coco, 2022).

c. Kolaboratif dan Multisektoral

Kolaborasi lintas sektor memperkuat efektivitas implementasi dan memperluas jangkauan intervensi. Integrasi antara sektor kesehatan dan sektor lain mendukung pendekatan holistik terhadap determinan sosial kesehatan (World Health Organization, 2025). Sistem pelayanan primer yang kolaboratif terbukti lebih tangguh dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat (World Health Organization, 2021).

d. Berorientasi pada Hasil dan Evaluasi Berkelanjutan

Pelaksanaan program harus disertai dengan indikator hasil yang jelas, sistem monitoring yang efektif, serta evaluasi berkala. Indikator ini membantu melihat kemajuan program secara objektif dan memberikan data dasar untuk perbaikan (*continuous quality improvement*) program berikutnya (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018). Pendekatan ini memastikan bahwa implementasi tidak bersifat administratif semata, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan pada indikator kesehatan masyarakat (Kruk, et al., 2018).

4. Tantangan dalam Implementasi

Implementasi layanan berbasis komunitas sering menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

a. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis

Keterbatasan tenaga terlatih dan dukungan teknis dapat menghambat kualitas implementasi (World Health Organization, 2023).

b. Hambatan sosial budaya

Nilai dan kepercayaan lokal dapat memengaruhi penerimaan intervensi kesehatan, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi sensitif budaya (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022).

c. Kurangnya dukungan kebijakan lokal

Implementasi berbasis komunitas memerlukan kebijakan daerah yang mendukung pelayanan primer sebagai prioritas (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2019).

d. Kesulitan koordinasi lintas sektor

Perbedaan prioritas antar sektor dapat menghambat integrasi program dan efektivitas implementasi (World Health Organization, 2025).

Mengatasi tantangan ini memerlukan strategi deliberatif, seperti peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan jaringan kolaboratif, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada pendekatan pemberdayaan komunitas.

E. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Layanan

1. Konsep Mutu dan Keselamatan Layanan Kesehatan

Mutu layanan kesehatan merupakan derajat sejauh mana layanan yang diberikan mampu meningkatkan kemungkinan tercapainya luaran kesehatan yang diharapkan secara efektif, efisien, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien maupun masyarakat (Kruk, et al., 2018) (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018). Mutu tidak hanya berkaitan dengan pencapaian klinis, tetapi juga mencakup dimensi aksesibilitas, responsivitas, dan keadilan pelayanan.

Sementara itu, keselamatan layanan kesehatan (patient safety) merupakan upaya sistematis untuk mencegah dan mengurangi risiko, kesalahan, serta dampak merugikan yang terjadi selama proses pelayanan (World Health Organization, 2021). Dalam konteks pelayanan berbasis komunitas, keselamatan tidak terbatas pada tindakan medis, tetapi juga mencakup keselamatan informasi, komunikasi risiko, serta akses layanan yang aman dan tidak diskriminatif (World Health Organization, 2019). Mutu dan keselamatan merupakan fondasi sistem kesehatan yang adil (equitable), efektif (effective),

dan berkelanjutan. Tanpa jaminan mutu dan keselamatan, perluasan cakupan layanan tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Kruk, et al., 2018)

2. Dimensi Peningkatan Mutu Layanan

Peningkatan mutu layanan kesehatan berbasis komunitas dilaksanakan melalui beberapa dimensi utama:

a. Mutu Teknisi dan Standar Prosedur Operasional

Mutu teknis mencakup kompetensi tenaga kesehatan, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta penerapan pedoman berbasis bukti. Dalam kerangka peningkatan mutu sistem kesehatan, struktur dan proses pelayanan berkontribusi signifikan terhadap outcome kesehatan (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018).

Penerapan standar operasional prosedur (SOP) membantu menjaga konsistensi pelayanan, meminimalkan variasi yang tidak perlu, dan mengurangi risiko kesalahan. Pendekatan evidence-based public health juga menekankan pentingnya pembaruan kompetensi tenaga kesehatan secara berkelanjutan (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025).

b. Pengukuran Kinerja dan Monitoring

Peningkatan mutu memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis. Indikator mutu mencakup dimensi struktur, proses, dan hasil pelayanan, serta pengalaman pengguna layanan (Kruk, et al., 2018).

Evaluasi berkala menjadi bagian dari pendekatan continuous quality improvement yang memungkinkan organisasi belajar dari data dan melakukan perbaikan berkelanjutan (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018) (World Health Organization, 2023). Tanpa sistem monitoring yang kuat, peningkatan mutu berisiko bersifat administratif dan tidak berdampak pada kualitas layanan secara substantif.

c. Fokus pada Pengalaman Pengguna Layanan

Pengalaman pasien dan masyarakat merupakan indikator penting dalam mutu layanan. Persepsi terhadap aksesibilitas, kualitas komunikasi, penghormatan terhadap hak pasien, dan kejelasan informasi memengaruhi tingkat kepuasan dan kepatuhan terhadap intervensi kesehatan (World Health Organization, 2021).

Pelayanan berbasis komunitas yang responsif terhadap pengalaman pengguna terbukti meningkatkan keterlibatan masyarakat serta efektivitas program kesehatan (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022) (Marrone, Nieman, & Coco, 2022). Oleh karena itu, dimensi pengalaman pengguna tidak dapat dipisahkan dari indikator mutu klinis.

3. Konsep Keselamatan Layanan dalam Konteks Komunitas

Keselamatan layanan dalam konteks komunitas mencakup pencegahan risiko medis, kesalahan komunikasi, diskriminasi pelayanan, hingga bahaya lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat (World Health Organization, 2021). Dalam pelayanan berbasis komunitas, keselamatan tercermin melalui proses imunisasi yang sesuai standar, penyediaan lokasi pelayanan yang aman dan higienis, serta sistem pelaporan kejadian tidak diinginkan yang transparan. Sistem kesehatan yang mengintegrasikan budaya keselamatan pasien cenderung memiliki mutu layanan yang lebih konsisten dan terpercaya (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018).

4. Strategi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Layanan

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan kompetensi tenaga kesehatan masyarakat melalui pelatihan berkelanjutan dan pembelajaran berbasis bukti merupakan strategi utama dalam peningkatan mutu (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025). Di Indonesia, penguatan kapasitas tenaga puskesmas sebagai bagian dari pelayanan primer menjadi kebijakan strategis dalam mendukung mutu layanan berbasis komunitas (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2019). Peningkatan kompetensi tidak hanya berdampak pada kualitas teknis, tetapi juga pada kualitas komunikasi dan manajemen risiko pelayanan.

b. Implementasi Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan

Penerapan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan siklus perbaikan berkelanjutan membantu organisasi mengidentifikasi kesenjangan layanan dan melakukan penyesuaian berbasis data (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018). Budaya keselamatan yang mendorong pelaporan kesalahan tanpa stigma serta pembelajaran organisasi merupakan komponen penting dalam sistem mutu modern (World Health Organization, 2023). Pendekatan ini memperkuat akuntabilitas dan transparansi pelayanan.

c. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengawasan Layanan

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan mutu meningkatkan relevansi sistem evaluasi terhadap kebutuhan nyata komunitas (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022). Partisipasi dalam pemberian umpan balik, forum evaluasi layanan, serta mekanisme pengaduan publik memperkuat legitimasi sistem pelayanan dan mendorong perbaikan berkelanjutan (Marrone, Nieman, & Coco, 2022). Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada komunitas.

F. Tantangan dalam Mewujudkan Mutu Layanan Berbasis Komunitas

1. Konteks Tantangan Mutu Layanan Berbasis Komunitas

Mutu layanan kesehatan berbasis komunitas merupakan tujuan strategis dalam sistem pelayanan kesehatan primer yang menekankan layanan yang relevan, efektif, responsif, dan berkeadilan (World Health Organization, 2019) (World Health Organization, 2021). Namun, meskipun pendekatan primary health care dan pemberdayaan komunitas telah menjadi fondasi kebijakan kesehatan global dan nasional, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan struktural, fungsional, dan budaya yang kompleks.

Tantangan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek teknis pelayanan, tetapi juga dari keterbatasan sumber daya, kapasitas organisasi, dukungan kebijakan, serta tingkat keterlibatan masyarakat (Kruk, et al., 2018). Identifikasi dan analisis hambatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem mutu layanan di tingkat komunitas secara berkelanjutan.

2. Keterbatasan Sumber Daya

a. Keterbatasan Tenaga Kesehatan

Kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan distribusi tenaga kesehatan. Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan menjadi tantangan yang berdampak pada kualitas pelayanan primer (World Health Organization, 2023). Keterbatasan jumlah tenaga juga memengaruhi intensitas kegiatan promotif dan preventif yang menjadi inti layanan berbasis komunitas (World Health Organization, 2019). Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, mutu layanan sulit ditingkatkan secara konsisten.

b. Pembiayaan dan Infrastruktur

Pembiayaan yang terbatas berdampak pada kurangnya sarana, prasarana, serta sistem informasi kesehatan yang memadai. Sistem kesehatan yang kuat memerlukan investasi berkelanjutan untuk menjamin mutu dan keselamatan pelayanan (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018). Di Indonesia, penguatan pelayanan primer melalui Puskesmas telah menjadi kebijakan strategis, namun variasi dukungan anggaran antar daerah masih memengaruhi kualitas implementasi di lapangan (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2019).

3. Tantangan Sistemik dan Organisasional

a. Koordinasi dan Integrasi Lintas Sektor

Permasalahan kesehatan masyarakat bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh determinan sosial seperti pendidikan, sanitasi, dan

lingkungan (World Health Organization, 2025). Namun, koordinasi lintas sektor sering kali terfragmentasi, sehingga implementasi program kurang terpadu dan berdampak pada mutu layanan (World Health Organization, 2021). Pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam memperkuat integrasi sistemik, namun memerlukan kepemimpinan dan tata kelola yang kuat.

b. Manajemen Mutu dan Evaluasi

Banyak layanan kesehatan komunitas belum memiliki sistem manajemen mutu yang terstandarisasi. Monitoring dan evaluasi sering dilakukan secara sporadis tanpa indikator yang terukur dan konsisten (Kruk, et al., 2018). Pendekatan *continuous quality improvement* menuntut sistem evaluasi berbasis data dan pembelajaran organisasi yang adaptif (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018). Tanpa sistem tersebut, perbaikan mutu sulit dilakukan secara sistemik.

4. Tantangan Sosial Budaya

a. Nilai Budaya dan Persepsi Kesehatan

Nilai dan praktik budaya memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap intervensi kesehatan. Variasi persepsi kesehatan dapat memengaruhi partisipasi dalam program skrining, imunisasi, atau promosi perilaku sehat (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022). Pendekatan komunikasi sensitif budaya menjadi penting untuk memastikan pesan kesehatan diterima secara kontekstual dan tidak menimbulkan resistensi sosial.

b. Tingkat Literasi dan Partisipasi Masyarakat

Literasi kesehatan yang rendah membatasi kemampuan masyarakat dalam memahami informasi dan mengambil keputusan kesehatan yang tepat. Peningkatan literasi kesehatan merupakan komponen penting dalam penguatan pelayanan berbasis komunitas (World Health Organization, 2019). Selain itu, partisipasi masyarakat yang rendah dalam perencanaan dan evaluasi program dapat mengurangi efektivitas implementasi dan relevansi indikator mutu (Marrone, Nieman, & Coco, 2022).

5. Hambatan Teknis dan Operasional

a. Standarisasi Prosedur

Standarisasi prosedur operasional penting untuk menjamin konsistensi pelayanan. Variasi pelayanan akibat kurangnya implementasi SOP berpotensi menurunkan mutu dan keselamatan layanan (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018). Pendekatan berbasis bukti dan pembaruan kompetensi tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas implementasi (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025).

b. Sistem Informasi Kesehatan

Sistem informasi kesehatan yang tidak terintegrasi menghambat pelaporan data dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Penguatan sistem informasi kesehatan menjadi prioritas dalam reformasi pelayanan primer (World Health Organization, 2023). Data yang akurat dan real-time mendukung evaluasi mutu dan respons cepat terhadap kebutuhan komunitas (Kruk, et al., 2018).

6. Tantangan Kebijakan dan Dukungan Regulasi

Konsistensi kebijakan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendekatan berbasis komunitas. Meskipun kebijakan nasional mendukung pelayanan primer dan pemberdayaan masyarakat, implementasi di tingkat lokal sering kali menghadapi variasi komitmen dan alokasi anggaran (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2019). Tanpa dukungan regulasi yang kuat dan mekanisme monitoring yang jelas, mutu layanan dapat berbeda secara signifikan antar wilayah.

7. Tantangan dalam Menghadapi Perubahan Epidemiologi

Transisi epidemiologi dari penyakit menular menuju penyakit tidak menular (*non-communicable diseases/NCDs*) menuntut adaptasi sistem layanan komunitas yang lebih kompleks dan berkelanjutan (World Health Organization, 2023). Penyakit kronis membutuhkan layanan jangka panjang, edukasi berkelanjutan, dan integrasi layanan promotif, preventif, serta kuratif. Tantangan ini semakin berat ketika dikombinasikan dengan faktor sosial ekonomi yang memengaruhi akses layanan (World Health Organization, 2025).

8. Peluang dan Strategi Mengatasi Tantangan

Meskipun tantangan tersebut kompleks, terdapat peluang strategis untuk memperkuat mutu layanan berbasis komunitas, antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader melalui pelatihan berkelanjutan berbasis bukti (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025).
- b. Penguatan sistem informasi kesehatan untuk mendukung monitoring dan evaluasi berbasis data (World Health Organization, 2023).
- c. Advokasi kebijakan lokal agar sejalan dengan penguatan pelayanan primer dan pemberdayaan komunitas (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2019).
- d. Pendekatan komunikasi yang sensitif budaya guna meningkatkan literasi dan keterlibatan masyarakat (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022).
- e. Kolaborasi lintas sektor dan kemitraan strategis dalam menangani determinan sosial kesehatan (World Health Organization, 2025).

Strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tantangan dalam mewujudkan mutu layanan berbasis komunitas bersifat multidimensional, penguatan sistemik dan kolaboratif dapat menjadi solusi berkelanjutan.

G. Strategi Penguatan Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat

1. Konsep Strategi Penguatan Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat

Penguatan peran tenaga kesehatan masyarakat (TKM) merupakan langkah strategis untuk memastikan sistem kesehatan primer berjalan secara responsif, efektif, dan berkeadilan (World Health Organization, 2021). Strategi penguatan tidak hanya berfokus pada kapasitas individu, tetapi juga mencakup penguatan institusi, tata kelola, sistem informasi, serta dukungan kebijakan yang memungkinkan TKM menjalankan fungsi promotif, preventif, advokatif, dan koordinatif secara optimal.

Dalam kerangka *evidence-based public health*, penguatan peran TKM diperlukan agar intervensi kesehatan berbasis komunitas mampu dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, berbasis data, dan berorientasi pada outcome (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025). Selain itu, pemberdayaan komunitas menjadi bagian integral dalam strategi penguatan peran TKM (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022) (Marrone, Nieman, & Coco, 2022).

2. Strategi Utama Penguatan Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat

Untuk mencapai peran yang optimal, strategi penguatan peran TKM dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek strategis berikut:

a. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Profesional

Pengembangan kompetensi profesional merupakan fondasi penguatan peran TKM. Pelatihan berbasis kompetensi, pembelajaran berkelanjutan, mentoring, serta akses terhadap praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*) meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi program komunitas (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025).

Penguatan kompetensi dalam analisis data epidemiologi, komunikasi kesehatan, pendekatan partisipatif, serta pemanfaatan teknologi informasi mendukung layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (World Health Organization, 2023). Di Indonesia, kebijakan penguatan kapasitas tenaga Puskesmas menjadi bagian dari strategi reformasi pelayanan primer (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2019).

b. Pembentukan Jaringan Kemitraan dan Kolaborasi

Kolaborasi lintas sektor merupakan strategi penting dalam penguatan peran TKM. Permasalahan kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh determinan

sosial yang memerlukan pendekatan multisektoral (World Health Organization, 2025).

Kemitraan antara fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta memperluas cakupan intervensi serta meningkatkan efektivitas program (World Health Organization, 2021). Pendekatan kolaboratif ini juga meningkatkan keberlanjutan program berbasis komunitas (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022).

c. Peningkatan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Kesehatan

Transformasi digital menjadi bagian strategis dalam penguatan peran TKM. Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan data, pelaporan, serta monitoring program secara lebih akurat dan real-time (World Health Organization, 2023). Pendekatan berbasis data mendukung perencanaan dan evaluasi berbasis bukti serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan (Kruk, et al., 2018). Digitalisasi juga meningkatkan respons terhadap kejadian kesehatan masyarakat di tingkat komunitas.

d. Advokasi Kebijakan dan Penguatan Regulasi

Advokasi kebijakan merupakan strategi penting untuk memastikan dukungan regulasi dan pembiayaan yang memadai bagi pelayanan berbasis komunitas. Penyampaian bukti kebutuhan kesehatan masyarakat kepada pengambil kebijakan mendukung perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis data (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025). Di tingkat nasional, penguatan pelayanan primer telah menjadi prioritas kebijakan, namun implementasi yang konsisten di tingkat daerah tetap memerlukan komitmen regulatif dan dukungan anggaran yang berkelanjutan (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2019).

e. Pemberdayaan Komunitas dan Partisipasi Aktif Masyarakat

Pemberdayaan komunitas merupakan strategi inti dalam penguatan peran TKM. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi meningkatkan legitimasi serta keberlanjutan program (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022) (Marrone, Nieman, & Coco, 2022). Pendekatan ini memperkuat literasi kesehatan dan membangun kapasitas kolektif komunitas dalam merespons masalah kesehatan secara mandiri (World Health Organization, 2019).

3. Tantangan dalam Penguatan Peran TKM dan Solusinya

Penguatan peran TKM menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana, resistensi organisasi, serta disparitas akses terhadap pelatihan dan teknologi (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi yang dapat diimplementasikan antara lain:

- a. Pendanaan berkelanjutan, sejalan dengan penguatan pelayanan primer sebagai prioritas nasional (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2019).
- b. Pelatihan inklusif berbasis bukti, guna memastikan pemerataan kapasitas TKM di berbagai wilayah (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025).
- c. Kolaborasi akademik dan riset terapan, untuk memperkuat praktik berbasis bukti dalam pelayanan komunitas (Kruk, et al., 2018).

H. Dampak Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat terhadap Mutu Layanan Kesehatan

1. Dampak terhadap Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan

a. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer

Pelayanan kesehatan primer merupakan fondasi utama sistem kesehatan yang bermutu (World Health Organization, 2019). Optimalisasi peran TKM dalam pendekatan promotif dan preventif memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan pemerataan akses (World Health Organization, 2021). Di Indonesia, penguatan fungsi Puskesmas sebagai fasilitas tingkat pertama menjadi strategi utama dalam meningkatkan akses layanan dasar secara merata (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2019).

b. Penjangkauan Kelompok Rentan dan Wilayah Terpencil

Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan penjangkauan kelompok rentan melalui kunjungan rumah dan penguatan kader kesehatan. Sistem pelayanan primer yang inklusif meningkatkan keadilan akses dan menurunkan kesenjangan layanan (Kruk, et al., 2018).

2. Dampak terhadap Kualitas dan Efektivitas Pelayanan

a. Penerapan Standar Mutu dan Evidence-Based Practice

Mutu layanan meningkat ketika intervensi dirancang secara sistematis dan berbasis data epidemiologi (Brownson, Deshpande, Gillespie, & Mazzucca-Ragan, 2025). Sistem kesehatan dengan indikator mutu yang jelas menunjukkan outcome yang lebih baik dan konsisten (National Academies of Sciences, Health, Board, Board, & Committee, 2018). Pendekatan berbasis bukti juga meningkatkan efektivitas program promotif dan preventif di tingkat komunitas (World Health Organization, 2023).

b. Efisiensi dan Pengurangan Beban Kuratif

Pelayanan promotif dan preventif yang kuat menurunkan beban penyakit serta meningkatkan efisiensi sistem kesehatan (Kruk, et al., 2018). Sistem

kesehatan dengan pelayanan primer optimal cenderung memiliki pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan (World Health Organization, 2021).

3. Dampak terhadap Keselamatan dan Kepercayaan Masyarakat

a. Peningkatan Keselamatan Layanan Berbasis Komunitas

Keselamatan layanan merupakan komponen penting mutu sistem kesehatan (World Health Organization, 2021). Peran TKM dalam edukasi penggunaan obat rasional dan pencegahan infeksi di komunitas berkontribusi pada peningkatan keselamatan layanan berbasis komunitas.

b. Peningkatan Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan meningkat ketika interaksi antara tenaga kesehatan dan komunitas bersifat partisipatif dan komunikatif (Belaid, Sarmiento, Dimiti, & Andersson, 2022). Kepuasan layanan berkorelasi dengan mutu komunikasi, responsivitas, serta penghormatan terhadap kebutuhan masyarakat (World Health Organization, 2019).

4. Dampak terhadap Pemberdayaan dan Partisipasi Komunitas

a. Penguatan Literasi dan Perubahan Perilaku Kesehatan

Tenaga kesehatan masyarakat berperan sebagai agen perubahan perilaku melalui edukasi dan pemberdayaan. Literasi kesehatan yang meningkat memperkuat keberlanjutan program dan partisipasi masyarakat (World Health Organization, 2019).

b. Ketahanan Komunitas dan Sistem Kesehatan

Sistem kesehatan dengan pelayanan primer yang kuat lebih adaptif dalam menghadapi perubahan epidemiologi dan krisis kesehatan (World Health Organization, 2023). Di Indonesia, penguatan pelayanan primer menjadi strategi utama dalam meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2019)

I. Referensi

- Brownson, R. C., Deshpande, A. D., Gillespie, K. N., & Mazzucca-Ragan, S. (2025). Evidence-Based Public Health. United Kingdom: Oxford University Press.
- Akin, O., & Adeola, O. (2022). Assessment of Quality of Care in a Primary HealthCare Setting in South West Nigeria. *International Journal of Health Sciences and Research*, 12-26.
- Belaid, L., Sarmiento, I., Dimiti, A., & Andersson, N. (2022). Community Participation in Primary Healthcare in the South Sudan Boma Health Initiative: A Document Analysis. *International Journal of Health Policy and Management*, 2869-2875.

- Daroedono, E., Aurellita, N., Savero, I., Sirait, G. P., Imanuel, R., & Kuheba, E. G. (2025). The Curative Role of the Main Primary Health Facility in Indonesia: Analyzing Patient Visits at a Single PUSKESMAS with a Focus on General and Maternal-Child Health Clinics. *Asian Journal of Research in Medical and Pharmaceutical Sciences*, 68-78.
- Julvata, S., Feer, S., & Dratva, J. (2023). Digital health literacy – an evolving concept. *European Journal of Public Health*, 121.
- Kementerian Kesehatan Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Indonesia. (2024). *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Indonesia;. (2026). *Layanan Kementerian Kesehatan*. From Transformasi Kesehatan Indonesia: <https://kemkes.go.id/id/layanan/transformasi-kesehatan-indonesia>
- Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., Jordan, K., Leslie, H. H., Roder-DeWan, S., . . . Pate, M. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution. *The Lancet Global Health Commission*, e1196-e1252.
- Kurniawan, V. E., Putra, K. W., & Setiawan, R. (2024). IMPROVING HEALTH BEHAVIOR IN THE COMMUNITY THROUGH EMPOWERING HEALTH-AWARE COMMUNITIES. *Journal of Indonesian Public Health Service*, 30-35.
- Luisi, D. R., & Haïmel, K. (2024). Understandings of community participation and empowerment in primary health care in Emilia-Romagna, Italy: A qualitative interview study with practitioners and stakeholders. *PLoS ONE*, e0310137.
- Marrone, N. L., Nieman, C. L., & Coco, L. (2022). Community-Based Participatory Research and Human-Centered Design Principles to Advance Hearing Health Equity. *Ear and hearing*, 33S-44S.
- Nadrian, H. (2024). Primary health care and achieving universal health coverage: An emphasis on the crucial role of E-Health. *Health promotion perspectives*, 1-2.
- National Academies of Sciences, E. a., H. a., B. o., B. o., & C. o. (2018). *Crossing the Global Quality Chasm: Improving Health Care Worldwide*. Washington (DC): National Academies Press (US).
- Nutbeam, D., & Muscat, D. M. (2021). Health Promotion Glossary 2021. *Health promotion international*, 1578-1598.

- Oyebade, A., Adeyemo, C., Oshineye, A., Olanrewaju, S., Njoku, L., Oladapo, J., & Atolagbe, J. (2022). Perception of quality of primary health care services in South-West Nigeria: a cross sectional study. *International Journal Of Community Medicine And Public Health*, 3426–3432.
- Padmasawitri, T. A., Pratiwi, B., Bahana, I., Yuniar, C. T., Hanum, N., & Zazuli, Z. (2023). A Scoping Review on Interventions to Reduce the Workload of Healthcare Workers in Primary Health Care of Low- and Middle- Income Countries. *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)*.
- Qin, C., Liu, M., & Liu, J. (2024). Trends and disparities of disease burden in infections among pregnant women in 131 low-income and middle-income countries, 1990-2019. *Journal of global health*, 04130.
- Save the Children Indonesia. (2023). *Enhancing nutrition through SBCC programs in Indonesia (BISA)*. Jakarta Selatan: Save the Children Indonesia.
- Solikha, D. A., Butler, D. C., Setiawan, E., Korda, R. J., & Kelly, M. (2025). Primary health care performance measurement at the service delivery level in Indonesia: a scoping review. *BMC health services research*, 898.
- Solikha, D. A., Butler, D. C., Setiawan, E., Korda, R. J., & Kelly, M. (2025). Primary health care performance measurement at the service delivery level in Indonesia: a scoping review. *BMC health services research*, 898.
- Turnock, B. J. (2016). *Public Health: What It Is and How It Works Eighth Edition*. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- World Health Organization. (2018). *Delivering quality health services: A global imperative for universal health coverage*. Jenewa, Swiss: World Health Organization.
- World Health Organization. (2019). *Declaration of Astana on primary health care*. Jenewa, Swiss: World Health Organization.
- World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030: towards eliminating avoidable harm in health care*. Jenewa, Swiss: World Health Organization.
- World Health Organization. (2021). *Tracking universal health coverage: 2021 global monitoring report*. Jenewa, Swiss: World Health Organization.
- World Health Organization. (2023). *World health statistics 2023: Monitoring health for the SDGs*. Jenewa, Swiss: World Health Organization.
- World Health Organization. (2025). *World Report On Social Determinants Of Health Equity*. Jenewa, Swiss: World Health Organization.

J. Glosarium

COPC	:	Community-Oriented Primary Care
FGD	:	Focus Group Discussion
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MAPP	:	Mobilizing for Action through Planning and Partnerships
NCDs	:	Non-Communicable Diseases
PDCA	:	Plan–Do–Check–Act
PHBS	:	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PHC	:	Primary Health Care
QMS	:	Quality Management System
SMART	:	Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound
SOP	:	Standard Operating Procedures
TKM	:	Tenaga Kesehatan Masyarakat
UHC	:	Universal Health Coverage
WHO	:	World Health Organization

CHAPTER 6

KOLABORASI TIM KESEHATAN DALAM PELAYANAN BERKUALITAS (HEALTH CARE TEAM COLLABORATION IN QUALITY HEALTHCARE DELIVERY)

Maulia Isnaini, S.ST., Bdn., M.Keb

A. Pendahuluan

Perkembangan sistem pelayanan kesehatan di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks, termasuk meningkatnya penyakit kronis, tuntutan pelayanan berpusat pada pasien (*patient-centered care*), kebutuhan efisiensi layanan, serta peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas dan keamanan layanan kesehatan. Kompleksitas ini tidak dapat diatasi oleh satu profesi kesehatan saja, melainkan membutuhkan pendekatan kolaboratif yang terintegrasi antara dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, fisioterapis, tenaga kesehatan masyarakat, dan profesi kesehatan lainnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan bahwa **kolaborasi interprofesional (Interprofessional Collaboration/IPC)** merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. IPC didefinisikan sebagai proses ketika dua atau lebih profesi kesehatan bekerja bersama untuk memberikan pelayanan komprehensif dengan mengandalkan komunikasi efektif, koordinasi peran, dan tujuan yang sama untuk meningkatkan hasil kesehatan pasien (WHO, 2010).

Di berbagai negara, penerapan kolaborasi tim kesehatan terbukti dapat meningkatkan mutu layanan melalui penurunan angka kesalahan medis, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, serta peningkatan keselamatan pasien (*patient safety*). Studi oleh O'Leary et al. (2023) menunjukkan bahwa tim kesehatan yang menerapkan kolaborasi interprofesional secara konsisten mengalami peningkatan kualitas dokumentasi, kecepatan pengambilan keputusan klinis, dan kepuasan pasien di tingkat pelayanan primer maupun rumah sakit.

Selain itu, pendekatan berbasis bukti (*evidence-based practice/EBP*) menjadi landasan penting dalam praktik kolaboratif, memastikan bahwa keputusan klinis diambil berdasarkan data ilmiah yang kuat, pengalaman klinis, serta preferensi pasien. Kolaborasi yang mengintegrasikan EBP terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap *clinical guidelines*, memperbaiki alur pelayanan, serta mengurangi *variation of care* yang tidak perlu (Reeves et al., 2021).

Tidak hanya berdampak pada pasien, IPC juga berpengaruh signifikan terhadap lingkungan kerja tenaga kesehatan. Studi tahun 2022 oleh Kyle & Inbus menemukan bahwa kolaborasi antarprofesi yang efektif dapat menurunkan tingkat *burnout*, meningkatkan kepuasan kerja, serta menumbuhkan budaya keselamatan (*safety culture*) yang lebih baik—dua hal yang sangat penting di tengah meningkatnya beban kerja tenaga kesehatan pasca-pandemi COVID-19.

Di Indonesia, tuntutan terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga semakin kuat, sebagaimana tertuang dalam standar akreditasi rumah sakit Nasional dan pedoman Patient Safety Kementerian Kesehatan. Kolaborasi tim kesehatan menjadi prinsip utama dalam implementasi *Clinical Pathway*, *Continuity of Care*, dan Program Manajemen Terpadu Penyakit Kronis (Prolanis), yang seluruhnya menekankan pentingnya kerja lintas profesi yang sinergis dan terdokumentasi dengan baik.

Dengan demikian, kolaborasi tim kesehatan bukan hanya menjadi sebuah pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan strategis dalam memastikan mutu layanan yang efektif, aman, berkelanjutan, dan berfokus pada pasien. Integrasi antara kolaborasi interprofesional dan *evidence-based practice* menjadi dasar dalam pengembangan sistem kesehatan modern serta meningkatkan pencapaian indikator kualitas layanan kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan

B. Konsep Kolaborasi Tim Kesehatan

1. Pengertian Kolaborasi Tim Kesehatan

Kolaborasi tim kesehatan (*Interprofessional Collaboration/IPC*) adalah proses kerja sama antara dua atau lebih profesi kesehatan yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang komprehensif, berpusat pada pasien, serta didasarkan pada komunikasi efektif, peran yang jelas, dan pengambilan keputusan bersama. WHO mendefinisikan IPC sebagai “kemitraan antara tenaga kesehatan lintas profesi yang bekerja bersama pasien, keluarga, dan komunitas untuk memberikan pelayanan terbaik di seluruh situasi pelayanan kesehatan” (WHO, 2010). Pendekatan dalam kolaborasi tim kesehatan adalah suatu pendekatan kerja yang melibatkan berbagai profesi kesehatan, seperti dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, fisioterapis, dan profesi kesehatan lain, untuk mencapai tujuan pelayanan yang sama sehingga merespons kebutuhan pasien secara menyeluruh. Kolaborasi interprofesional bukan hanya sekadar bekerja berdampingan, namun merupakan *partnership* yang saling melengkapi dengan fokus pada *shared goals*, *shared responsibilities*, dan *shared accountability*. Dalam pelayanan kesehatan modern, IPC menjadi indikator penting mutu layanan, keselamatan pasien, dan efektivitas pelayanan.

2. Tujuan Kolaborasi Tim Kesehatan

Tujuan utama kolaborasi tim kesehatan meliputi:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
Termasuk efektivitas pengobatan, kecepatan layanan, dan akurasi tindakan klinis.
- b. Meningkatkan keselamatan pasien (patient safety)
Kolaborasi efektif mengurangi *medical errors* dan kesalahan komunikasi antar profesi (Reeves et al., 2021).
- c. Memberikan perawatan yang berpusat pada pasien (patient-centered care)
Pasien mendapat pelayanan yang lebih komprehensif, holistik, dan berkesinambungan.
- d. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mencegah duplikasi pemeriksaan, meningkatkan koordinasi perawatan, dan mempercepat *clinical pathway*.
- e. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan
IPC terbukti menurunkan beban kerja berlebih dan burnout (Kyle & Inbus, 2022).

3. Prinsip-Prinsip Kolaborasi Tim Kesehatan

- a. Komunikasi Efektif
Komunikasi jelas, terstruktur, dan saling menghargai menjadi inti IPC. Komunikasi yang buruk adalah penyebab utama 70% kesalahan klinis (Joint Commission, 2021).
- b. Kejelasan Peran (Role Clarity)
Setiap profesi memahami:
 - 1) kompetensi,
 - 2) wewenang,
 - 3) dan kontribusi profesi masing-masing.Ketidakjelasan peran dapat menyebabkan konflik dan duplikasi tugas (O'Leary et al., 2023).
- c. Keputusan Bersama (Shared Decision Making)
Semua anggota tim berpartisipasi aktif dalam menentukan rencana terapi dan pengambilan keputusan klinis berdasarkan *evidence-based practice*.
- d. Saling Menghargai dan Percaya
Trust adalah elemen psikologis penting yang membuat tiap anggota tim merasa dihargai dan aman untuk mengemukakan pendapat.
- e. Tujuan Bersama (Common Goal)
Seluruh tim menyepakati tujuan layanan dan bekerja secara terkoordinasi untuk mencapainya.

f. Akuntabilitas Bersama

Semua anggota bertanggung jawab terhadap hasil pelayanan dan kualitas keputusan bersama.

4. Model-Model Kolaborasi Tim Kesehatan

a. Interprofessional Team-Based Care

Tim kesehatan dari berbagai profesi memberikan pelayanan terpadu dalam satu unit atau departemen efektif dalam layanan rumah sakit dan perawatan kronis (Hudson et al., 2022).

b. Interdisciplinary Bedside Rounds (IBR)

Dokter, perawat, farmasis, dan tenaga kesehatan lain melakukan *rounding* bersama di samping pasien. Model ini meningkatkan komunikasi dan kepuasan pasien.

c. Collaborative Practice Model

Fokus pada koordinasi perawatan antara berbagai profesi pada berbagai lini layanan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan layanan rujukan.

d. Patient-Centered Collaborative Model

Semua profesi bekerja dengan memasukkan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis.

e. Virtual/Telehealth IPC Model

Kolaborasi melalui sistem digital/telemedicine—meningkat pesat setelah pandemi COVID-19 (Lateef, 2021).

C. Komponen Kunci Kolaborasi Tim Kesehatan

Komponen Kunci Kolaborasi Tim Kesehatan

Kolaborasi tim kesehatan (*Interprofessional Collaboration/IPC*) merupakan fondasi penting dalam pelayanan kesehatan modern terutama dalam mewujudkan *patient-centered care*, keselamatan pasien, dan peningkatan mutu layanan. Untuk memastikan kolaborasi berjalan efektif, beberapa komponen kunci perlu dibangun secara sistematis di tingkat individu, tim, dan organisasi.

Berikut uraian mendalam tentang komponen kunci kolaborasi tim kesehatan berdasarkan evidence-based practice:

1. Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif adalah proses pertukaran informasi yang jelas, lengkap, tepat waktu, dan saling dipahami antar profesi kesehatan. Ini adalah fondasi utama IPC.

Mengapa penting?

a. Mengurangi *medical error* hingga 70% (Joint Commission, 2021).

b. Meningkatkan koordinasi antar profesi.

- c. Mempercepat pengambilan keputusan klinis.

Elemen komunikasi efektif:

- a. Penggunaan bahasa yang jelas dan standar.
- b. Teknik komunikasi struktural seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation).
- c. Mendengarkan aktif dan empati.
- d. Dokumentasi yang akurat dan konsisten.

Contoh praktik:

- a. *Bedside handover* antara perawat dan dokter.
- b. Pertemuan harian tim (interdisciplinary rounds).

2. Kejelasan Peran (*Role Clarity*)

Kejelasan peran merupakan pemahaman setiap profesi tentang kompetensi, tanggung jawab, dan batasan tugas masing-masing dalam tim.

Mengapa penting?

- a. Mencegah tumpang tindih tugas.
- b. Mengurangi konflik antar profesi.
- c. Meningkatkan rasa saling percaya.

Komponen role clarity:

- a. Job description yang jelas.
- b. Pemahaman lintas profesi tentang peran masing-masing.
- c. Penetapan tujuan dan kontribusi setiap profesi terhadap rencana perawatan.

3. Tujuan Bersama (*Shared Goals*)

Tujuan bersama adalah sasaran yang disepakati oleh semua anggota tim dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Penting karena:

- a. Menyatukan arah kerja tim.
- b. Membantu menyusun rencana perawatan yang komprehensif.
- c. Meningkatkan efisiensi koordinasi.

Contoh:

Rencana perawatan terintegrasi untuk pasien kanker yang mencakup aspek medis, keperawatan, gizi, psikososial, dan farmasi.

4. Pengambilan Keputusan Bersama (*Shared Decision-Making*)

Merupakan proses membuat keputusan klinis secara kolaboratif berdasarkan bukti ilmiah, keahlian klinis, dan preferensi pasien.

Kegunaan:

- a. Meningkatkan efektivitas perawatan.
- b. Mengurangi bias keputusan individual.
- c. Meningkatkan keterlibatan pasien.

Praktiknya meliputi:

- a. Diskusi terbuka antar profesi.
- b. Konsultasi multidisipliner.
- c. Melibatkan pasien dan keluarga dalam keputusan klinis penting.

5. Koordinasi Tim (*Team Coordination*)

Koordinasi adalah pengaturan kegiatan dan sumber daya antar anggota tim untuk mencapai pelayanan efektif dan efisien.

Komponen koordinasi efektif:

- a. Penjadwalan layanan yang sinkron.
- b. Penggunaan *clinical pathway*.
- c. Sistem rujukan internal yang jelas.
- d. Adanya pemimpin tim yang memfasilitasi koordinasi.

Dampak positif:

- a. Mengurangi keterlambatan layanan.
- b. Meningkatkan kontinuitas perawatan pasien.

6. Kepemimpinan Kolaboratif (*Collaborative Leadership*)

Gaya kepemimpinan yang mendorong partisipasi, menghargai kompetensi semua profesi, dan memfasilitasi kerja sama.

Ciri kepemimpinan kolaboratif:

- a. Tidak hirarkis secara kaku.
- b. Mengutamakan fasilitasi, bukan komando.
- c. Mendorong komunikasi dua arah.
- d. Mampu menyelesaikan konflik.

Efek:

- a. Meningkatkan motivasi kerja tim.
- b. Mengurangi stres dan burnout.

7. Dokumentasi Terpadu (*Integrated Documentation*)

Dokumentasi yang dapat diakses oleh semua profesi kesehatan untuk memastikan informasi klinis tersampaikan dengan akurat dan konsisten.

Elemen:

- a. *Electronic Medical Record (EMR)*.

- b. Standar dokumentasi antar profesi.
- c. Catatan yang lengkap dan real-time.

Manfaat:

- a. Mengurangi miskomunikasi.
- b. Meningkatkan keselamatan pasien.
- c. Mempercepat rujukan dan koordinasi.

8. Lingkungan Kerja dan Budaya Kolaboratif

Budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, rasa saling menghargai, dan kepercayaan antar profesi.

Mengapa penting?

Budaya organisasi menentukan keberhasilan IPC lebih dari 50% (WHO, 2020).

Aspek budaya kolaboratif:

- a. Tidak ada diskriminasi antar profesi.
- b. Menghargai kompetensi semua tenaga kesehatan.
- c. Mengutamakan keselamatan pasien.
- d. Mendorong pembelajaran tim.

9. Pendidikan Interprofesional (*Interprofessional Education/IPE*)

Pendekatan pendidikan yang melibatkan mahasiswa atau tenaga kesehatan dari berbagai profesi belajar bersama untuk meningkatkan keterampilan kolaboratif.

Dampak IPE berdasarkan penelitian 2021–2023:

- a. Mengurangi stereotip antar profesi.
- b. Meningkatkan kemampuan komunikasi.
- c. Membentuk mindset kolaboratif sejak dini.
- d. Meningkatkan kualitas praktik klinis.

Contoh implementasi:

- a. Simulasi bersama mahasiswa kedokteran, keperawatan, farmasi.
- b. Workshop IPC di rumah sakit.

10. Teknologi Pendukung Kolaborasi

Penggunaan teknologi informasi dan telehealth untuk mendukung komunikasi, koordinasi, dan dokumentasi.

Contoh:

- a. Telemedicine untuk konsultasi antar profesi.
- b. Aplikasi monitoring pasien kronis.

- c. Dashboard kolaboratif untuk rekam medis.

Manfaat:

- a. Mempercepat proses kolaboratif.
- b. Menghilangkan hambatan waktu dan jarak.
- c. Meningkatkan efektivitas koordinasi.

11. Mekanisme Evaluasi Kolaborasi

Kolaborasi harus dievaluasi untuk memastikan tim berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu layanan.

Elemen evaluasi:

- a. Audit komunikasi.
- b. Penilaian kinerja tim.
- c. Evaluasi patient outcome.
- d. Pengukuran keselamatan pasien.
- e. Survey kepuasan tenaga kesehatan.

Instrumen yang sering digunakan:

- a. *IPC-AQ (Interprofessional Collaboration Assessment Questionnaire)*
- b. *TeamSTEPPS Teamwork Perception Questionnaire*
- c. *Collaborative Practice Assessment Tool (CPAT)*

D. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kolaborasi

Kolaborasi interprofesional merupakan pendekatan yang menempatkan berbagai tenaga kesehatan untuk bekerja bersama secara sinergis dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien. Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk kompetensi individu, dinamika tim, kultur organisasi, pemimpin, serta faktor sistem pelayanan kesehatan.

1. Faktor Individu (*Individual-Level Factors*)

a. Pengetahuan dan Kompetensi Profesional

Keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan setiap profesional dalam memahami perannya dan peran profesi lain. Kompetensi klinis, komunikasi, dan pengambilan keputusan merupakan dasar terbentuknya kerja interprofesional yang efektif.

b. Sikap terhadap Kolaborasi

Sikap terbuka, saling menghargai, dan kesediaan bekerja lintas profesi menentukan kualitas hubungan profesional. Hambatan biasanya muncul jika terdapat stereotip profesi atau ketidaksetaraan peran.

- c. Kecerdasan Emosional dan Empati
Tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan regulasi emosi, empati, dan kemampuan sosial lebih mudah membangun interaksi efektif dalam tim.
- 2. Faktor Tim (*Team-Level Factors*)
 - a. Komunikasi Efektif
Komunikasi terbuka, jelas, dan terstruktur menjadi inti kolaborasi. Kesalahan komunikasi merupakan penyebab utama insiden keselamatan pasien.
 - b. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab
Kolaborasi berhasil ketika setiap anggota memahami perannya dan menghargai kontribusi profesi lain. Overlap peran tanpa kejelasan dapat memicu konflik.
 - c. Kepercayaan dan Mutual Respect
Kepercayaan antar anggota tim meningkatkan kenyamanan dalam menyampaikan pendapat, feedback, dan kritik.
 - d. Mekanisme Resolusi Konflik
Tim yang memiliki prosedur penyelesaian konflik yang sehat mampu mempertahankan produktivitas dan kualitas layanan.
- 3. Faktor Organisasi (*Organizational-Level Factors*)
 - a. Kepemimpinan (*Leadership*)
Pemimpin yang mendukung kolaborasi akan mendorong budaya teamwork, mencegah silo profesi, dan memastikan koordinasi layanan berjalan optimal.
 - b. Budaya Organisasi (*Organizational Culture*)
Budaya kerja yang kolaboratif mendorong komunikasi terbuka, partisipasi, dan pemberdayaan anggota tim.
 - c. Dukungan Sumber Daya
Fasilitas memadai seperti ruangan rapat kolaboratif, SIMRS terintegrasi, alat komunikasi, dan jadwal pertemuan interprofesional mendorong tercapainya koordinasi.
 - d. Kebijakan dan SOP Kolaboratif
Adanya SOP kolaboratif, clinical pathway, dan standar interprofessional practice mempermudah kolaborasi.
- 4. Faktor Sistem Pelayanan Kesehatan (*System-Level Factors*)
 - a. Regulasi dan Kebijakan Nasional
Dukungan regulasi seperti standar akreditasi rumah sakit, kebijakan praktik kolaboratif, dan sistem rujukan memengaruhi implementasi kolaborasi.
 - b. Sistem Pembayaran dan Insentif
Model pembiayaan berbasis nilai (*value-based care*) mendorong kolaborasi karena menekankan hasil kesehatan pasien, bukan volume layanan.

- c. Teknologi dan Integrasi Informasi Kesehatan
Sistem digital seperti Electronic Health Record (EHR) mempermudah koordinasi.
- 5. Faktor Pasien dan Keluarga
 - a. Keterlibatan Pasien (Patient Engagement)
Kolaborasi yang efektif melibatkan pasien/keluarga dalam proses pengambilan keputusan.
 - b. Kompleksitas Kondisi Pasien
Pasien dengan penyakit kronis dan komorbid membutuhkan kolaborasi intensif dan koordinasi lintas profesi.
- 6. Faktor Lingkungan Kerja (*Work Environment Factors*)
 - a. Beban Kerja dan Burnout
Burnout tenaga kesehatan dapat mengurangi kemampuan berkolaborasi.
 - b. Ketersediaan Waktu untuk Kolaborasi
Tim membutuhkan waktu untuk komunikasi, briefing, debriefing, dan pertemuan case conference.

Faktor keberhasilan kolaborasi tim kesehatan bersifat multidimensi dan melibatkan aspek individu, tim, organisasi, sistem, lingkungan kerja, serta keterlibatan pasien. Upaya peningkatan kolaborasi membutuhkan pendekatan holistik termasuk pelatihan interprofesional, penguatan budaya organisasi, dukungan regulasi, dan integrasi teknologi.

Faktor Pendukung

1. Dukungan manajemen dan kebijakan rumah sakit.
2. Sistem komunikasi dan teknologi informasi yang baik.
3. Pelatihan komunikasi dan manajemen konflik.
4. Kejelasan job description.
5. Lingkungan kerja non-hierarkis.

Faktor Penghambat

1. Hierarki profesi yang terlalu kaku.
2. Ego profesi dan stereotip antar profesi.
3. Kurangnya waktu bersama untuk koordinasi.
4. Komunikasi yang buruk.
5. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab.

E. Dampak Kolaborasi Tim Kesehatan terhadap Mutu Pelayanan

Kolaborasi tim kesehatan merupakan pilar penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan modern. Ketika dokter, perawat, bidan, apoteker, fisioterapis, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan profesi lain bekerja secara sinergis, maka kualitas layanan meningkat secara signifikan. Perawatan menjadi lebih aman, efektif, efisien, dan berpusat pada pasien. Dampak kolaborasi dapat dilihat pada dimensi mutu pelayanan WHO, termasuk keselamatan pasien, efektivitas klinis, efisiensi, aksesibilitas, kesinambungan layanan, serta pengalaman pasien.

1. Dampak terhadap Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)
 - a. Penurunan Medical Error
Komunikasi antarprofesi yang baik mengurangi insiden kesalahan medis seperti pemberian obat yang salah, miskomunikasi perintah dokter, atau kesalahan identifikasi pasien.
 - b. Peningkatan Deteksi Dini Risiko
Tim yang berkolaborasi dapat mengidentifikasi perubahan kondisi pasien lebih cepat, sehingga mencegah komplikasi.
2. Dampak terhadap Efektivitas Klinis (*Clinical Effectiveness*)
 - a. Keputusan Klinis Lebih Akurat
Diskusi antarprofesi menghasilkan perspektif yang lebih lengkap dan meningkatkan akurasi diagnosis dan terapi.
 - b. Peningkatan Kualitas Intervensi
Kolaborasi memungkinkan perencanaan perawatan terkoordinasi dan komprehensif sesuai kebutuhan bio-psiko-sosial pasien.
3. Dampak terhadap Efisiensi Pelayanan (*Efficiency*)
 - a. Pengurangan Duplikasi Tindakan
Dengan komunikasi terintegrasi, tim menghindari pemeriksaan atau intervensi yang tidak perlu.
 - b. Optimalisasi Alur Kerja (*Workflow*)
Perencanaan kolaboratif mengurangi waktu tunggu, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kapasitas pelayanan.
4. Dampak terhadap Pengalaman Pasien (*Patient Experience*)
 - a. Peningkatan Kepuasan Pasien
Kolaborasi meningkatkan kualitas komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien.
 - b. Perawatan lebih berpusat pada pasien
Pasien merasa lebih didengar, dilibatkan, dan mendapatkan informasi yang lebih jelas ketika tim bekerja bersama.

- c. Peningkatan *Continuity of Care*
Kolaborasi memudahkan transisi perawatan antar unit (IGD rawat inap rawat jalan), sehingga pasien tidak mengalami fragmentasi layanan.
- 5. Dampak terhadap Hasil Klinis (*Clinical Outcomes*)
 - a. Penurunan Angka Morbiditas dan Mortalitas
Kolaborasi meningkatkan kualitas intervensi sehingga mengurangi angka komplikasi.
 - b. Kontrol Penyakit Lebih Baik
Pada pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi, DM, atau kanker, model perawatan kolaboratif terbukti meningkatkan kualitas hidup.
- 6. Dampak terhadap Ketenagakerjaan dan Kinerja Tenaga Kesehatan
 - a. Penurunan Burnout
Tim yang bekerja dalam kolaborasi memiliki dukungan sosial lebih tinggi sehingga burnout berkurang.
 - b. Peningkatan Kepuasan Kerja
Kolaborasi menciptakan lingkungan kerja positif, meningkatkan motivasi dan retensi tenaga kesehatan.
 - c. Kompetensi Profesional Meningkat
Kolaborasi memfasilitasi pembelajaran lintas profesi dan meningkatkan kemampuan klinis.
- 7. Dampak terhadap Sistem Pelayanan Kesehatan Secara Keseluruhan
 - a. Penguatan Sistem Rujukan
Kolaborasi meningkatkan koordinasi antar fasilitas (puskesmas–RS–klinik).
 - b. Efisiensi Pembiayaan Sistem Kesehatan
Model *value-based care* terbantu dengan kolaborasi karena fokus pada outcome, bukan volume.
 - c. Peningkatan Akreditasi dan Standar Mutu
Akreditasi rumah sakit (*mis. SNARS*) menekankan kolaborasi sebagai indikator utama mutu layanan.

Hasil penelitian menunjukkan IPC berdampak positif terhadap:

- 1. Keselamatan Pasien
Mengurangi kesalahan medis, *adverse events*, dan meningkatkan monitoring klinis. (Studi Reeves et al., 2021; Joint Commission, 2021)
- 2. Efektivitas Pelayanan
Peningkatan akurasi diagnosis, kecepatan penanganan, dan perawatan berkelanjutan (Hudson et al., 2022).

3. Pengalaman Pasien

Pasien merasa dihargai, dipahami, dan mendapatkan pelayanan komprehensif.

4. Biaya Kesehatan

Kolaborasi mengurangi rawat inap yang terlalu panjang dan pemeriksaan tidak perlu.

5. Kinerja Tenaga Kesehatan

Menurunnya konflik, meningkatnya rasa saling percaya, serta meningkatnya kepuasan kerja.

F. Tantangan Masa Depan Kolaborasi Tim Kesehatan

Kolaborasi tim kesehatan merupakan fondasi bagi sistem pelayanan kesehatan yang efektif, aman, dan berfokus pada pasien (*patient-centered care*). Walaupun manfaatnya sudah terbukti, penerapan kolaborasi secara konsisten masih menghadapi sejumlah tantangan kompleks—terutama di era kesehatan modern yang terus berubah. Tantangan ini bersifat struktural, budaya, teknologi, pendidikan, dan kebijakan.

Tantangan Pendidikan dan Kompetensi Interprofesional

1. Integrasi Interprofessional Education (IPE) di Kurikulum

Walaupun IPE semakin diakui sebagai strategi penting untuk membangun kompetensi kolaboratif, banyak sekolah kesehatan masih belum mengintegrasikannya secara sistematis dalam kurikulum.

Permasalahan utama:

- a. Kurikulum terfragmentasi antar profesi
- b. Waktu pendidikan yang terbatas
- c. Hambatan logistik dan sumber daya pembelajaran bersama

2. Tantangan Budaya Organisasi dan Kepemimpinan

a. Budaya Kerja Dominan Satu Profesi

Budaya hierarkis yang kuat dalam organisasi kesehatan (mis. dominasi profesi medis) dapat menghambat komunikasi dan integrasi peran antar profesi.

b. Kepemimpinan Kolaboratif

Pemimpin yang tidak memiliki keterampilan fasilitasi atau yang lebih condong pada pendekatan top-down akan menyulitkan terbentuknya tim kolaboratif yang sehat.

3. Tantangan Transformasi Sistem Kesehatan dan Kebijakan
 - a. Fragmentasi Sistem dan Regulasi

Sistem kesehatan yang terpisah-pisah (termasuk peraturan masing-masing profesi) meninggalkan gap dalam koordinasi antarfasilitas dan memperumit interoperabilitas antar lembaga.
 - b. Ketidaksesuaian Kebijakan dengan Praktik Kolaboratif

Kebijakan sering mendukung kolaborasi secara umum, tetapi implementasi di lapangan masih terhambat karena kurangnya standar operasional atau mekanisme insentif yang jelas.
4. Tantangan Teknologi dan Integrasi Sistem Informasi
 - a. Interoperabilitas Rekam Medis Elektronik

EHR (*Electronic Health Record*) yang tidak saling terintegrasi antar fasilitas kesehatan menjadi hambatan besar dalam pertukaran informasi antar tim.
 - b. Kesenjangan Digital dan Ketidakmerataan Akses

Tenaga kesehatan di daerah yang tidak memiliki infrastruktur digital memerlukan dukungan untuk dapat berkolaborasi secara efektif.
5. Tantangan Kualitas Data dan Pembuktian Dampak Kolaborasi
 - a. Kesulitan Pengukuran Efektivitas Kolaborasi

Masih terdapat keterbatasan instrumen valid dan reliabel untuk mengukur kolaborasi lintas profesi secara akurat dan komprehensif.
 - b. Bukti Dampak yang Heterogen

Meski banyak studi menyatakan manfaat IPC, heterogenitas desain studi, konteks, dan indikator outcome membuat meta-analisis dan generalisasi hasil masih menantang.
6. Tantangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Profesional
 - a. Burnout dan Kelelahan Kerja

Burnout yang tinggi pada tenaga kesehatan dapat menghambat kemampuan individu untuk berkolaborasi secara efektif, terutama dalam konteks tekanan kerja tinggi dan kekurangan staf.
7. Tantangan Globalisasi dan Mobilitas Tenaga Kesehatan
 - a. Standarisasi Kompetensi Lintas Negara

Mobilitas tenaga kesehatan antar negara memerlukan sistem kompetensi dan standar kolaborasi yang konsisten, agar dapat bekerja efektif dalam konteks lintas budaya dan sistem kesehatan yang berbeda.
 - b. Tantangan Multikultural dalam Tim

Tim yang terdiri dari latar budaya dan bahasa yang berbeda memerlukan strategi komunikasi dan manajemen konflik yang lebih matang.

8. Tantangan Perubahan Epidemiologi dan Layanan Kesehatan Modern

a. Penyakit Kronis dan Polikomorbiditas

Kasus dengan penyakit kompleks membutuhkan koordinasi lintas spesialisasi dan profesi yang lebih intensif, serta integrasi layanan lanjutan (*continuity care*).

b. Teknologi Baru dan Big Data

Penggunaan *AI*, *machine learning*, dan big data dalam diagnosis/terapi memerlukan tim kolaboratif yang mampu memadukan data teknis dengan keputusan klinis.

Tabel 6.1
Ringkasan Tantangan Masa Depan

Kategori Tantangan	Arah Hambatan
Pendidikan & Kompetensi	Integrasi kurikulum IPE, pelatihan kolaboratif
Budaya & Kepemimpinan	Hierarki profesi, budaya top-down
Sistem & Kebijakan	Fragmentasi layanan, regulasi tidak sejalan
Teknologi	Interoperabilitas EHR, digital inequality
Data & Bukti	Pengukuran outcome, heterogenitas studi
Tenaga Kerja	Burnout, retensi staf
Globalisasi	Standarisasi kompetensi, multikultural
Epidemiologi	Kompleksitas kasus, big data

G. Simpulan

Kolaborasi tim kesehatan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien. Dalam era kompleksitas sistem kesehatan modern, tidak ada profesi kesehatan yang dapat bekerja secara terisolasi. Integrasi kompetensi, komunikasi efektif, koordinasi tindakan, dan pengambilan keputusan bersama menjadi faktor kunci yang memastikan pelayanan berkualitas tinggi dan memberikan hasil yang optimal bagi pasien.

Kolaborasi interprofesional terbukti meningkatkan keselamatan pasien, mengurangi kesalahan medis, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan efektivitas klinis. Tidak hanya berdampak pada pasien, kolaborasi juga meningkatkan kepuasan dan kinerja tenaga kesehatan dengan menurunkan burnout dan memperkuat budaya kerja positif. Bagi sistem kesehatan secara keseluruhan, kolaborasi membantu meningkatkan efisiensi, memperkuat rujukan,

dan mendukung pencapaian standar mutu nasional maupun global. Di masa depan, kolaborasi akan semakin penting karena tantangan seperti penyakit kronis, perkembangan teknologi digital, dan globalisasi tenaga kesehatan menuntut integrasi kerja lintas-profesi yang lebih kuat. Meski berbagai tantangan seperti fragmentasi sistem, perbedaan budaya profesi, dan keterbatasan teknologi informasi masih ada, peningkatan pendidikan interprofesional, kepemimpinan kolaboratif, serta penguatan kebijakan kesehatan dapat menjadi kunci keberhasilan.

Secara keseluruhan, kolaborasi tim kesehatan bukan hanya strategi kerja, tetapi merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan pasien. Implementasi kolaborasi yang konsisten dan berbasis bukti akan membawa manfaat besar bagi pasien, tenaga kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

H. Referensi

- Azhar et al. (2022). Attitudes towards interprofessional collaboration among healthcare providers. *BMC Health Services Research*.
- Chan EA, et al. Interprofessional education and collaborative practice: Recent advancements. *Nurse Education Today*. 2022.
- Hudson P, et al. The role of interprofessional collaboration in the management of chronic diseases: A 2022 scoping review. *Health Services Research*. 2022;57(6):1109-1123.
- Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Penguatan Budaya Keselamatan Pasien*. Jakarta: Kemenkes RI; 2020.
- Kementerian Kesehatan RI. *Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS Edisi 1.1)*. Jakarta: KARS; 2021.
- Kyle J, Inbus S. Impact of Interprofessional Collaboration on Healthcare Worker Burnout and Safety Culture: A Cross-sectional Study. *BMC Health Services Research*. 2022;22:1184.
- Lateef F. Patient-centered care and interdisciplinary teamwork: Essential elements of high-quality healthcare delivery. *Journal of Emergencies, Trauma, and Shock*. 2021;14(3):177-185.
- Leonard et al. (2020). The role of communication failures in patient safety. *The Joint Commission Journal*.
- O'Leary KJ, et al. Interprofessional collaboration improves clinical decision-making and patient outcomes: A systematic review. *Journal of Interprofessional Care*. 2023;37(4):580-589.

- Reeves S, Pelone F, Harrison R, Goldman J, Zwarenstein M. Interprofessional collaboration and patient outcomes: Updated systematic review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2021; Issue 1.
- Salas et al. (2021). Emotional intelligence and teamwork performance. *Medical Education*.
- The Joint Commission. Root cause analysis of sentinel events. 2021.
- World Health Organization (2021). Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice.
- World Health Organization. *Global Competency Framework for Universal Health Coverage*. WHO; 2020.
- Zwarenstein M, et al. The role of communication tools in IPC: Evidence from recent trials. *BMJ Quality & Safety*. 2020.

I. Glosarium

A

Akurasi Klinis

Ketepatan tenaga kesehatan dalam menegakkan diagnosis, memberikan intervensi, dan mendokumentasikan tindakan.

Assessment (Pengkajian)

Proses pengumpulan data pasien secara sistematis untuk menentukan masalah kesehatan dan kebutuhan pasien.

B

Burnout

Kondisi kelelahan fisik dan emosional yang dapat menurunkan kemampuan tenaga kesehatan berkolaborasi.

C

Care Coordination

Pengaturan dan pengintegrasian semua layanan pasien agar kesinambungan pelayanan tetap terjaga.

Clinical Pathway

Rencana perawatan terstandar yang mendukung koordinasi lintas profesi.

Communication Breakdown

Gangguan atau kegagalan komunikasi antar tenaga kesehatan yang dapat menghambat kolaborasi.

Collaborative Practice

Model praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh berbagai profesi secara sinergis.

Conflict of Roles

Ketidaksesuaian pemahaman tentang tugas dan fungsi tiap profesi dalam tim.

D

Decision-Making (Pengambilan Keputusan)

Proses menentukan tindakan terbaik bagi pasien secara kolektif dalam tim kesehatan.

Delegasi

Pelimpahan tugas antar tenaga kesehatan berdasarkan kompetensi dan kewenangan.

E

Empati

Kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami kondisi dan perspektif pasien maupun anggota tim lainnya.

Evidence-Based Practice (EBP)

Pengambilan keputusan klinis berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia.

F

Fragmentasi Layanan

Pelayanan yang tidak terintegrasi sehingga menyebabkan duplikasi tindakan, kesalahan komunikasi, atau hambatan kolaborasi.

I

Interprofessional Collaboration (Kolaborasi Interprofesional)

Kerja sama berbagai profesi kesehatan untuk mencapai hasil klinis yang optimal.

Interprofessional Education (IPE)

Pendidikan yang mengajarkan kolaborasi lintas profesi sejak masa pendidikan formal.

Interprofessional Teamwork

Kerja sama tim yang melibatkan banyak profesi dengan tujuan yang sama dalam perawatan pasien.

K

Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Upaya meminimalkan risiko kesalahan dalam pelayanan kesehatan melalui praktik kolaboratif.

Komunikasi Efektif

Pertukaran informasi yang jelas, tepat, dan tervalidasi antar tenaga kesehatan.

Kompetensi Kolaborasi

Kemampuan tenaga kesehatan dalam bekerja sama, berkomunikasi, menghargai peran profesional lain, dan menyelesaikan konflik.

L

Leadership (Kepemimpinan)

Kemampuan mengelola, memotivasi, dan mengarahkan tim menuju tujuan pelayanan yang berkualitas.

M

Mutu Pelayanan Kesehatan

Derajat kesempurnaan pelayanan yang memenuhi standar profesi, aman, efektif, efisien, dan berorientasi pada pasien.

O

Outcome Klinis

Hasil yang dapat diukur dari pelaksanaan layanan kesehatan, seperti kecepatan pemulihan, angka kesakitan, atau kepuasan pasien.

P

Patient-Centered Care

Pelayanan yang menempatkan kebutuhan dan preferensi pasien sebagai pusat keputusan kolaboratif.

Peran dan Tanggung Jawab

Batasan tugas tiap profesi dalam tim, termasuk kewenangan klinis dan administratif.

R

Role Clarity (Kejelasan Peran)

Pemahaman yang jelas oleh setiap anggota tim mengenai tugas dan fungsi masing-masing profesi.

Resiliensi Tim

Kemampuan tim kesehatan untuk tetap berfungsi optimal dalam situasi stres atau perubahan.

S

Shared Goals (Tujuan Bersama)

Kesepakatan tim terkait sasaran perawatan pasien, prioritas, dan rencana intervensi.

Shared Decision-Making

Proses membuat keputusan klinis secara bersama antara pasien dan tim kesehatan.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Panduan resmi yang mengatur proses layanan untuk mendukung praktik kolaborasi.

T

Team-Based Care

Pelayanan yang diberikan oleh tim multiprofesi dengan koordinasi yang terstruktur.

Transdisciplinary Collaboration

Model kolaborasi yang lebih fleksibel, di mana batasan peran profesi menjadi lebih luwes sesuai kompetensi.

V

Visi Bersama

Tujuan jangka panjang tim dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas secara kolaboratif

CHAPTER 7

EVALUASI MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN

Suriani, S.Si., M.Kes

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia yang paling mendasar dalam kehidupan kemasyarakatan paling utama adalah kesehatan. Pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan bermutu sesuai standar pelayanan merupakan hak semua individu untuk menikmatinya. Perhatian dan kewaspadaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang tidak bermutu menjadi perhatian utama, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan di fasyankes sebagai sarana umum dan tempat mandiri praktek dan dokter gigi, laboratorium kesehatan, dan UTD harus semakin tinggi. Pelayanan yang bermutu tidak hanya dilihat dari kesembuhan fisik pasien, tetapi juga dari aspek keamanan, kenyamanan, serta kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan.

Tolok ukur kinerja utama dari fasilitas pelayanan kesehatan mengacu pada ketentuan PMK No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan (untuk Klinik swasta mandiri, Puskesmas, RS, Lab, UTD) dan Permenkes No. 6 Tahun 2024 yang mencabut PMK No. 4 Tahun 2019, mengatur pemenuhan SPM kesehatan, sangat menekankan pada indikator mutu dan pemantauan berjenjang untuk menjamin kualitas pelayanan dasar secara nasional dan menyeluruh.

Menurut Ruly Prapitasari, et.all, 2020, aspek fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan, kepuasan, dan pemenuhan hak pasien berdasarkan pada standar dan kode etik merupakan salah satu mutu pelayanan kesehatan. Evaluasi mutu pelayanan faskes yang bermutu dilaksanakan untuk dapat menggambarkan pencapaian terselenggaranya pelayanan kesehatan pada kepuasan pengguna layanan dari aspek klinis, aspek etika, profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas layanan yang aman dan berkualitas, fasyankes dituntut untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan secara global.

Sudah sepatutnya pelayanan kesehatan yang bermutu ditetapkan oleh lembaga kesehatan dunia berorientasi pada pasien untuk meningkatkan kesadaran akan pelayanan yang diharapkan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi

kedokteran saat ini yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Sudah sepatutnya penyedia pelayanan melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem, proses dan sumber daya yang dimiliki.

Mengacu pada dimensi mutu, parameter yang digunakan berdasarkan fungsinya melalui pendekatan mutu pelayanan kesehatan yang meliputi dimensi secara luas, termasuk didalamnya *patient safety*, efektivitas pelayanan, efisiensi SDM, mudah terjangkau, kesinambungan layanan, serta penghormatan terhadap nilai dan preferensi pasien (Ruly Prapitasari, et.all, 2020).

Oleh karena itu, strategi evaluasi mutu pelayanan fasilitas kesehatan meliputi fasilitas kesehatan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan manajemen dan peningkatan daya saing, tenaga kesehatan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja dalam memberikan asuhan medis serta masyarakat menjamin kenyamanan dan keamanan pasien untuk hidup yang berkualitas, efektif efisien, dan berpusat pada pasien (*patient-centered care*).

B. Konsep Mutu dan Dimensi Mutu

Konsep dan dimensi mutu pelayanan kesehatan didasarkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang memenuhi kriteria dan profesi untuk dapat memenuhi keinginan setiap pasien selaku pengguna layanan kesehatan sesuai dengan tingkat keinginan rata-rata masyarakat dalam penyelenggaranya sesuai dengan standar dan kode etik profesi (Ruly dan Nurul, 2020). Evaluasi mutu fasyankes dijadikan sebagai prioritas utama, jika pelayanan dan sarana pemberi pelayanan buruk kita sebagai *customer*, akan dalam memilih jenis pelayanan yang dibutuhkan akan berkeinginan pelayanan yang berkualitas tinggi dan unggul. Terlepas dari alasan apapun, mutu tetap mengutamakan keinginan pelanggan (*customer focused quality*). Oleh sebab itu jenis layanan atau fasyankes didesain berdasarkan *supply*, *demand* dan *need*, sehingga produk dalam bentuk pelayanan yang diberikan untuk memenuhi keinginan pelanggan atau *customer* dapat dimanfaatkan dengan maksimal, efektif efisien dan benar.

Konsep mutu adalah standar keunggulan suatu produk/jasa untuk dapat mencukupi dan melengkapi keinginan *customer*, bersifat dinamis, dan bisa ditingkatkan sesuai standar mutu. Berorientasi pelanggan merupakan konsep mutu dengan pendekatan manajemen mutu yang menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama, dengan fokus pada pemenuhan dan bahkan melebihi harapan mereka melalui perbaikan berkelanjutan pada produk, layanan, proses, dan sumber daya manusia. Intinya, fasilitas kesehatan selaku pemberi pelayanan berusaha keras memahami kebutuhan pelanggan (baik yang terlihat maupun

tersembunyi) dan merancang segala sesuatu dimulai dari kompetensi tenaga kesehatan dan alat-alat kesehatan agar sesuai atau bahkan melampaui ekspektasi tersebut, sehingga mendorong pelayanan fasilitas kesehatan loyal dengan keunggulan kompetitif jangka panjang.

Evaluasi mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan tanggapan pelanggan terhadap mutu produk atau layanan adalah opini, ulasan, dan evaluasi langsung dari konsumen mengenai kesesuaian antara harapan mereka dengan kinerja aktual yang mereka terima. Tanggapan pelanggan sangat penting karena mutu yang tinggi berbanding lurus dengan kepuasan pelanggan, yang akan meningkatkan loyalitas dan pembelian ulang. Beberapa hal penting mengenai tanggapan pelanggan terhadap mutu adalah:

1. Dimensi penilaian utama adalah pelanggan menilai mutu melalui 5 dimensi utama: bukti langsung (fasilitas), kehandalan (akurat/sesuai janji), daya tanggap (kecepatan), jaminan (rasa aman), dan empati.
2. Faktor kepuasan, pasien cenderung puas jika petugas kesehatan bersikap ramah, profesional, cepat tanggap, dan fasilitas yang tersedia memadai/nyaman.
3. Penyebab ketidakpuasan, pelanggan tidak puas saat diacuhkan, dibiarkan menunggu tanpa penjelasan, petugas tidak sopan, atau komunikasi yang buruk.
4. Hubungan mutu dengan kepuasan, jika pelayanan lebih besar dari harapan, pengguna jasa sangat puas atau sama dengan harapan, maka pengguna jasa dikategorikan puas.
5. Dampak mutu pelayanan yang baik meningkatkan kepercayaan pasien dan mendorong mereka untuk kembali atau merekomendasikan layanan tersebut.

Mutu pelayanan yang baik tidak hanya menciptakan kepuasan sesaat, tetapi juga membangun loyalitas agar pasien bersedia kembali atau merekomendasikan layanan tersebut kepada orang lain

Dimensi mutu merupakan parameter kualitas suatu jenis layanan. Pada sisi yang berbeda pelayanan kesehatan akan memiliki makna yang berbeda bila ditinjau pada sudut pelanggan atau penyedia layanan (Ruly dan Nurul, 2020). Sudut pandang tersebut adalah:

1. Pasien sebagai pemakai jasa pelayanan kesehatan mempunyai sudut pandang terhadap faskes, lebih berfokus pada kualitas interaksi, kecepatan pelayanan, dan aksesibilitas, terutama dengan dominasi penggunaan BPJS Kesehatan.
2. Rumah sakit, puskesmas dan fasyankes lainnya sebagai pemberi layanan kesehatan, mengasosiasikan dan ketersediaan peralatan yang lengkap, diterapkan SOP kerja, keleluasaan staf medis layanan kesehatan yang bermutu untuk melaksanakan layanan berdasarkan perkembangan teknologi kesehatan

yang mutakhir akan menghasilkan layanan kesehatan yang bermutu serta akurat.

3. Penjamin biaya pelayanan kesehatan asuransi kesehatan BPJS, Jamsostek atau asuransi swasta lainnya menilai kelayakan layanan kesehatan sebagai layanan bermutu adalah layanan yang akurat, efektif dan efisien. Biaya pengobatan dikemas bentuk paket dengan harapan pasien dapat sembuh dalam waktu yang telah ditentukan.
4. Sudut pandang provider berpendapat bahwa pelayanan yang bermutu merupakan layanan efektif efisien dengan pendapatan lebih besar dari biaya oprasional dan pemeliharaan sehingga mendapatkan deviden yang maksimal.
5. Tim manajemen atau administrator layanan kesehatan ikut memberikan pelayan secara tidak langsung kepada masyarakat dan berkontribusi dalam masalah mutu layanan kesehatan. Peran utama administrator adalah melakukan evaluasi mutu pelayan pada fasyankes sesuai standar nasional mutu.

Pendekatan kualitas pelayanan fasyankes untuk evaluasi mutu layanan sebagai bahan acuan penilaian kualitas jasa pelayanan adalah metode SERVQUAL (Service Quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithmal, dan Berry (1990). Dasar dari model SERVQUAL adalah untuk mengukur mutu layanan dengan menyamakan konsep kinerja aktual untuk pelanggan. Kualitas layanan dianggap bermutu jika kinerja melebihi atau sesuai harapan, dan sebaliknya.

Evaluasi mutu pelayanan mengacu pada lima dimensi yaitu model SERVQUAL. Model ini berfokus pada lima kesenjangan (*gap*) utama, dengan *gap* kelima perbedaan antara harapan dan pengalaman nyata sebagai fokus utama pengukuran. Model SERVQUAL sebagai instrument untuk mengukur kualitas pelayanan yang sudah disederhanakan untuk mengukur kualitas pelayananan.

Menurut Zheithalm et al dalam Arief (2017:11), ada 5 kelompok karakteristik yang dipergunakan customer untuk mengevaluasi kualitas jasa pelayanan, yaitu :

1. *Tangibles* merupakan bukti fisik, meliputi fasilitas fisik fasyankes berupa bangunan, alat kesehatan, peralatan kantor, SDM, sarana prasarana, alat komunikasi. Produk layanan secara fisik dapat disentuh, dipegang dan dapat dirasakan hasil yang diperolehnya. Untuk itu diperlukan alat ukur lain supaya pasien dapat merasakan secara nyata. Tersedia ruang pendaftaran pasien yang bersih, wangi, sejuk, indah, tempat duduk, adanya sarana untuk distabilitas, tersedia sarana kantor, seragam pegawai. Secara fisik, penyelenggara menyediakan fasilitas dan perlengkapan sistim informasi terintegrasi. Pengguna jasa layanan atau customer, selain pelayanan kesehatan, sarana fisik lainnya dapat dirasakan seperti lahan parkir yang rapi dan luas, ketersediaan sarana

umum yang cukup diruang tunggu, toilet bersih dan wangi, kebersihan ruangan yang terjaga sehingga pemberi pelayanan bekerja secara optimal dengan SPO dalam memberikan pelayanan kesehatan.

2. Reliability merupakan suatu kehandalan yaitu berkemampuan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat. Pada dimensi ini dapat dijelaskan standar pelayanan diberikan berdasarkan standar minimal yang mengacu pada standar nasional mutu sehingga ketepatan waktu dan akurat sesuai yang tertera dalam brosur pelayanan. Pada dimensi realibility ini oleh pelanggan dianggap sebagai hal yang sangat penting. Budaya kerja sangat berpengaruh pada dimensi ini dikarenakan produk jasa layanannya sangat tergantung pada aktifitas manusia sehingga sangat sulit untuk mendapatkan output yang konsisten, sehingga pucuk pimpinan sangat perlu menerapkan budaya kerja di lingkungan kerjanya dengan program mengevaluasi mutu.
3. Responsiveness atau daya tanggap, merupakan kesediaan dan kemampuan pelaksana pelayanan untuk membantu pasien dan memberikan layanan secara cepat, tepat, dan tanggap tanpa membiarkan konsumen menunggu. Daya tanggap dan responsif terhadap kebutuhan *customer* sangat ditentukan oleh sikap petugas yang *awareness* pada baris depan pelayanan sebagai ujung tombak. Komponen daya tanggap sangat krusial dalam kualitas pelayanan, di mana kecepatan merespons keluhan atau kebutuhan pelanggan secara positif dapat mencegah kesan negatif dan meningkatkan kepuasan. Indikator pada dimensi ini meliputi kecepatan layanan, kesiapan membantu cepat, kejelasan dalam memberikan informasi dan responsif staf untuk melayani dengan segera tanpa membiarkan pelanggan menunggu terlalu lama.
4. Jaminan (Assurance), pada dimensi ini mencakup kompetensi, kesopanan, sifat dapat dipercaya, dan kemampuan staf untuk menanamkan keyakinan serta rasa aman kepada pelanggan yang merupakan untuk mengukur tingkat kepercayaan pelanggan terhadap penyedia jasa. Menurut Kotler, jaminan adalah pengetahuan terhadap produk secara tepat, kesopan-santunan karyawan, keterampilan dalam memberikan informasi, serta kemampuan dalam membangun kepercayaan pelanggan. Pentingnya assurance dalam pelayanan adalah untuk membangun kepercayaan dengan jaminan yang tinggi akan meningkatkan rasa aman, membuat pelanggan merasa nyaman, dan akhirnya meningkatkan loyalitas, mengurangi resiko dan memberikan dampak kepuasan yang memberi pengaruh positif secara signifikan antara jaminan yang diberikan dengan tingkat kepuasan pelanggan.
5. Empati (Emphaty), pada dimesi ini kemampuan untuk memahami, merasakan, dan berbagi perasaan orang lain secara mendalam, serta memberikan perhatian

tulus secara individual dan terkait dengan rasa kepedulian dan perhatian khusus pelaksana pelayanan kepada setiap pasien selaku pengguna jasa. Kemampuan staf sebagai pemberi pelayanan penting melibatkan mendengarkan aktif, mengenali emosi, menghormati perspektif orang lain, dan memberikan dukungan atau bantuan. Pada layanan empati sangat krusial untuk kepuasan pelanggan untuk memberikan kemudahan dihubungi setiap saat jika pengguna jasa membutuhkan bantuannya dan ini sangat menentukan mutu pelayanan kesehatan pada fasyankes.

Mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh persepsi-persepsi dengan *barrier quality* bentuk layanan kesehatan sesuai yang dijelaskan oleh banyak pakar diantaranya seperti Donabedian (1998), "mutu pelayanan kesehatan adalah *The quality of technical care consist in the application of medical science and technology in a way that maximizes its benefit to health without correspondingly increasing its risk. The degree of its quality is, therefore, the extent to which the care provided is expected the most favourable balance of risk and benefit*". Model Donabedian membagi kualitas ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Struktur merupakan fasilitas fisik bangunan rumah sakit, puskesmas dan klinik Kesehatan. Peralatan medik merupakan sarana prasarana penunjang pelayanan dan sumber daya manusia merupakan daya dukung pelaksana serta sistem manajemen merupakan mekanisme terlaksananya pelayanan.
2. Proses adalah interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien, termasuk ketepatan diagnosis dan efektivitas perawatan.
3. Hasil (Outcome) merupakan perubahan status kesehatan pasien dan tingkat kepuasan mereka.

Selain itu, evaluasi sering merujuk pada 6 dimensi mutu WHO yaitu: efektif untuk mencapai tujuan dan efisien dalam menghemat sumber daya, dapat terjangkau dengan mudah, berorientasi pada pasien, Equitable, dan Aman. Evaluasi mutu pada fasyankes sangat terkait dengan dimensi mutu dimana sumber daya, fasilitas dibutuhkan seperti pada dimensi konsumen/pasien mengharapkan pelayanan maksimal mencapai kepuasannya, dimensi profesi dituntut menjalankan pelayanan sesuai standar layanan dan profesi serta menjalankan proses pada dimensi manajemen, yaitu rangkaian tindakan sistematis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Proses layanan dilaksanakan sesuai fungsi-fungsi manajemen supaya sumber daya dapat lebih efisien dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pasien dengan maksimal.

C. Implementasi Indikator Nasional Mutu (INM)

Tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas suatu pelayanan dapat dijadikan indikator dari kualitas mutu pada suatu fasyankes. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dasar masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, maka mutu puskesmas harus terjamin. Provider perlu melakukan evaluasi pada puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pertama dengan melalui pelaksanaan survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dan fasilitas kesehatan yang disediakan untuk masyarakat.

Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan merupakan tolok ukur wajib yang ditetapkan kementerian kesehatan melalui PMK No. 30 Tahun 2022 untuk menilai, mengukur, dan peningkatan kualitas layanan pada fasyankes seperti puskesmas, klinik kesehatan, rumah sakit, laboratorium. INM berfokus pada keselamatan pasien, efektivitas, dan kepuasan pasien, mencakup kepatuhan dalam menjalankan peraturan standar indikator nasional diantaranya kepatuhan mencuci tangan dengan bersih, penggunaan alat pelindung diri yang tepat, dan menggunakan identifikasi pasien yang benar.

Pada peraturan menteri kesehatan nomor 11 tahun 2017 yang mengatur mengenai keselamatan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan, pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia harus menyelenggarakan dan melaporkan kejadian-kejadian mengenai keselamatan pasien secara berkala. Data insiden pasien tersebut digunakan sebagai gambaran untuk mengukur indikator nasional mutu. Sejak awal tahun 2022 puskesmas sudah diwajibkan untuk melaksanakan pengukuran indikator nasional mutu secara berkala. Fungsi indikator yang ditetapkan untuk mengukur kinerja, mengevaluasi kinerja untuk mencapai target, sebagai pertanggungjawaban, untuk penilaian akreditasi, untuk menilai prioritas layanan, dan untuk menentukan kualitas layanan.

Indikator nasional mutu puskesmas meliputi 6 indikator sesuai permenkes nomor 30 tahun 2022 diantaranya:

1. Melaksanakan kepatuhan kebersihan tangan.
2. Melaksanakan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)
3. Melaksanakan kepatuhan identifikasi pasien
4. Melaksanakan keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis semua kasus sensitif obat.
5. Mengutamakan ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan ante natal care sesuai standar; dan
6. Mengutamakan kepuasan pasien.

Menurut WHO, kebersihan tangan adalah tindakan penting untuk mencegah penyebaran mikroorganisme dengan melakukan cuci tangan memakai air mengalir kran air, menggunakan sabun cuci tangan atau handrub yang mengandung alkohol, dilakukan melalui 6 langkah yang terstruktur (telapak, punggung, sela jari, kunci jari, ibu jari, ujung jari) dan pada 5 langkah kritis yaitu sebelum memegang pasien, sebelum prosedur aseptik, setelah risiko terjadi paparan cairan tubuh, setelah memegang pasien, dan setelah masuk dalam area pasien), untuk menjaga kebersihan diri dan mencegah infeksi dengan 6 langkah dan 5 momen.

Alat pelindung diri berfungsi sebagai pertahanan terakhir, bukan pengganti eliminasi bahaya, yang meliputi pelindung kepala, mata, telinga, pernapasan, tangan, dan kaki, yang harus memenuhi standar keamanan digunakan untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Pemakaian alat pelindung diri merupakan upaya untuk menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja yang optimal bagi pasien dan pelaksana pemberi pelayanan dengan total standar INM 100%.

Selanjutnya INM pada kepatuhan identifikasi pasien yang diukur adalah tingkat kepatuhan staf medis/tenaga kesehatan dalam melakukan verifikasi identitas pada pasien dilakukan minimal dua identitas, seperti nama dan tanggal lahir pasien sebelum dilakukan tindakan. Identifikasi pasien untuk mencegah kesalahan tindakan saat pemberian obat, jenis darah, produk darah, pengambilan sampel, dan tindakan intervensi lainnya dan menargetkan pencapaiannya 100%.

Pada tindakan operasi, untuk mengukur parameter efisiensi pelayanan operasi yang utama yaitu ketepatan waktu penjadwalan operasi. Secara aturan INM penundaan operasi elektif di rumah sakit ditetapkan kurang dari 5% per bulan. Faktor penyebab penundaan operasi umumnya:

1. Faktor kondisi pasien yaitu kondisi medis pasien yang tiba-tiba tidak fit atau belum siap.
2. Faktor prosedur/fasilitas yaitu kurangnya waktu operasi, tidak tersedianya ICU/PICU, atau perlengkapan sarana prasarana yang belum lengkap.
3. Faktor manajemen/petugas yaitu keterlambatan dokter bedah atau anestesi, serta masalah administrasi.

Kepatuhan terhadap clinical pathway menjadi indikator sangat penting pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Para pelaksana dan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan lainnya harus mengikuti standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dalam clinical pathway dengan tujuan untuk memastikan mutu layanan, efisiensi, dan hasil pasien yang optimal, dengan mengukur kesesuaian tindakan, lama rawat inap, obat, dan pemeriksaan dengan pedoman terstandar.

Pada pelaporan hasil kritis laboratorium merupakan prosedur darurat untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengancam jiwa (nilai kritis) secara cepat, maksimal <30 menit, kepada DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) atau perawat ruangan untuk penanganan pasien segera. Perlunya pelaporan nilai kritis sebagai fase penting untuk proses menegakkan diagnosa dan terapi pada pasien. Pada setiap unit ruangan di rumah sakit diberikan tanggungjawab untuk membuat laporan dan menindaklanjuti laporan nilai kritis tersebut diterima oleh dokter DPJP (Febrianto et al., 2021). Capaian mutu untuk laporan hasil kritis laboratorium standar INM 100%.

D. Evaluasi Dimensi Mutu di Fasilitas Kesehatan

Evaluasi dimensi mutu pada fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) adalah penilaian sistematis terhadap tingkat kesempurnaan layanan untuk memenuhi kebutuhan pasien, yang umumnya mencakup beberapa dimensi mutu seperti: efektif, efisien, adil, tepat waktu, yang berorientasi pada pasien, aman, dan terintegrasi. Evaluasi ini penting dilaksanakan untuk meningkatkan kepuasan dan keselamatan pasien.

Faktor pelayanan kesehatan di masyarakat dipengaruhi oleh aksesibilitas jarak dan waktu tempuh, kualitas SDM dan sarana fisik yang tersedia, biaya, serta kepercayaan masyarakat. Kualitas pelayanan, termasuk daya tanggap staf dan efektivitas perawatan, berpusat pada pasien, adil, dan aman, menjadi penentu utama pemanfaatan layanan. Pemanfaatan juga dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi seperti pendapatan dan edukasi. Evaluasi dimensi kualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan merupakan proses yang terukur untuk menilai sejauh mana layanan kesehatan sudah memenuhi standar yang diharapkan, baik dari perspektif klinis maupun perspektif kepuasan pelanggan.

Kepuasan pasien salah satu indikator untuk mengukur dan menilai mutu pelayanan di fasilitas kesehatan sampai pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan untuk menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien. Semakin mendapatkan kepuasan mutlak yang dirasakan, semakin tinggi dimensi mutu pelayanannya.

Evaluasi mutu pelayanan yang standar tidak hanya mengukur kepuasan pelanggan, tetapi juga membandingkan kinerja aktual dengan standar operasional prosedur (SOP) dan indikator kinerja minimal, akan tetapi ketersediaan fasilitas, kelengkapan teknologi dan penampilan fisik serta sikap dan perilaku pemberi pelayanan harus mencerminkan profesionalisme dan mempunyai komitmen tinggi. Pelayanan yang baik akan memberikan hal yang baik untuk fasilitas kesehatan (Aras & Azwar, 2017). Pemberi pelayanan sebagai wujud tanggung jawab sosial

kepada masyarakat atas fasilitas kesehatan yang lengkap, sehingga pelayanan yang baik menjadikan benefit untuk fasyankes seperti :

1. Pasien akan setia dan pasien bisa menjadi pelanggan tetap.
2. Pasien dapat dijadikan sebagai media promosi langsung dengan kepuasan yang didapatkan dari pelayanan faskes kepada teman atau tetangganya sehingga faskes menjadi lebih dikenal.
3. Puasnya konsumen disebabkan terpenuhi kebutuhannya, baik dari segi kualitas sarana dan profesionalisme pelayanan. Keunggulan pelayanan yang maksimal pasien akan merasa bahwa semua kebutuhannya telah dipenuhi oleh faskes.
4. Unggulnya brand faskes dikarenakan banyaknya customer yang merasa puas dan menjadi customer abadi sehingga nama baik faskes akan semakin unggul di mata semua jenis customer.
5. Prima dari segi bisnis dan kompetitif secara normal.

Pada perspektif dimensi mutu WHO, merumuskan enam dimensi utama dalam mengevaluasi mutu pelayanan kesehatan, yang sering disingkat sebagai kerangka kerja STEEEP yang berfokus pada penyediaan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, mudah dijangkau, pasien sebagai pusat (*patient-centred*), adil (*equitable*), dan aman (*safe*) dengan tujuan meningkatkan kesehatan individu dan populasi dengan memaksimalkan sumber daya dan meminimalisir risiko. Dimensi mutu berdasarkan WHO dapat dijabarkan seperti berikut ini:

1. Efektif yaitu pelayanan diberikan berdasarkan data ilmiah (*evidence-based*) kepada individu dan masyarakat yang membutuhkannya.
2. Efisien yaitu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menghindari pemborosan (penggunaan BHP).
3. Mudah diakses yaitu layanan tersedia tepat waktu dan sesuai keterampilan, melampaui sekadar ketersediaan fisik.
4. Berpusat pada pasien yaitu Pelayanan yang memperhatikan pilihan, kebutuhan, dan nilai-nilai pasien.
5. Adil yaitu memberikan pelayanan yang tidak membedakan status sosial, ekonomi, etnis, geografis, atau jenis kelamin.
6. Aman yaitu meminimalisir risiko dan bahaya yang mungkin timbul akibat pelayanan kesehatan.

Evaluasi mutu di fasilitas pelayanan kesehatan berfokus pada standarisasi melalui Indikator Nasional Mutu (INM) dan siklus perbaikan secara berkelanjutan dengan menggunakan metode dan instrumen yang terstruktur untuk menjamin keselamatan pasien dan efektivitas pelayanan.

Mengacu pada peraturan pemerintah yaitu kementrian kesehatan (PMK) No. 30 Tahun 2022 mengenai penjabaran metode dan instrumen untuk mengukur dimensi mutu fasyankes adalah:

1. Metode Pengukuran Mutu Fasyankes.

Pengukuran menggunakan indikator yang ditetapkan pemerintah untuk menilai standar pelayanan di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan Praktik Mandiri, seperti kepuasan pasien, kebersihan tangan, dan penggunaan APD (INM). Dengan survei akreditasi metode penilaian eksternal yang dilakukan secara berkala oleh lembaga independen untuk memastikan Fasyankes memenuhi standar tata kelola dan pelayanan, seterusnya dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi sebagai pemantauan berkala terhadap capaian indikator klinis dan manajemen, pelaporan insiden keselamatan pasien dan diakhiri dengan audit klinis sebagai evaluasi sistematis terhadap pelayanan medis dibandingkan dengan standar yang ada.

2. Instrumen Pengukuran Mutu Fasyankes.

Instrumen sebagai alat bantu (kuisioner, cheklis dan aplikasi) digunakan untuk menjalankan metode pengukuran mutu sesuai kebutuhan.

a. Dimensi Mutu yang Diukur.

- 1) Aman yaitu meminimalkan risiko dan cedera pada pasien.
- 2) Efektif yaitu memberikan layanan berdasarkan bukti ilmiah kepada yang membutuhkan.
- 3) Efisien yaitu menghindari pemborosan sumber daya seperti bahan habis pakai, obat obatan, dll
- 4) Tepat waktu yaitu mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan layanan
- 5) Adil yaitu memberikan layanan yang seragam tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, atau suku.
- 6) Berorientasi pasien yaitu melayani sesuai kebutuhan dan nilai-nilai pasien.
- 7) Terintegrasi yaitu ada koordinasi layanan yang bekesinambungan antar penyedia jasa layanan

b. Indikator Spesifik berfokus pada masing-masing tingkatan faskes. Puskesmas berfokus pada upaya promotif, preventif, dan kuratif dasar dengan indikator utama dan Rumah Sakit memiliki indikator yang lebih kompleks, berfokus pada tingkat rujukan dan keselamatan pasien (termasuk Indikator Nasional Mutu/INM).

E. Simpulan

Layanan kesehatan merupakan salah satu pilar utama ketahanan global terutama dalam menghadapi krisis ekonomi dan bencana alam. Evaluasi mutu pelayanan fasilitas kesehatan dilakukan dengan menggunakan indikator nasional mutu dan kredensialing untuk memastikan standar keselamatan dan kualitas pelayanan terpenuhi. Evaluasi mutu fasyankes yang bermitra dengan penjamin kesehatan berfokus pada peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada pasien (patient-centered care), keselamatan pasien (patient safety), dan kehandalan sistem pelayanan. Ini mencakup waktu tunggu, kompetensi staf, dan ketersediaan sarana. Rekomendasi penulis pada evaluasi mutu fasyankes sebagai berikut: 1) Ketersediaan fasilitas fisik, peralatan, kompetensi dan penampilan staf; 2) Memberikan pelayanan yang tepat dan akurat; 3) Penilaian berkala sarana terhadap sarana prasarana, dan sumber daya untuk kelayakan; 4) Mengukur kepuasan pelanggan secara langsung dan; 5) Audit klinis.

F. Referensi

- Ahmad Fachrurrozi, Dimas Ageng Prayogo, D. M. (2023). Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran (JURRIKE), Volume 2*.
- Febrianto, W., Rahmawati, M., Sastrawan, I. G., & Hariyanti, T. (2021). The importance of hospital reaccreditation: improving the timeliness of laboratory critical value reporting. *Health Science Journal of Indonesia*, 12(2). <https://doi.org/10.22435/hsji.v12i2.331> 5
<https://unair.ac.id/kepuasan-pasien-sebagai-indikator-mutu-dalam-pelayanan-kesehatan>
- Herlambang, Susatyo, 2014, Customer Service Rumah Sakit Dan Kesehatan, Gosyen Publishing, Yogyakarta
- Ruly P, Nurul H. (2020). Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan. Penerbit Adab.

G. Glosarium

INM = Indikator Nasional Mutu

CHAPTER 8

TANTANGAN DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Ita Pursitasari, M.Kep.Sp.Kep.An

A. Pendahuluan

Mutu pelayanan kesehatan merupakan konsep fundamental yang harus dipahami oleh setiap tenaga kesehatan, karena kualitas pelayanan yang diberikan secara langsung memengaruhi keselamatan pasien, efektivitas intervensi, serta kepuasan pengguna layanan. Dalam konteks pendidikan kesehatan, pemahaman mengenai mutu pelayanan kesehatan menjadi dasar penting untuk membentuk kompetensi profesional yang mampu memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Menurut WHO (2018), pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang meningkatkan kemungkinan tercapainya hasil kesehatan yang diharapkan, sesuai dengan pengetahuan ilmiah terkini, serta diselenggarakan secara aman, efektif, efisien, tepat waktu, berkeadilan, dan berpusat pada pasien.

Meskipun konsep mutu pelayanan kesehatan telah menjadi perhatian global, berbagai literatur internasional menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasinya masih sangat kompleks. Institute of Medicine (2001), mengemukakan bahwa sistem pelayanan kesehatan di banyak negara masih menghadapi kesenjangan antara standar ideal dan praktik nyata, yang ditandai dengan variasi mutu pelayanan, ketidakkonsistenan penerapan pedoman berbasis bukti, serta tingginya risiko kejadian tidak diinginkan pada pasien. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, tetapi juga mencerminkan permasalahan sistemik dalam tata kelola, budaya organisasi, dan manajemen pelayanan kesehatan.

Keselamatan pasien merupakan salah satu isu utama yang mencerminkan rendahnya mutu pelayanan kesehatan. WHO (2019), melaporkan bahwa insiden keselamatan pasien, seperti kesalahan medis dan infeksi terkait pelayanan kesehatan, masih menjadi penyebab signifikan morbiditas dan mortalitas yang sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan sistem mutu yang efektif. Dalam konteks pembelajaran, pemahaman mengenai hubungan antara mutu pelayanan dan keselamatan pasien menjadi penting agar peserta didik mampu melihat

pelayanan kesehatan sebagai suatu sistem yang saling terintegrasi, bukan sekadar kumpulan tindakan klinis individual.

Selain itu, kompleksitas sistem pelayanan kesehatan modern menuntut tenaga kesehatan memiliki kemampuan berpikir sistemik (*systems thinking*). Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai profesi, teknologi, dan tingkat layanan yang harus bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan luaran yang optimal. WHO (2018), menekankan bahwa fragmentasi pelayanan dan lemahnya koordinasi antar unit layanan merupakan hambatan utama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, modul atau buku ajar mengenai mutu pelayanan kesehatan perlu membekali peserta didik dengan pemahaman konseptual yang kuat tentang sistem pelayanan kesehatan dan dinamika peningkatan mutunya.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi fokus penting dalam pendidikan tenaga kesehatan. Strategi yang direkomendasikan secara internasional meliputi penerapan praktik berbasis bukti, penguatan tata kelola dan kepemimpinan, pengembangan kompetensi tenaga kesehatan, penggunaan indikator mutu, serta keterlibatan pasien dan masyarakat dalam perbaikan layanan (WHO, 2018). Institute of Medicine menegaskan bahwa peningkatan mutu harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem pelayanan, bukan sebagai kegiatan terpisah atau reaktif.

Oleh karena itu, modul atau buku ajar ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, tantangan, dan strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan literatur internasional. Materi ini diharapkan dapat menjadi landasan teoritis dan praktis bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam mengembangkan sikap profesional, keterampilan analitis, serta komitmen terhadap perbaikan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Dengan pemahaman yang kuat tentang mutu pelayanan kesehatan, peserta didik diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan sistem kesehatan yang aman, efektif, dan berorientasi pada pasien.

B. Tantangan dan Hambatan dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan rencana strategis global yang memiliki peran penting dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Mutu pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan hasil klinis, tetapi juga mencakup aspek keselamatan pasien, pengalaman pengguna layanan, efektivitas intervensi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keadilan dalam akses dan pemberian pelayanan. Menurut WHO (2018), sistem kesehatan yang

bermutu rendah berkontribusi terhadap tingginya angka kematian yang dapat dicegah, pemborosan sumber daya, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Meskipun berbagai negara telah mengadopsi kebijakan mutu dan keselamatan pasien, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks dan saling terkait.

Salah satu tantangan utama dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan adalah lemahnya tata kelola sistem kesehatan (*health system governance*). Tata kelola yang tidak efektif sering ditandai dengan kurangnya kepemimpinan yang kuat, kebijakan mutu yang tidak terintegrasi, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas dan pengawasan. WHO (2018), menegaskan bahwa tanpa tata kelola yang baik, inisiatif peningkatan mutu cenderung bersifat fragmentaris, tidak berkelanjutan, dan bergantung pada individu atau proyek tertentu. Kondisi ini menyebabkan standar pelayanan tidak diterapkan secara konsisten di seluruh fasilitas dan tingkat pelayanan kesehatan.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kesenjangan antara bukti ilmiah dan praktik pelayanan kesehatan. Institute of Medicine (IOM) menyatakan bahwa banyak intervensi yang telah terbukti efektif secara ilmiah tidak diimplementasikan secara optimal dalam praktik klinis sehari-hari, sementara praktik yang tidak berbasis bukti masih sering digunakan. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pedoman klinis terkini, rendahnya literasi berbasis bukti di kalangan tenaga kesehatan, serta minimnya sistem pendukung keputusan klinis. Akibatnya, mutu pelayanan menjadi bervariasi dan berpotensi menurunkan keselamatan pasien.

Sumber daya manusia kesehatan merupakan faktor kunci dalam peningkatan mutu pelayanan, namun juga menjadi salah satu hambatan terbesar. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, kekurangan jumlah tenaga terlatih, serta tingginya beban kerja berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diberikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kruk et al. (2018) menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang bekerja dalam kondisi tekanan tinggi dan sumber daya terbatas cenderung mengalami kelelahan kerja (*burnout*), yang berkontribusi terhadap meningkatnya kesalahan medis dan menurunnya mutu pelayanan. Selain itu, kurangnya pelatihan berkelanjutan dan kesempatan pengembangan profesional menghambat peningkatan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan bermutu tinggi.

Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana juga menjadi tantangan signifikan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. WHO (2020), melaporkan bahwa banyak fasilitas kesehatan, terutama di negara berpendapatan rendah dan menengah, masih menghadapi kekurangan alat medis esensial, obat-

obatan, air bersih, listrik, dan sistem sanitasi yang memadai. Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas pelayanan, tetapi juga meningkatkan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan dan kejadian tidak diinginkan lainnya. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, standar mutu dan keselamatan pasien sulit untuk diterapkan secara konsisten.

Aspek keselamatan pasien merupakan tantangan besar yang mencerminkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan. WHO (2019), memperkirakan bahwa jutaan pasien di seluruh dunia mengalami kejadian tidak diinginkan setiap tahunnya, dan sebagian besar kejadian tersebut sebenarnya dapat dicegah. Kesalahan pengobatan, infeksi nosokomial, serta kegagalan komunikasi antar tenaga kesehatan merupakan contoh masalah keselamatan pasien yang masih sering terjadi. Hambatan utama dalam peningkatan keselamatan pasien adalah lemahnya sistem pelaporan insiden dan budaya organisasi yang belum mendukung pembelajaran dari kesalahan.

Budaya organisasi yang tidak kondusif terhadap mutu dan keselamatan pasien menjadi tantangan yang bersifat non-teknis namun sangat berpengaruh. WHO (2019), menekankan bahwa budaya menyalahkan (*blame culture*) masih banyak ditemukan dalam sistem pelayanan kesehatan, sehingga tenaga kesehatan enggan melaporkan kesalahan atau kejadian tidak diinginkan karena takut akan sanksi atau stigma. Akibatnya, organisasi kehilangan kesempatan untuk melakukan analisis akar masalah dan perbaikan sistem. Perubahan budaya organisasi menuju budaya keselamatan dan perbaikan berkelanjutan membutuhkan komitmen jangka panjang dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi.

Fragmentasi pelayanan kesehatan dan lemahnya koordinasi antar tingkat layanan juga menjadi hambatan dalam peningkatan mutu. Sistem pelayanan yang terfragmentasi menyebabkan kurangnya kesinambungan perawatan, duplikasi layanan, serta kesalahan dalam transisi pelayanan, misalnya saat rujukan atau pemulangan pasien (WHO, 2018). Kondisi ini semakin kompleks dengan meningkatnya prevalensi penyakit kronis yang memerlukan pelayanan jangka panjang dan terkoordinasi antara berbagai fasilitas dan profesi kesehatan. Tanpa sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan komunikasi yang efektif, mutu pelayanan sulit untuk ditingkatkan secara menyeluruh.

Selain faktor internal sistem kesehatan, faktor eksternal seperti ketimpangan sosial dan ekonomi juga mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan. Kruk et al. (2018) menegaskan bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan sering kali menerima pelayanan dengan mutu rendah, meskipun memiliki kebutuhan kesehatan yang lebih besar. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa peningkatan

mutu pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari upaya mencapai keadilan dan pemerataan dalam sistem kesehatan.

Secara keseluruhan, tantangan dan hambatan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan bersifat multidimensional dan saling terkait, mencakup aspek tata kelola, sumber daya manusia, infrastruktur, budaya organisasi, keselamatan pasien, koordinasi layanan, serta faktor sosial ekonomi. WHO (2018) menegaskan bahwa peningkatan mutu tidak dapat dicapai melalui intervensi tunggal atau jangka pendek, melainkan memerlukan pendekatan sistemik, berkelanjutan, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai tantangan dan hambatan ini menjadi landasan penting bagi perumusan strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang realistis dan efektif dalam konteks pendidikan, kebijakan, maupun praktik pelayanan kesehatan.

C. Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada individu dan masyarakat memenuhi standar profesional, aman bagi pasien, efektif secara klinis, efisien dalam penggunaan sumber daya, berorientasi pada pasien, serta berkeadilan. Dalam konteks global, mutu pelayanan kesehatan dipandang sebagai elemen kunci dalam pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). WHO (2018), menegaskan bahwa peningkatan akses layanan tanpa disertai mutu yang memadai tidak akan menghasilkan perbaikan luaran kesehatan yang signifikan, bahkan dapat meningkatkan risiko keselamatan pasien dan pemborosan sumber daya.

Laporan *High-Quality Health Systems* menekankan bahwa mutu pelayanan kesehatan yang rendah merupakan penyebab utama kematian yang dapat dicegah di banyak negara, termasuk negara berpendapatan rendah dan menengah (Kruk *et al.* 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan mutu harus menjadi prioritas utama dalam reformasi sistem kesehatan. Strategi tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial atau jangka pendek, melainkan harus dirancang secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis bukti ilmiah.

1. Penguatan Tata Kelola dan Kepemimpinan Mutu

Salah satu strategi fundamental dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan adalah penguatan tata kelola (*governance*) dan kepemimpinan. Tata kelola yang kuat memungkinkan sistem kesehatan menetapkan visi, kebijakan, dan akuntabilitas yang jelas dalam pengelolaan mutu pelayanan. WHO menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif di semua tingkat sistem

kesehatan nasional, regional, hingga fasilitas pelayanan merupakan prasyarat utama keberhasilan program peningkatan mutu (WHO, 2018). Penguatan tata kelola mencakup penyusunan kebijakan mutu yang terintegrasi, penetapan standar pelayanan yang jelas, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Menurut Shaw *et al.* (2020), tanpa kerangka tata kelola yang kuat, inisiatif peningkatan mutu cenderung berjalan secara terfragmentasi dan bergantung pada individu atau proyek tertentu, sehingga sulit dipertahankan dalam jangka panjang.

2. Penerapan Praktik Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice)

Penerapan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*) merupakan strategi inti dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Praktik berbasis bukti mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, dan nilai serta preferensi pasien dalam pengambilan keputusan pelayanan kesehatan. Institute of Medicine menegaskan bahwa sistem kesehatan yang bermutu harus mampu memberikan pelayanan yang efektif dan aman berdasarkan bukti ilmiah terkini. Namun, berbagai studi menunjukkan masih adanya kesenjangan antara bukti dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, strategi peningkatan mutu perlu mencakup pengembangan dan implementasi pedoman klinis, audit dan umpan balik (*audit and feedback*), serta sistem pendukung keputusan klinis. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan dan menurunkan variasi praktik yang tidak perlu (Melnik & Fineout-Overholt, 2019).

3. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan merupakan aktor utama dalam peningkatan mutu pelayanan. Tanpa tenaga kesehatan yang kompeten, termotivasi, dan didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif, strategi peningkatan mutu sulit mencapai hasil yang optimal. WHO menekankan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan berkelanjutan, dan pengembangan profesional merupakan strategi kunci untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan (WHO, 2020). Kruk *et al.* (2018) menunjukkan bahwa kelelahan kerja (*burnout*) dan beban kerja berlebih pada tenaga kesehatan berkontribusi terhadap menurunnya kualitas dan keselamatan pelayanan. Oleh karena itu, strategi peningkatan mutu juga harus mencakup manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada kesejahteraan tenaga kesehatan, distribusi tenaga yang adil, serta penguatan kompetensi klinis dan nonklinis, seperti komunikasi dan kerja tim.

4. Peningkatan Keselamatan Pasien sebagai Pilar Mutu

Keselamatan pasien merupakan dimensi esensial dari mutu pelayanan kesehatan. WHO memperkirakan bahwa jutaan pasien di seluruh dunia mengalami kejadian tidak diinginkan setiap tahunnya, dan sebagian besar kejadian tersebut dapat dicegah melalui sistem keselamatan yang efektif (WHO, 2019). Oleh karena itu, strategi peningkatan mutu harus menjadikan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Strategi keselamatan pasien meliputi penguatan sistem pelaporan insiden, penerapan standar keselamatan, penggunaan daftar tilik (*checklist*), serta pengembangan budaya keselamatan (*patient safety culture*). WHO menekankan bahwa budaya organisasi yang mendukung pelaporan tanpa menyalahkan (*no blame culture*) sangat penting untuk mendorong pembelajaran dari kesalahan dan perbaikan sistem secara berkelanjutan (WHO, 2019).

5. Pemanfaatan Data, Indikator Mutu, dan Teknologi Informasi

Pemanfaatan data dan indikator mutu merupakan strategi penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan pemantauan kinerja pelayanan kesehatan. WHO (2018), menyatakan bahwa sistem informasi kesehatan yang kuat memungkinkan identifikasi masalah mutu, evaluasi intervensi, serta perbaikan layanan secara berkelanjutan. Penggunaan indikator mutu yang relevan, seperti indikator struktur, proses, dan luaran, membantu fasilitas pelayanan kesehatan menilai kinerja dan membandingkannya dengan standar atau target tertentu. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi kesehatan, seperti rekam medis elektronik dan sistem pelaporan digital, dapat meningkatkan akurasi data, koordinasi pelayanan, dan keselamatan pasien (Bates *et al.* 2018).

6. Pendekatan Perbaikan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement)

Strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga mencakup penerapan pendekatan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement/CQI*). Pendekatan ini menekankan siklus perbaikan yang terus-menerus, seperti model *Plan-Do-Study-Act* (PDSA), untuk mengidentifikasi masalah, menguji solusi, dan mengevaluasi dampaknya secara sistematis (Taylor *et al.* 2014). Pendekatan CQI memungkinkan organisasi kesehatan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasien dan lingkungan pelayanan, serta mendorong keterlibatan seluruh staf dalam upaya peningkatan mutu. Penelitian Batalden dan Davidoff (2007), menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan CQI secara konsisten cenderung memiliki kinerja mutu dan keselamatan pasien yang lebih baik.

7. Keterlibatan Pasien dan Masyarakat

Keterlibatan pasien dan masyarakat merupakan strategi penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien. WHO menekankan bahwa pasien bukan hanya penerima layanan, tetapi juga mitra dalam perbaikan mutu (WHO, 2018). Keterlibatan pasien dapat dilakukan melalui mekanisme umpan balik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta edukasi kesehatan. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepuasan pasien, kepatuhan terhadap pengobatan, dan kepercayaan terhadap sistem kesehatan. Selain itu, keterlibatan masyarakat membantu memastikan bahwa strategi peningkatan mutu selaras dengan kebutuhan dan konteks lokal (Carman *et al.* 2013).

8. Integrasi Strategi Mutu dalam Sistem Kesehatan

Secara keseluruhan, strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus diintegrasikan dalam sistem kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan. WHO menegaskan bahwa mutu pelayanan tidak dapat ditingkatkan melalui intervensi tunggal, melainkan memerlukan kombinasi strategi yang saling melengkapi dan didukung oleh komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan (WHO, 2018). Integrasi ini mencakup kebijakan, pembiayaan, pendidikan, dan praktik pelayanan kesehatan sehari-hari.

Dengan demikian, strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan proses multidimensional yang menuntut pendekatan sistemik, berbasis bukti, dan berorientasi pada pasien. Pemahaman yang mendalam mengenai strategi ini menjadi landasan penting bagi pengembangan tenaga kesehatan yang profesional serta pembangunan sistem kesehatan yang aman, efektif, dan berkeadilan.

D. Kesimpulan

Mutu pelayanan kesehatan merupakan elemen esensial dalam penyelenggaraan sistem kesehatan yang aman, efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Mutu tidak hanya mencerminkan keberhasilan intervensi klinis, tetapi juga mencakup keselamatan pasien, pengalaman pengguna layanan, keadilan akses, serta keberlanjutan sistem kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus dipahami sebagai tanggung jawab sistemik yang melibatkan seluruh komponen sistem kesehatan.

Kajian dalam buku ajar ini menunjukkan bahwa tantangan dan hambatan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan bersifat kompleks dan multidimensional. Permasalahan tersebut meliputi lemahnya tata kelola dan kepemimpinan, kesenjangan antara bukti ilmiah dan praktik pelayanan,

keterbatasan serta ketimpangan sumber daya manusia kesehatan, kekurangan infrastruktur dan sarana prasarana, rendahnya keselamatan pasien, budaya organisasi yang belum mendukung pembelajaran, fragmentasi pelayanan, serta pengaruh ketimpangan sosial dan ekonomi. Kompleksitas ini menegaskan bahwa peningkatan mutu tidak dapat dicapai melalui intervensi tunggal atau pendekatan jangka pendek.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu dilaksanakan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Strategi utama yang dibahas meliputi penguatan tata kelola dan kepemimpinan mutu, penerapan praktik berbasis bukti, pengembangan kompetensi dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan keselamatan pasien sebagai pilar mutu, pemanfaatan data dan indikator mutu, penggunaan teknologi informasi kesehatan, penerapan perbaikan mutu berkelanjutan, serta keterlibatan aktif pasien dan masyarakat. Keseluruhan strategi ini harus saling mendukung dan diintegrasikan dalam sistem kesehatan secara menyeluruh.

Dengan demikian, peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan proses dinamis yang menuntut komitmen jangka panjang dari pembuat kebijakan, pimpinan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta masyarakat. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan dan strategi peningkatan mutu, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dan praktis bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam mengembangkan kompetensi profesional, kemampuan berpikir sistemik, serta komitmen terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada pasien.

E. Referensi

- Batalden PB, Davidoff F. 2007. What is "quality improvement" and how can it transform healthcare? *Quality and Safety in Health Care*. 16(1): 2–3.
- Bates DW, Singh H, Sittig DF. 2018. Operationalizing patient safety and quality improvement in healthcare information technology. *Journal of the American Medical Informatics Association*. 25(4):404–407.
- Carman KL, Dardess P, Maurer M, Sofaer S, Adams K, Bechtel C, Sweeney J. 2013. Patient and family engagement: A framework for understanding the elements and developing interventions and policies. *Health Affairs*. 32(2):223–231.
- Institute of Medicine. (2001). *Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century*. National Academy Press.

- Kruk ME, Gage AD, Arsenault C, Jordan K, Leslie HH, Roder-DeWanS, ... Pate, M. 2018. High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: Time for a revolution. *The Lancet Global Health*, 6(11):1196-1252.
- Melnyk BM, Fineout-Overholt E. 2019. Evidence-based practice in nursing and healthcare: A guide to best practice (4th ed.). Wolters Kluwer
- Shaw CD, Kutryba B, Braithwaite J, Bedlicki M, Warunek A. 2020. Sustainable healthcare quality improvement: Towards a framework. *BMJ Open Quality*, 9(2):e000847.
- World Health Organization. 2018. Delivering quality health services: A global imperative for universal health coverage. World Health Organization
- World Health Organization. 2019. Patient safety: Global action on patient safety. World Health Organization.
- World Health Organization. 2020. State of the world's nursing 2020: Investing in education, jobs and leadership. World Health Organization.

F. Glosarium

PDSA	= Plan Do Study Act
SDGs	= Sustainable Development Goals
UHC	= Universal Health Coverage
WHO	= World Health Organization

PROFIL PENULIS



Ns. Sri Melfa Damanik, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.An., merupakan dosen keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Pada tahun 2012, penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran, Bandung dan berhasil menyelesaikan profesi Ners pada tahun 2013. Penulis juga telah menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan (S2) di Universitas Indonesia pada tahun 2017 dan pendidikan Ners spesialis keperawatan anak tahun 2020. Selain sebagai dosen penulis juga aktif dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. Email : melfadamanik20@gmail.com



Isabel De Fatima Gudino, S.ST., M.K.M., lahir di Alas, pada 6 Agustus 1992. Lulusan Program Studi DIV Bidan Pendidik dari Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO) tahun 2016 dan tercatat sebagai lulusan Universitas Nusa Cendana Kupang (UNDANA) dengan gelar Magister Kesehatan Masyarakat di bidang KIA/ Kespro pada tahun 2020. Saat ini menjadi dosen program Studi Diploma III di Akademi Kebidanan Santa Elisabeth Kefamenanu. Mengampu mata kuliah Konsep Kebidanan, Dokumentasi Kebidanan, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan & Menyusui, Kespro/ KB, Praktik Klinik Kebidanan I & II. Aktif menulis beberapa artikel penelitian dan pengabdian masyarakat yang bisa diakses di google scholar <https://scholar.google.com/citations?user=few6vJEAAAAJ&hl=id>. Serta aktif mengikuti kegiatan mahasiswa di luar kampus sebagai pembimbing dalam praktik klinik kebidanan, pendamping PBL (Praktek Belajar Lapangan), serta jika ingin mengenal lebih dekat dengan penulis bisa mengirimkan pesan di email: isabelgudino06@gmail.com

PROFIL PENULIS



Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc., Penulis dilahirkan di Cianjur, Jawa Barat, pada tanggal 14 September 1962, Pendidikan diawali di AKPER Dep Kes Jakarta, lalu melanjutkan ke S1 Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan FKUI, Pendidikan S2 : Master of Health Care Practice, Liverpool John Moores University, Inggris, Mulai mengawali karir sebagai dosen di Akademi Keperawatan Dep Kes RI Jakarta, Jl. Kimia 17, Jakarta Pusat, pada Januari 1985. Selanjutnya menjadi bagian dari jajaran manajemen Poltekkes Kemenkes Jakarta III dimulai sebagai Ka Prodi DIII Keperawatan, KAJUR Keperawatan, Pembantu Direktur I bidang akademik dan terakhir, menjabat sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III pada April tahun 2018 - April 2024 dan fungsional dosen di bidang keperawatan Anak. Saat ini tugas pokok sebagai dosen dengan homebased di Prodi Keperawatan Bogor, Poltekkes Kemenkes Bandung. Penulis juga aktif melakukan Penelitian maupun Pengabdian Masyarakat khususnya di bidang Keperawatan Anak serta aktif berkontribusi dalam pengembangan keilmuan keperawatan anak baik melalui Organisasi Profesi Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI), Paediatric Nursing Society (PNS), Asia Pacific Paediatric Nursing Association (APPNA) dan International Children Paediatric Care Nursing Network (ICPCN). Penulis sudah banyak menghasilkan buku, sejak tahun 2003, baik buku keperawatan Anak, Keperawatan Dasar, Konsep dan Proses Keperawatan dan publikasi dalam bentuk jurnal Nasional maupun Internasional, terindex dan bereputasi. Fokus kajian di bidang Keperawatan Anak adalah: Kekerasan dan Penelantaran Pada Anak. Penulis juga pernah bekerjasama dengan UNICEF, Kemenkes RI dan tim pengembangan Buku Pedoman Penanggulangan Kekerasan & Penelantaran pada Anak, juga menjadi bagian dari tim pengembangan beberapa buku panduan pelayanan Keperawatan Produksi Kemenkes RI. Motto Hidup Penulis: "Sharing sebanyak banyak nya kepada orang lain, Insya Allah berkah" Email penulis: yupi_riyanto@yahoo.com



Bdn. Ika Putri Ramadhani, M.Biomed., Lahir di Padang, 05 Juli 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Biologi, Universitas Andalas Padang tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas Padang Program Studi Biomedis dan lulus tahun 2008. Saat ini penulis bekerja di Universitas Alifiah Padang mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Naturopati, Pelayanan KB dan Ilmu Gizi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan Pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ikaputri005@gmail.com. Motto: "Your only limit is your mind".

PROFIL PENULIS



Maulia Isnaini, S.ST., Bdn., M.Keb., lahir di Cipadang pada 26 September 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh meliputi Diploma IV Bidan Pendidik di STIKes Aisyah Pringsewu dan diselesaikan pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada Program Magister Kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dan memperoleh gelar Magister Kebidanan (M.Keb.) pada tahun 2021. Selanjutnya, penulis menyelesaikan Pendidikan Profesi Bidan di Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu pada tahun 2024. Karier akademik penulis dimulai pada tahun 2014 sebagai staf Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di STIKes Aisyah Pringsewu. Seiring perubahan bentuk institusi menjadi Universitas Aisyah Pringsewu pada tahun 2019, penulis terus berkontribusi dalam penguatan sistem penjaminan mutu. Pada periode 2021–2024, penulis dipercaya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dengan tanggung jawab dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik di tingkat universitas. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Universitas Aisyah Pringsewu. Penulis mengampu mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Konsep Kebidanan, Kebidanan Berbasis Bukti, Kesehatan Reproduksi dan Persiapan Kehamilan Sehat, Kebutuhan Dasar Manusia dan Biostatistik. Bidang kepakaran penulis meliputi mutu layanan kebidanan, pelayanan kesehatan primer, kesehatan ibu dan anak, manajemen dan penjaminan mutu pendidikan tinggi, serta pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis aktif sebagai penulis buku ajar, penulis artikel ilmiah pada jurnal nasional, serta pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas. Selain itu, penulis terlibat dalam berbagai penelitian kolaboratif yang berfokus pada penguatan pelayanan primer dan peningkatan mutu layanan kebidanan dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mauliaisnaini234@gmail.com

PROFIL PENULIS



Yuliati, SKp., MM., M.Kep.M., Penulis Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia. lulus pada tahun 1997. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Institut Magister Manajemen Indonesia lulus pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan Di Universitas Indoinesia lulus pada tahun 2015. Kandidat PhD di University Malaysiua Sabah (UMS). Sejak tahun 2006 penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen keperawatan dan saat ini penulis aktif mengajar di Program Studi Ilmu Keperawatan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, jakarta. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email yuliati@esaunggul.ac.id. Pesan untuk para pembaca: Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mempelajari materi tentang *Kolaborasi Tim Kesehatan dalam Pelayanan Berkualitas*. Materi ini disusun untuk membantu tenaga kesehatan, mahasiswa, dan praktisi memahami bahwa pelayanan kesehatan yang bermutu tidak dapat dicapai oleh satu profesi saja, tetapi melalui kerja sama yang kuat, saling menghargai, dan komunikasi efektif antar seluruh anggota tim. Di tengah tantangan layanan kesehatan yang semakin kompleks, kolaborasi interprofesional bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan. Setiap profesi memiliki kompetensi, perspektif, dan kontribusi unik yang jika digabungkan akan menghasilkan asuhan yang lebih aman, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih berpusat pada pasien. Meningkatkan kemampuan komunikasi, koordinasi, dan kepemimpinan dalam praktik sehari-hari. Mengaplikasikan prinsip kolaborasi dalam berbagai situasi klinis, komunitas, edukasi, maupun manajerial. Terinspirasi untuk terus belajar, karena kolaborasi adalah keterampilan yang terus berkembang seiring pengalaman dan kompleksitas pelayanan. Akhirnya, semoga materi ini dapat menjadi panduan praktis yang membantu Anda memberikan pelayanan terbaik bagi pasien dan keluarga, serta memperkuat budaya kerja sama di lingkungan kerja Anda. Teruslah berkolaborasi. Karena pelayanan berkualitas lahir dari tim kesehatan yang bersatu.

Motto: "*Living Your Life Well: Inspire, Grow, and Make a Difference.*"

PROFIL PENULIS



Suriani, S.Si., M.Kes., lahir di Banda Aceh 07 September 1968. Setelah menyelesaikan sekolah tingkat pertama (1985) melanjutkan Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) Banda Aceh (1988). Pada Tahun 1990 bekerja di Laboratorium Klinik RSUZA Banda Aceh sambil melanjutkan Studi di Universitas Muhammadiyah Aceh Fakultas MIPA jurusan Biologi (1995). Tahun 2000 tugas belajar di Ilmu Kesehatan Masyarakat minat Magister Manajemen Rumah Sakit pada Universitas Gadjah Mada. Setelah menyelesaikan studi pasca sarjana (2002) pernah menjadi staf mobilisasi dana, Kepala Subbid Akuntansi Manajemen, Kepala Subbid Akuntansi Keuangan, Kepala Subbid Non Medis di RSUZA sampai 2014. Tahun (2015-2019) dimutasi ke Bidang Pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dan tahun 2020 sampai sekarang menjadi dosen di STIKES Muhammadiyah Aceh pada prodi Administrasi Rumah Sakit.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan kegiatan akademik serta kemahasiswaan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: suriani.id2020@gmail.com



Ns. Ita Pursitasari, Mkep.Sp.Kep.An., Lahir di Kota Garut (Jawa Barat), 23 September 1979. Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Wanaraja 1 (1985-1991), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Garut (1991-1994), Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN1 Garut (1994-1997). Memulai karir sebagai seorang perawat sejak lulus dari Akademi Keperawatan Depkes Bandung tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan profesi Ners di Universitas

Padjadjaran Fakultas Keperawatan lulus tahun 2007. Karir sebagai seorang perawat pelaksana dimulai sebagai seorang perawat pelaksana di Ruang ICU Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung (2001-2010), kemudian melanjutkan karir di ruang High Care Unit Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung (2010-2015). Sejak tahun 2015 sampai sekarang aktif sebagai dosen keperawatan anak di Poltekkes Bandung Prodi Keperawatan Bogor. Tahun 2017 melanjutkan kuliah Magister dan Spesialis Keperawatan Anak di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2020.

Sinopsis

Bunga rampai "Kontribusi Tenaga Kesehatan dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas" menghadirkan rangkaian tulisan yang menyoroti peran strategis berbagai profesi kesehatan dalam membangun layanan yang bermutu, aman, efektif, berkesinambungan, dan berpusat pada pasien serta komunitas. Buku ini menegaskan bahwa mutu pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan fasilitas, tetapi terutama oleh kompetensi, kolaborasi, dan komitmen tenaga kesehatan dalam menerapkan standar praktik terbaik di setiap lini pelayanan.

Pembahasan diawali dengan konsep pelayanan kesehatan berkualitas dalam sistem kesehatan, mencakup prinsip mutu, dimensi kualitas layanan, serta keterkaitannya dengan tata kelola, kebijakan, dan budaya organisasi. Selanjutnya, buku ini menguraikan peran kebidanan dalam memastikan kualitas layanan pada kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan woman-centered care, edukasi, pencegahan risiko, deteksi dini komplikasi, dan pendampingan keluarga.

Kontribusi profesi lain dibahas secara mendalam. Keperawatan ditampilkan sebagai garda terdepan dalam menjaga mutu dan keselamatan pasien, mulai dari penerapan patient safety, pencegahan kejadian tidak diinginkan, komunikasi terapeutik, hingga penguatan asuhan berbasis bukti. Sementara itu, bab tentang gizi menekankan pentingnya asuhan gizi terintegrasi dalam meningkatkan status kesehatan pasien, mempercepat pemulihan, dan menurunkan risiko komplikasi melalui penatalaksanaan diet yang tepat serta pemantauan status gizi yang berkelanjutan.

Pada lingkup yang lebih luas, buku ini menyoroti peran tenaga kesehatan masyarakat dalam menjaga mutu layanan berbasis komunitas melalui promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pemberdayaan masyarakat, dan pendekatan yang responsif terhadap konteks sosial budaya. Untuk memastikan mutu berjalan konsisten, buku ini juga mengangkat pentingnya kolaborasi tim kesehatan (health care team collaboration in quality healthcare delivery), yaitu kerja sama lintas profesi yang efektif melalui komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang saling mendukung demi hasil layanan yang optimal.

Buku ini turut membahas evaluasi mutu pelayanan di fasilitas kesehatan, meliputi indikator mutu, audit klinis, survei kepuasan, pelaporan insiden keselamatan, serta perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement). Sebagai penutup, dipaparkan berbagai tantangan dan strategi peningkatan mutu, seperti keterbatasan sumber daya, variasi kompetensi, beban kerja, kepatuhan standar, hingga tantangan manajemen perubahan, disertai rekomendasi langkah strategis untuk memperkuat mutu secara sistematis dan berkelanjutan.

Dengan bahasa yang jelas dan topik yang relevan, bunga rampai ini diharapkan menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, praktisi, pengelola fasilitas kesehatan, serta siapa pun yang berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, aman, dan humanis.

Bunga rampai “Kontribusi Tenaga Kesehatan dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas” menghadirkan rangkaian tulisan yang menyoroti peran strategis berbagai profesi kesehatan dalam membangun layanan yang bermutu, aman, efektif, berkesinambungan, dan berpusat pada pasien serta komunitas. Buku ini menegaskan bahwa mutu pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan fasilitas, tetapi terutama oleh kompetensi, kolaborasi, dan komitmen tenaga kesehatan dalam menerapkan standar praktik terbaik di setiap lini pelayanan.

Pembahasan diawali dengan konsep pelayanan kesehatan berkualitas dalam sistem kesehatan, mencakup prinsip mutu, dimensi kualitas layanan, serta keterkaitannya dengan tata kelola, kebijakan, dan budaya organisasi. Selanjutnya, buku ini menguraikan peran kebidanan dalam memastikan kualitas layanan pada kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan woman-centered care, edukasi, pencegahan risiko, deteksi dini komplikasi, dan pendampingan keluarga.

Kontribusi profesi lain dibahas secara mendalam. Keperawatan ditampilkan sebagai garda terdepan dalam menjaga mutu dan keselamatan pasien, mulai dari penerapan patient safety, pencegahan kejadian tidak diinginkan, komunikasi terapeutik, hingga penguatan asuhan berbasis bukti. Sementara itu, bab tentang gizi menekankan pentingnya asuhan gizi terintegrasi dalam meningkatkan status kesehatan pasien, mempercepat pemulihan, dan menurunkan risiko komplikasi melalui penatalaksanaan diet yang tepat serta pemantauan status gizi yang berkelanjutan.

Pada lingkup yang lebih luas, buku ini menyoroti peran tenaga kesehatan masyarakat dalam menjaga mutu layanan berbasis komunitas melalui promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pemberdayaan masyarakat, dan pendekatan yang responsif terhadap konteks sosial budaya. Untuk memastikan mutu berjalan konsisten, buku ini juga mengangkat pentingnya kolaborasi tim kesehatan (health care team collaboration in quality healthcare delivery), yaitu kerja sama lintas profesi yang efektif melalui komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang saling mendukung demi hasil layanan yang optimal.

Buku ini turut membahas evaluasi mutu pelayanan di fasilitas kesehatan, meliputi indikator mutu, audit klinis, survei kepuasan, pelaporan insiden keselamatan, serta perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement). Sebagai penutup, dipaparkan berbagai tantangan dan strategi peningkatan mutu, seperti keterbatasan sumber daya, variasi kompetensi, beban kerja, kepatuhan standar, hingga tantangan manajemen perubahan, disertai rekomendasi langkah strategis untuk memperkuat mutu secara sistematis dan berkelanjutan.

Dengan bahasa yang jelas dan topik yang relevan, bunga rampai ini diharapkan menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, praktisi, pengelola fasilitas kesehatan, serta siapa pun yang berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, aman, dan humanis.

ISBN 978-634-7556-70-7



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

